UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO
FACULTAD DE HUMANIDADES · CARRERA DE PSICOLOGÍA

Revista Académica de Psicología

Territorio de la Palabra

Volumen 1 · Número 1 · 2026

SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA



Ñe Renda — Territorio de la Palabra
Revista Académica de Psicología
Vol. 1, N.º 1 · 2026

INSTITUCIÓN EDITORA

Carrera de Psicología · Facultad de Humanidades
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

Rector: Dr. Reinerio Vargas Banegas
Decana de la Facultad de Humanidades: MSc. Mariela Castro Suarez
Directora de la Carrera de Psicología: MSc. Nilda Céspedes Robles

EQUIPO EDITORIAL

Editor científico: MSc. Joel Challa Pérez
Coordinación de investigación: MSc. María Fátima Escobar

DATOS DE LA PUBLICACIÓN

Normas de publicación: APA, 7.ª edición
ISSN impreso y en línea: en trámite.

ENFOQUE Y ALCANCE

Ñe Renda — Territorio de la Palabra es la revista académica de la Carrera de Psicología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Publica investigación original, revisiones, estudios de caso y ensayos que amplían la comprensión de la psicología en Bolivia y la región, con revisión por pares doble ciego.

Los contenidos se publican en acceso abierto bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Las opiniones expresadas en los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores y no comprometen a la institución editora. Se permite la reproducción total o parcial de los contenidos citando la fuente, en los términos de la licencia.

Ñe Renda
Territorios de la Palabra
REVISTA ACADÉMICA DE PSICOLOGÍA
CARRERA DE PSICOLOGÍA · UAGRM
SANTA CRUZ DE LA SIERRA · BOLIVIA

SOBRE EL NOMBRE

Ñe Renda

El territorio de la palabra

Ñe Renda (guaraní): el lugar o la casa de la palabra. De *ñe'ẽ*, palabra, y *renda*, lugar.

Hay nombres que se eligen por estética o por significado. Cuando decidimos bautizar nuestra revista científica como *Ñe Renda*, no buscamos un título: queríamos encontrar los significados de nuestro campo de estudio, la palabra, pero la palabra situada en nuestro contexto e historia.

Ñe Renda es una expresión de la lengua guaraní, la cultura indígena que habita en el Chaco cruceño y que ha resistido los vientos de la historia. Su significado es profundo y luminoso: el lugar, o la casa, de la palabra. Es el espacio donde la palabra no solo se pronuncia, sino que se habita. Donde el verbo se vuelve refugio y una forma de estar en el mundo.

En la tradición guaraní, la palabra, el *ñe'ẽ*, es mucho más que un instrumento de comunicación. Es el aliento del alma, el puente entre los vivos y los ancestros, la fuerza que nombra el mundo y lo hace existir. Sin palabra, el mundo sería un silencio sin forma. Con *ñe'ẽ*, el ser se vuelve territorio, se vuelve casa, cuerpo y ser.

En la psicología, la palabra es también el territorio fundamental. Freud descubrió que el inconsciente habla a través de las palabras que se nos escapan, de los lapsus, de los sueños. Lacan sostuvo que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, que somos habitados por la palabra del Otro.

Dewey y Vygotski nos enseñaron que el pensamiento se construye en la interacción social, en el diálogo, en esa zona de desarrollo próximo que solo se activa cuando alguien nos habla y nos escucha.

La psicología, desde sus orígenes, se ha fundado en la palabra. No hay clínica sin escucha. No hay diagnóstico sin relato. No hay intervención sin diálogo. El psicólogo es, en esencia, un habitante de *Ñe Renda*: alguien que escucha, que nombra, que sostiene el espacio donde el otro puede decir su verdad.

Ñe Renda es, entonces, un homenaje. A la cultura guaraní, que nos enseña que la palabra es un lugar y un ser que existe. A los grandes pensadores que fundaron la psicología sobre el diálogo. Y a nuestros estudiantes y docentes, que cada día construyen con sus investigaciones ese territorio donde la palabra se vuelve ciencia, y la ciencia se vuelve palabra que transforma.

Bienvenidos a Ñe Renda, el territorio de la palabra, el hogar donde la psicología se piensa, se comparte y se hace.

Contenido

VOL. 1 · N.° 1 · 2026

PRESENTACIÓN

Presentación 6

DOCENTES INVESTIGADORES

Sintomatología de estrés, ansiedad y depresión en una muestra de población adulta de Santa Cruz de la Sierra: estudio descriptivo exploratorio 7
Regina Ninoska Ocampo Barba · Artículo de investigación

Rediseño curricular por competencias en la Carrera de Psicología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno: análisis documental del tránsito del Plan 148-1 al Plan 148-2 20
Wilma Forest Herrera · Artículo de investigación

La flexibilidad y el movimiento pendular del sujeto en el discurso contemporáneo 31
María Fátima Escobar · Ensayo

Método comparativo de enfoques psicoterapéuticos basado en experiencias vivenciales grupales: Psicodrama y Psicoterapia Positiva 41
Teresa Baldiviezo Álvarez · Artículo metodológico

ESTUDIANTES

Estrés laboral en fuerzas del orden: dimensiones organizacionales y lectura sistémica en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 55
Rafael Mauricio Ribera Jiménez · Artículo de investigación

Aquiescencia en autoinformes infantiles y límites de la inferencia proyectiva: estudio de caso único 69
Carlos Raúl Lara Aguilar · Estudio de caso

Procesos atencionales y de memoria en una niña con indicadores de inatención: estudio de caso 79
Gabriela Rosales · Estudio de caso

Dificultades en habilidades preacadémicas y de lectoescritura en una niña sin escolarización inicial: reporte clínico de caso 88
Natalia Gabriela Montaño López · Estudio de caso

Territorio de la Palabra
REVISTA ACADÉMICA DE PSICOLOGÍA
CARRERA DE PSICOLOGÍA · UAGRM
SANTA CRUZ DE LA SIERRA · BOLIVIA

Vol. 1, N.° 1 (2026) · pp. 6–6
CC BY-NC 4.0

PRESENTACIÓN

Presentación

La Carrera de Psicología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno presenta el primer número de la *Revista Académica de Psicología*, un espacio destinado a difundir la producción científica de docentes, investigadores y estudiantes, y a fortalecer la cultura de investigación en la formación de psicólogos en Santa Cruz de la Sierra y en Bolivia.

Este número reúne ocho trabajos organizados en dos partes. La primera presenta la producción de docentes investigadores de la Carrera: un estudio descriptivo sobre la sintomatología de estrés, ansiedad y depresión en población adulta cruceña; un análisis documental del rediseño curricular por competencias de la Carrera de Psicología de la UAGRM, en el tránsito del Plan 148-1 al Plan 148-2; un ensayo que propone una lectura psicoanalítica de la flexibilidad como imperativo del discurso contemporáneo, y un artículo metodológico que plantea un método comparativo entre el Psicodrama y la Psicoterapia Positiva a partir de experiencias vivenciales grupales. La segunda parte reúne trabajos de estudiantes: un análisis del estrés laboral en integrantes de las fuerzas del orden y tres estudios de caso en psicología infantil, que abordan la aquiescencia en los autoinformes, los procesos atencionales y de memoria, y las dificultades preacadémicas asociadas a la falta de escolarización inicial.

Todos los trabajos se presentan conforme a las normas APA, 7.ª edición, y han sido objeto de revisión editorial. Agradecemos a los autores su contribución e invitamos a la comunidad académica a sumarse a este proyecto con sus investigaciones.

Editorial

Neuenda Territorio de la Palabra
REVISTA ACADÉMICA DE PSICOLOGÍA
CARRERA DE PSICOLOGÍA · UAGRM
SANTA CRUZ DE LA SIERRA · BOLIVIA

Vol. 1, N.º 1 (2026) · pp. 7–19
CC BY-NC 4.0

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN · DOCENTES INVESTIGADORES

Sintomatología de estrés, ansiedad y depresión en una muestra de población adulta de Santa Cruz de la Sierra: estudio descriptivo exploratorio

Stress, anxiety, and depression symptoms in a sample of adults from Santa Cruz de la Sierra: A descriptive exploratory study

Regina Ninoska Ocampo Barba[1*]

[1] Carrera de Psicología, Facultad de Humanidades, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
* Correspondencia: regina.ocampo@uagrm.com.bo

RESUMEN

Objetivo. Describir la frecuencia y los niveles de gravedad de la sintomatología de estrés, ansiedad y depresión en una muestra de adultos de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y explorar diferencias según sexo y grupo etario. Método. Estudio transversal descriptivo-exploratorio con muestreo no probabilístico por conveniencia en una campaña comunitaria de salud mental. De 1026 personas reclutadas, la muestra final fue de 746 adultos de 18 a 90 años; 712 completaron la Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21). Se calcularon frecuencias, intervalos de confianza al 95 % por el método de Wilson y pruebas de chi-cuadrado con V de Cramér. Resultados. El 60,11 % de los participantes presentó puntuaciones de ansiedad por encima del rango normal, el 53,37 % de depresión y el 29,92 % de estrés; el 47,19 % alcanzó niveles de ansiedad moderados o superiores. La gravedad de la ansiedad se asoció con el sexo (mayor en mujeres; V = ,15), pero no la de la depresión ni la del estrés. El grupo de 18 a 25 años presentó mayor gravedad que el de 26 a 59 años en ansiedad y depresión (V = ,18 y ,16) y, en menor medida, en estrés (V = ,09). Conclusiones. En esta muestra de voluntarios, con predominio de mujeres y jóvenes, la ansiedad fue la sintomatología más frecuente y grave. Los resultados no son generalizables y deben contrastarse con diseños probabilísticos; orientan, de forma preliminar, estrategias preventivas para jóvenes y mujeres.

Palabras clave: ansiedad; depresión; estrés psicológico; DASS-21; salud mental comunitaria

ABSTRACT

Objective. To describe the frequency and severity of stress, anxiety, and depression symptoms in a sample of adults from Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, and to explore differences by sex

and age group. Method. Cross-sectional descriptive-exploratory study with non-probability convenience sampling in a community mental health campaign. Of 1,026 recruited individuals, the final sample comprised 746 adults aged 18 to 90 years; 712 completed the Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21). Frequencies, 95 % Wilson confidence intervals, and chi-square tests with Cramér's V were computed. Results. Overall, 60.11 % of participants scored above the normal range for anxiety, 53.37 % for depression, and 29.92 % for stress; 47.19 % reached moderate or higher anxiety levels. Anxiety severity was associated with sex (higher in women; V = .15), whereas depression and stress severity were not. Participants aged 18 to 25 showed greater severity than those aged 26 to 59 in anxiety and depression (V = .18 and .16) and, to a lesser extent, in stress (V = .09). Conclusions. In this volunteer sample, predominantly composed of women and young people, anxiety was the most frequent and severe symptom dimension. Results cannot be generalized and should be tested with probabilistic designs; they provide preliminary guidance for preventive strategies for young people and women.

Keywords: anxiety; depression; psychological stress; DASS-21; community mental health

RECIBIDO
16 de julio de 2026

ACEPTADO
2 de octubre de 2026

PUBLICADO
30 de noviembre de 2026

CÓMO CITAR (APA 7)
Ocampo Barba, R. N. (2026). Sintomatología de estrés, ansiedad y depresión en una muestra de población adulta de Santa Cruz de la Sierra: estudio descriptivo exploratorio. *Ñe Renda. Territorio de la Palabra, 1*(1), 7–19.

INTRODUCCIÓN

La salud mental constituye uno de los principales desafíos de salud pública a nivel mundial, por el incremento sostenido de los trastornos emocionales y su impacto sobre la calidad de vida, el desempeño académico y laboral y el funcionamiento social de las personas. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2025) estima que aproximadamente una de cada ocho personas en el mundo vive con un trastorno mental, y que los trastornos de ansiedad y depresivos son los más frecuentes: alrededor de 301 millones de personas presentan trastornos de ansiedad y 280 millones viven con depresión, una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. En América Latina, la revisión sistemática y metaanálisis de Errazuriz et al. (2023) documentó una prevalencia elevada de trastornos depresivos en la población adulta de la región, lo que pone de relieve la necesidad de sistemas de vigilancia que permitan conocer la magnitud de estas condiciones en contextos específicos.

Desde la neuropsicología contemporánea, existe amplia evidencia de que el estrés, la ansiedad y la depresión comparten mecanismos neurofuncionales relacionados con la regulación emocional, el control ejecutivo y la adaptación al entorno. Estas condiciones se asocian con alteraciones funcionales en los circuitos frontolímbicos, particularmente en la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza cingu-

lada anterior, la amígdala y el hipocampo, estructuras implicadas en la regulación de las emociones, la memoria, la atención y la toma de decisiones (Etkin et al., 2015; Ochsner et al., 2012; Pessoa, 2017).

Desde la neuropsicología de la regulación emocional, se ha propuesto que el malestar emocional sostenido refleja una desregulación en los sistemas frontolímbicos que subyacen al control cognitivo y a la respuesta afectiva (Etkin et al., 2015; Ochsner et al., 2012). La corteza prefrontal dorsolateral ejerce un papel modulador sobre estructuras subcorticales como la amígdala, el hipocampo y el estriado ventral, lo que permite la regulación de las emociones, la reevaluación cognitiva y la inhibición de respuestas automáticas ante estímulos amenazantes (Pessoa, 2017). Cuando este control descendente se ve comprometido —por estrés crónico, factores genéticos o experiencias adversas tempranas—, se produce una hiperreactividad amigdalina y una disminución de la conectividad funcional prefrontal que facilitan la aparición de síntomas ansiosos, depresivos y de tensión psicofisiológica (Arnsten, 2009; Etkin et al., 2015). El estrés prolongado activa, además, el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, eleva los niveles de cortisol y altera la plasticidad sináptica en regiones como el hipocampo, con efectos sobre la memoria, la atención y la regulación emocional (McEwen, 2017).

A partir de esta evidencia, la autora propone el Proceso de Desregulación Neuropsicológica (PDN) como marco conceptual exploratorio para comprender la interacción entre estrés, ansiedad y depresión. El PDN se fundamenta en dos postulados. El primero plantea que estas tres condiciones no son fenómenos independientes, sino manifestaciones interrelacionadas de un proceso progresivo de desregulación de los mecanismos responsables de la regulación emocional, el control ejecutivo y la adaptación al estrés, en coherencia con la evidencia de patrones compartidos de hiperreactividad amigdalina, disminución del control inhibitorio prefrontal y alteraciones de la conectividad frontolímbica (Etkin et al., 2015; Pessoa, 2017). El segundo sostiene que las manifestaciones subjetivas de estrés, ansiedad y depresión podrían funcionar como indicadores tempranos de ese proceso e identificarse mediante instrumentos estandarizados antes del establecimiento de trastornos clínicamente diagnosticables, en consonancia con las recomendaciones de la OMS (2025) sobre prevención y atención temprana. El PDN es un modelo teórico en desarrollo y no un constructo validado: el presente estudio no mide indicadores neurofuncionales ni pone a prueba sus postulados, por lo que el modelo se emplea aquí solo como marco interpretativo y sus implicaciones deben entenderse como hipótesis.

La Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés de 21 ítems (DASS-21) ha mostrado propiedades psicométricas adecuadas en muestras clínicas y comunitarias, con coeficientes de consistencia interna superiores a 0,80 (Antony et al., 1998; Lovibond y Lovibond, 1995), lo que la hace útil para estudios descriptivos y comunita-

rios. En el presente estudio se emplea para identificar manifestaciones subjetivas de estrés, ansiedad y depresión, sin que ello constituya un diagnóstico clínico ni neuropsicológico.

En Bolivia, y particularmente en Santa Cruz de la Sierra, la información sobre sintomatología emocional en población general es limitada, y la ausencia de registros sistemáticos dificulta la planificación de intervenciones basadas en evidencia (Aguilar, 2013). Disponer de información local, aunque sea de alcance descriptivo y con limitaciones muestrales, constituye un insumo para orientar programas preventivos y futuras investigaciones.

En respuesta a esta necesidad, el presente estudio tuvo como objetivo describir la frecuencia y los niveles de gravedad de la sintomatología de estrés, ansiedad y depresión en una muestra de población adulta de Santa Cruz de la Sierra, y explorar diferencias según sexo y grupo etario. El diseño transversal y el muestreo no probabilístico limitan la generalización de los resultados; se espera que esta aproximación exploratoria oriente investigaciones posteriores con diseños más sólidos.

MÉTODO

Diseño

El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, transversal y de alcance descriptivo-exploratorio (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2023). Según la clasificación de Ato et al. (2013), corresponde a un estudio descriptivo mediante encuesta de tipo transversal. Las variables se observaron sin manipulación, la información se recolectó en un único momento y el propósito fue caracterizar la frecuencia y la distribución de la sintomatología en la muestra, sin establecer relaciones causales. Aunque se enmarca en un contexto comunitario, el estudio no cumple los requisitos de un tamizaje poblacional, que exige muestreo probabilístico y representatividad, por lo que sus resultados describen únicamente a la muestra evaluada.

Participantes

La población de referencia estuvo constituida por personas adultas residentes en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que participaron voluntariamente en una campaña comunitaria de salud mental organizada por el Instituto de Neurociencias Comportamentales (INCC) durante la gestión 2025. La muestra se seleccionó mediante muestreo no probabilístico por conveniencia e incorporó a todas las personas que aceptaron participar y cumplieron los criterios de inclusión: edad igual o mayor a 18 años, residencia en Santa Cruz de la Sierra y firma del consentimiento informado. Se excluyó a quienes rechazaron o retiraron el consentimiento y a

quienes no podían responder el instrumento por limitaciones cognitivas, sensoriales o lingüísticas.

Inicialmente se reclutaron 1026 personas mediante convocatoria abierta. Tras la depuración de la base de datos se excluyeron 280 registros por cuestionarios incompletos (más del 10 % de ítems omitidos), patrones de respuesta inconsistentes (por ejemplo, marcación uniforme), duplicados, incumplimiento de los criterios de elegibilidad, ausencia de consentimiento informado o errores de digitación no verificables. La muestra final quedó constituida por 746 participantes, de 18 a 90 años, cuya composición se presenta en la Tabla 1. De ellos, 34 (4,56 %) no tenían respuestas registradas en la DASS-21, por lo que los análisis de sintomatología se basan en 712 participantes.

Tabla 1

Características sociodemográficas de la muestra

Variable	Categoría	*n*	%
Sexo	Femenino	486	65,15
	Masculino	247	33,11
	Prefiere no decirlo	13	1,74
Grupo etario	18 a 25 años	517	69,30
	26 a 59 años	215	28,82
	60 años o más	14	1,88

Nota. N = 746. Rango de edad: 18 a 90 años.

La muestra presenta una sobrerrepresentación de mujeres y de personas jóvenes, lo que limita su representatividad y debe considerarse al interpretar los resultados.

Instrumento

Se utilizó la Depression Anxiety Stress Scales de 21 ítems (DASS-21), versión abreviada de la DASS-42 desarrollada por Lovibond y Lovibond (1995). Es un autoinforme que evalúa la frecuencia e intensidad de síntomas emocionales experimentados durante la última semana mediante tres subescalas de siete ítems: estrés (tensión, irritabilidad, dificultad para relajarse), ansiedad (activación autonómica, miedo, pánico) y depresión (anhedonia, ánimo bajo, desesperanza, baja autoestima). Cada ítem se responde en una escala de cuatro opciones, de 0 (*no me aplicó en absoluto*) a 3 (*me aplicó mucho o la mayor parte del tiempo*).

Tabla 2

Puntos de corte de la DASS-21 por nivel de gravedad

Nivel	Estrés	Ansiedad	Depresión
Normal	0–14	0–7	0–9
Leve	15–18	8–9	10–13

Nivel	Estrés	Ansiedad	Depresión
Moderado	19–25	10–14	14–20
Severo	26–33	15–19	21–27
Extremadamente severo	≥ 34	≥ 20	≥ 28

Nota. Adaptado de Lovibond y Lovibond (1995). Las puntuaciones corresponden a la suma de cada subescala multiplicada por dos.

Procedimiento

El estudio se desarrolló en cuatro etapas. En la primera se elaboró el protocolo (diseño, criterios de selección, instrumento, procedimiento y plan de análisis), se organizó la campaña comunitaria y se capacitó al equipo evaluador del INCC en los objetivos del estudio, la administración estandarizada de la DASS-21, los principios éticos y el registro de la información. En la segunda se realizó la convocatoria abierta, se informó a los participantes sobre los objetivos, el carácter voluntario, la confidencialidad y el uso científico de la información, se obtuvo su consentimiento informado por escrito y se aplicó, de forma presencial y autoadministrada bajo supervisión, una ficha sociodemográfica y la DASS-21. En la tercera se registraron y codificaron los datos y se depuró la base de datos con los criterios señalados. En la cuarta se realizaron los análisis estadísticos y la interpretación de los resultados.

Análisis de datos

Los datos se procesaron con SPSS versión 26 y Microsoft Excel. Se calculó el coeficiente alfa de Cronbach para la escala global y para cada subescala; la muestra se describió mediante frecuencias y porcentajes. Para cada subescala se calculó la frecuencia de sintomatología positiva (puntuación superior al rango normal) con su intervalo de confianza al 95 % por el método de Wilson (Newcombe, 1998), y se describió la distribución por niveles de gravedad. La asociación entre la gravedad y las variables sexo y grupo etario se exploró mediante la prueba de chi-cuadrado de Pearson, con V de Cramér como tamaño del efecto y $\alpha = ,05$. Para cumplir el supuesto de frecuencias esperadas suficientes (Field, 2018), los análisis por sexo se limitaron a mujeres y varones (se excluyó la categoría “prefiere no decirlo”, $n = 13$) y los análisis por edad compararon los grupos de 18 a 25 y de 26 a 59 años (se excluyó el grupo de 60 años o más, $n = 14$, que se describe solo de forma descriptiva).

Consideraciones éticas

La investigación se rigió por los principios de la Declaración de Helsinki (Asociación Médica Mundial, 2013) y la normativa boliviana sobre investigación con seres humanos. Todos los participantes otorgaron su consentimiento informado por escrito; la participación fue voluntaria, con posibilidad de retiro en cualquier momento, y los datos se anonimizaron y almacenaron con acceso restringido al equi-

po investigador. Se ofreció a los participantes información sobre sus resultados y orientación para la derivación a servicios de salud mental cuando se identificaron niveles de gravedad clínica, y se dispuso de un protocolo de contención para atender la incomodidad emocional que pudiera surgir al responder. Tambien cabe mencionar que no existe financiamiento externo para la investigacion, al igual que no existe conflicto de intereses de parte del autor al respecto. Sobre la metodologia y analisis fue realizado de manera individual por el autor.

RESULTADOS

Frecuencia de sintomatología

La Tabla 3 presenta la frecuencia de participantes con puntuaciones superiores al rango normal en cada subescala y la distribución por niveles de gravedad. La ansiedad fue la dimensión con mayor frecuencia de sintomatología positiva, presente en seis de cada diez participantes, seguida por la depresión y el estrés. La ansiedad concentró también la mayor proporción de casos en niveles moderados o superiores (47,19 %; IC 95 % [43,55; 50,86]), frente al 28,93 % en depresión (IC 95 % [25,72; 32,37]) y el 8,57 % en estrés (IC 95 % [6,73; 10,85]). No se registraron niveles severos ni extremadamente severos de estrés, ni niveles extremadamente severos de depresión.

Tabla 3

Frecuencia de sintomatología positiva y distribución por niveles de gravedad en la DASS-21

Indicador	Estrés *n* (%)	Ansiedad *n* (%)	Depresión *n* (%)
Normal	499 (70,08)	284 (39,89)	332 (46,63)
Leve	152 (21,35)	92 (12,92)	174 (24,44)
Moderado	61 (8,57)	215 (30,20)	181 (25,42)
Severo	0 (0,00)	97 (13,62)	25 (3,51)
Extremadamente severo	0 (0,00)	24 (3,37)	0 (0,00)
Sintomatología positiva	213 (29,92)	428 (60,11)	380 (53,37)
IC 95 % de la sintomatología positiva	[26,67; 33,38]	[56,47; 63,65]	[49,70; 57,01]

Nota. n = 712 participantes con respuestas válidas en la DASS-21 (34 sin respuesta). Sintomatología positiva = puntuación superior al rango normal. IC 95 % calculado por el método de Wilson. Porcentajes calculados sobre los 712 casos válidos.

Diferencias según sexo

La Tabla 4 presenta la distribución de la gravedad según sexo. En estrés, la proporción en el rango normal fue similar en mujeres (68,14 %) y varones (73,28 %). En ansiedad, solo el 35,18 % de las mujeres se situó en el rango normal, frente al 48,99 % de los varones, y las mujeres presentaron mayores proporciones en los niveles moderado (32,96 % frente a 25,10 %), severo (14,60 % frente a 10,53 %) y extrema-

damente severo (4,42 % frente a 1,62 %). En depresión, el 44,69 % de las mujeres y el 51,82 % de los varones se situaron en el rango normal.

Tabla 4

Distribución de los niveles de gravedad de la DASS-21 según sexo

Dimensión y nivel	Mujeres *n* (%)	Varones *n* (%)
Estrés		
Normal	308 (68,14)	181 (73,28)
Leve	104 (23,01)	46 (18,62)
Moderado	40 (8,85)	20 (8,10)
Ansiedad		
Normal	159 (35,18)	121 (48,99)
Leve	58 (12,83)	34 (13,77)
Moderado	149 (32,96)	62 (25,10)
Severo	66 (14,60)	26 (10,53)
Extremadamente severo	20 (4,42)	4 (1,62)
Depresión		
Normal	202 (44,69)	128 (51,82)
Leve	115 (25,44)	57 (23,08)
Moderado	121 (26,77)	53 (21,46)
Severo	14 (3,10)	9 (3,64)

Nota. Mujeres con respuestas válidas, $n = 452$; varones, $n = 247$. Los 34 registros sin respuesta correspondían a mujeres. Se omite la categoría "prefiere no decirlo" ($n = 13$) y los niveles sin casos.

Diferencias según grupo etario

El grupo de 18 a 25 años presentó las mayores proporciones de sintomatología en las tres dimensiones (Tabla 5). En ansiedad, el 34,70 % de los jóvenes se situó en el rango normal, frente al 50,71 % del grupo de 26 a 59 años, y los niveles severo y extremadamente severo fueron más frecuentes en los jóvenes (15,20 % y 4,31 %). En depresión, la proporción en el rango normal fue del 41,27 % en jóvenes y del 57,82 % en el grupo de 26 a 59 años. En estrés, el rango normal agrupó al 67,56 % de los jóvenes y al 76,78 % del grupo de 26 a 59 años. El grupo de 60 años o más ($n = 14$) se describe solo a título informativo: ocho de sus integrantes se situaron en el rango normal de estrés y de ansiedad, y nueve en el de depresión.

Tabla 5

Distribución de los niveles de gravedad de la DASS-21 según grupo etario

Dimensión y nivel	18 a 25 años *n* (%)	26 a 59 años *n* (%)	60 años o más *n*
Estrés			
Normal	329 (67,56)	162 (76,78)	8
Leve	110 (22,59)	36 (17,06)	6
Moderado	48 (9,86)	13 (6,16)	0

Dimensión y nivel	18 a 25 años *n* (%)	26 a 59 años *n* (%)	60 años o más *n*
Ansiedad			
Normal	169 (34,70)	107 (50,71)	8
Leve	59 (12,11)	31 (14,69)	2
Moderado	164 (33,68)	48 (22,75)	3
Severo	74 (15,20)	22 (10,43)	1
Extremadamente severo	21 (4,31)	3 (1,42)	0
Depresión			
Normal	201 (41,27)	122 (57,82)	9
Leve	132 (27,10)	39 (18,48)	3
Moderado	133 (27,31)	47 (22,27)	1
Severo	21 (4,31)	3 (1,42)	1

Nota. Respuestas válidas: 18 a 25 años, $n = 487$; 26 a 59 años, $n = 211$; 60 años o más, $n = 14$. Por el tamaño reducido del grupo de 60 años o más no se calculan porcentajes.

Análisis de asociación

La Tabla 6 resume las pruebas de chi-cuadrado. La gravedad de la ansiedad se asoció significativamente con el sexo, con un tamaño del efecto pequeño; la de la depresión y la del estrés, no. Según el grupo etario, la gravedad de la ansiedad y de la depresión se asoció significativamente con la edad, con tamaños del efecto pequeños, y la del estrés mostró una asociación significativa de magnitud muy pequeña.

Tabla 6

Pruebas de chi-cuadrado entre los niveles de gravedad de la DASS-21, el sexo y el grupo etario

Cruce	χ^2	*gl*	*p*	*V* de Cramér	*n*
Sexo × estrés	2,14	2	,343	,06	699
Sexo × ansiedad	16,66	4	,002	,15	699
Sexo × depresión	4,04	3	,257	,08	699
Grupo etario × estrés	6,23	2	,044	,09	698
Grupo etario × ansiedad	22,10	4	< ,001	,18	698
Grupo etario × depresión	18,20	3	< ,001	,16	698

Nota. Sexo: mujeres y varones. Grupo etario: 18 a 25 y 26 a 59 años. Los valores se calcularon a partir de las frecuencias de las Tablas 4 y 5; ninguna celda tuvo frecuencia esperada inferior a 5.

DISCUSIÓN

El presente estudio se propuso describir la frecuencia y los niveles de gravedad de la sintomatología de estrés, ansiedad y depresión en una muestra de adultos de Santa Cruz de la Sierra y explorar diferencias según sexo y grupo etario. La ansiedad fue la dimensión con mayor frecuencia de sintomatología positiva (60,11 %), seguida por la depresión (53,37 %) y el estrés (29,92 %). Este orden coincide con la literatura que sitúa a la ansiedad entre las manifestaciones psicológicas más frecuentes en población general (Chacón Delgado et al., 2021; OMS, 2022).

Las frecuencias observadas son, sin embargo, considerablemente más altas que las prevalencias de trastornos estimadas en estudios epidemiológicos representativos. La OMS (2022) estima que los trastornos de ansiedad afectan aproximadamente al 4 % de la población mundial y los depresivos a cerca del 3,8 %, y el metaanálisis de Errazuriz et al. (2023) informa prevalencias de trastornos depresivos muy inferiores a las aquí observadas. La discrepancia puede atribuirse a varios factores: (a) la DASS-21 mide sintomatología, incluida la subclínica, y no trastornos diagnosticados; (b) la muestra está compuesta mayoritariamente por jóvenes y mujeres, grupos que en este estudio presentaron mayor gravedad, y (c) el reclutamiento por autoselección en una campaña de salud mental pudo atraer a personas con mayor malestar emocional, lo que sesgaría al alza las estimaciones. Por ello, las cifras no deben interpretarse como prevalencias poblacionales.

Las mujeres presentaron mayor gravedad de ansiedad que los varones, con un tamaño del efecto pequeño (V = ,15). Este patrón es consistente con la mayor prevalencia de trastornos internalizantes en mujeres documentada en la literatura (American Psychiatric Association [APA], 2022). En cambio, las diferencias en depresión y estrés según sexo no fueron estadísticamente significativas en esta muestra. Con la información disponible no es posible distinguir entre las explicaciones biológicas, psicológicas y sociales propuestas para esta diferencia, que no fueron evaluadas.

En cuanto a la edad, el grupo de 18 a 25 años presentó mayor gravedad que el de 26 a 59 años en ansiedad (V = ,18) y en depresión (V = ,16), y una diferencia de magnitud muy pequeña en estrés (V = ,09). Este hallazgo es coherente con los datos de UNICEF (2022) sobre la elevada frecuencia de angustia, depresión y ansiedad en adolescentes bolivianos, y sugiere la necesidad de fortalecer la promoción y la prevención en instituciones educativas y otros espacios comunitarios frecuentados por jóvenes. Las explicaciones habitualmente propuestas —transición a la vida adulta, presión académica y laboral, incertidumbre sobre el futuro— no fueron evaluadas en este estudio. El tamaño reducido del grupo de 60 años o más impide cualquier comparación con ese segmento.

Desde el marco del PDN, la coexistencia de sintomatología ansiosa y depresiva en una misma muestra y su mayor concentración en los grupos más jóvenes son compatibles con la hipótesis de un continuo de desregulación emocional; sin embargo, el diseño no permite contrastar esa hipótesis, porque no se midieron indicadores neurofuncionales ni se examinó la covariación entre subescalas.

Implicaciones teóricas y prácticas

En el plano teórico, el estudio aporta datos descriptivos locales que permiten formular hipótesis contrastables desde el PDN, por ejemplo, sobre la covariación entre las tres subescalas y su relación con medidas de control ejecutivo, en estudios

que incluyan indicadores neuropsicológicos. En el plano práctico, la alta frecuencia de sintomatología ansiosa y depresiva, en su mayor parte en niveles leves y moderados, sugiere la pertinencia de intervenciones preventivas universales y selectivas en espacios comunitarios y educativos, con énfasis en la población joven y, en el caso de la ansiedad, en las mujeres, así como la utilidad de la DASS-21 como instrumento de orientación para la derivación a evaluaciones clínicas.

Limitaciones

Los resultados deben interpretarse a la luz de las siguientes limitaciones: (a) el muestreo no probabilístico por conveniencia y la autoselección de los participantes impiden generalizar los resultados a la población de Santa Cruz de la Sierra; (b) la sobrerrepresentación de jóvenes y mujeres puede haber elevado las estimaciones globales; (c) el diseño transversal impide establecer trayectorias o relaciones causales; (d) el autoinforme está sujeto a sesgos de deseabilidad social, memoria y estado emocional; (e) el contexto de una campaña de salud mental pudo influir en la disposición a participar y en las respuestas, y (f) los análisis por sexo y por edad excluyeron a los grupos con frecuencias insuficientes (“prefiere no decirlo” y 60 años o más), sobre los que no pueden extraerse conclusiones.

CONCLUSIONES

En la muestra evaluada, la ansiedad fue la sintomatología más frecuente (60,11 %), seguida por la depresión (53,37 %) y el estrés (29,92 %), y fue también la que alcanzó mayor gravedad: el 47,19 % de los participantes presentó niveles de ansiedad moderados o superiores.

Las mujeres presentaron mayor gravedad de ansiedad que los varones, mientras que en depresión y estrés no se observaron diferencias significativas según sexo. El grupo de 18 a 25 años presentó mayor gravedad que el de 26 a 59 años en ansiedad y depresión y, en menor medida, en estrés. Todos los tamaños del efecto fueron pequeños.

Estos resultados describen a una muestra de voluntarios con predominio de mujeres y jóvenes y no son generalizables a la población. Constituyen una aproximación inicial que puede orientar investigaciones con muestreo probabilístico y diseños longitudinales, así como el diseño de estrategias preventivas en salud mental dirigidas a la población joven.

En el ámbito de la formación profesional, se recomienda fortalecer la enseñanza de la psicopatología y de la evaluación psicológica con instrumentos estandarizados, como la DASS-21, para la detección temprana y la derivación oportuna en contextos comunitarios.

REFERENCIAS

American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.). https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787

Antony, M. M., Bieling, P. J., Cox, B. J., Enns, M. W., y Swinson, R. P. (1998). Psychometric properties of the 42-item and 21-item versions of the Depression Anxiety Stress Scales in clinical groups and a community sample. *Psychological Assessment*, *10*(2), 176–181. https://doi.org/10.1037/1040-3590.10.2.176

Arnsten, A. F. T. (2009). Stress signalling pathways that impair prefrontal cortex structure and function. *Nature Reviews Neuroscience*, *10*(6), 410–422. https://doi.org/10.1038/nrn2648

Asociación Médica Mundial. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects. *JAMA*, *310*(20), 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053

Ato, M., López-García, J. J., y Benavente, A. (2013). Un sistema de clasificación de los diseños de investigación en psicología. *Anales de Psicología*, *29*(3), 1038–1059. https://doi.org/10.6018/analesps.29.3.178511

Chacón Delgado, E., Xatruch De la Cera, D., Fernández Lara, M., y Murillo Arias, R. (2021). Generalidades sobre el trastorno de ansiedad. *Cúpula, 35*

Errazuriz, A., Avello-Vega, D., Ramirez-Mahaluf, J. P., Torres, R., Crossley, N. A., Undurraga, E. A., y Jones, P. B. (2023). Prevalence of depressive disorder in the adult population of Latin America: A systematic review and meta-analysis. *The Lancet Regional Health – Americas*, *26*, Artículo 100587. https://doi.org/10.1016/j.lana.2023.100587

Etkin, A., Büchel, C., y Gross, J. J. (2015). The neural bases of emotion regulation. *Nature Reviews Neuroscience*, *16*(11), 693–700. https://doi.org/10.1038/nrn4044

Field, A. (2018). *Discovering statistics using IBM SPSS Statistics* (5th ed.). SAGE.

Hernández-Sampieri, R., y Mendoza, C. P. (2023). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*.

Lovibond, S. H., y Lovibond, P. F. (1995). *Manual for the Depression Anxiety Stress Scales* (2nd ed.). Psychology Foundation of Australia.

McEwen, B. S. (2017). Neurobiological and systemic effects of chronic stress. *Chronic Stress*, *1*. https://doi.org/10.1177/2470547017692328

Newcombe, R. G. (1998). Two-sided confidence intervals for the single proportion: Comparison of seven methods. *Statistics in Medicine*, *17*(8), 857–872. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0258(19980430)17:8<857::AID-SIM777>3.0.CO;2-E

Ochsner, K. N., Silvers, J. A., y Buhle, J. T. (2012). Functional imaging studies of emotion regulation: A synthetic review and evolving model of the cognitive control of emotion. *Annals of the New York Academy of Sciences*, *1251*(1), E1–E24. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2012.06751.x

Organización Mundial de la Salud. (2022). *Informe mundial sobre la salud mental: Transformar la salud mental para todos*.

Organización Mundial de la Salud. (2025). *Trastornos mentales*. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders

Pessoa, L. (2017). A network model of the emotional brain. *Trends in Cognitive Sciences*, *21*(5), 357–371. https://doi.org/10.1016/j.tics.2017.03.002

UNICEF. (2022, 11 de octubre). *Ocho de cada 10 adolescentes pasan angustia, depresión y ansiedad, pero no buscan apoyo psicológico* [Comunicado de prensa]. https://www.unicef.org/bolivia/

comunicados-prensa/ocho-de-cada-10-adolescentes-pasan-angustia-depresión-y-ansiedad-pero-no-buscan

Este artículo se publica en acceso abierto bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0).

Territorio de la Palabra
REVISTA ACADÉMICA DE PSICOLOGÍA · CARRERA DE PSICOLOGÍA · UAGRM · SANTA CRUZ DE LA SIERRA · BOLIVIA

Vol. 1, N.° 1 (2026) · pp20–30
CC BY-NC 4.0

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN · DOCENTES INVESTIGADORES

Rediseño curricular por competencias en la Carrera de Psicología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno: análisis documental del tránsito del Plan 148-1 al Plan 148-2

Wilma Forest Herrera[1*]

[1] Rediseño curricular por competencias en la Carrera de Psicología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno: análisis documental del tránsito del Plan 148-1 al Plan 148-2
* Correspondencia: wilmaforest@gmail.com

RESUMEN

El objetivo de este estudio fue analizar los cambios introducidos en el rediseño curricular de la Carrera de Psicología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, en el tránsito del Plan 148-1 al Plan 148-2, e identificar condiciones para su implementación y evaluación. Se realizó un análisis documental cualitativo, de alcance descriptivo-interpretativo, sobre el programa curricular institucional y su cuadro comparativo, con categorías definidas a priori que luego se contrastaron con literatura sobre diseño curricular, formación por competencias y práctica psicológica basada en evidencia. Los resultados muestran el paso de un currículo por objetivos y disciplinas a otro por competencias y ciclos, una reducción de 266 a 231 créditos (13,2 %) y de 6.156 a 5.220 horas académicas (15,2 %), la ampliación del perfil hacia nuevos campos de actuación y la incorporación de terapias cognitivo-conductuales y contextuales junto a los enfoques psicoanalíticos, humanistas y sistémicos. La discusión identifica tres tensiones: pluralismo teórico frente a práctica basada en evidencia, amplitud del perfil frente a profundidad formativa, y menor carga horaria frente a suficiencia de la práctica supervisada. Se concluye que estos cambios son decisiones de diseño cuyo efecto formativo aún no está demostrado, y que su valor dependerá de una matriz de alineamiento verificable, de la formación docente, de la supervisión y del seguimiento de cohortes. Se propone una agenda de implementación y evaluación con acciones, responsables y evidencias de cumplimiento.

Palabras clave: cambio curricular; educación superior; formación de psicólogos; formación por competencias; práctica basada en evidencia; evaluación curricular

ABSTRACT

This study analyzed the changes introduced by the curriculum redesign of the Psychology program at Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, in the transition from Plan 148-1 to Plan 148-2, and identified conditions for its implementation and evaluation. A qualitative documentary analysis with a descriptive-interpretive scope was conducted on the institutional curriculum and its comparative chart, using a priori categories that were then contrasted with literature on curriculum design, competency-based education, and evidence-based practice in psychology. Results show a shift from an objectives- and discipline-based curriculum to one organized by competencies and cycles, a reduction from 266 to 231 credits (13.2%) and from 6,156 to 5,220 academic hours (15.2%), a broader graduate profile covering new fields of practice, and the inclusion of cognitive-behavioral and contextual therapies alongside psychoanalytic, humanistic, and systemic approaches. The discussion identifies three tensions: theoretical pluralism versus evidence-based practice, breadth of the profile versus depth of training, and fewer hours versus the sufficiency of supervised practice. These changes are design decisions whose educational effect has not yet been demonstrated; their value will depend on a verifiable alignment matrix, faculty development, supervision, and cohort monitoring. An implementation and evaluation agenda with actions, responsible units, and evidence of compliance is proposed.

Keywords: curriculum change; higher education; psychology training; competency-based education; evidence-based practice; curriculum evaluation

RECIBIDO
18 de junio de 2026

ACEPTADO
2 de octubre de 2026

PUBLICADO
30 de noviembre de 2026

CÓMO CITAR (APA 7)
Forest Herrera, W. (2026). Rediseño curricular por competencias en la Carrera de Psicología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno: análisis documental del tránsito del Plan 148-1 al Plan 148-2. *Ñe Renda. Territorio de la Palabra, 1*(1), 20–30.

INTRODUCCIÓN

La salud mental ocupa un lugar cada vez más visible en la agenda pública, y los escenarios de intervención psicológica se han diversificado hacia los ámbitos educativo, organizacional, clínico y comunitario [Referencia, Año]. El informe mundial sobre salud mental advierte que hacen falta respuestas más integrales y accesibles (World Health Organization, 2022). Para las carreras de Psicología esto supone algo más que actualizar asignaturas: obliga a preguntarse si el perfil de egreso corresponde a lo que el estudiante realmente puede hacer y a lo que la sociedad necesita. En educación superior, revisar un currículo exige unir pertinencia social, formación científica y evaluación de resultados; incorporar temas recientes no basta para hablar de calidad.

La Carrera de Psicología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) aprobó el Plan 148-2 tras un proceso de rediseño. Según el documento institucional, ese proceso se apoyó en estudios de titulados, empleadores y mercado profesional, en la comparación de ofertas académicas, en consultas a expertos

y en tendencias de formación (Forest Herrera et al., 2026). Son insumos pertinentes para fundamentar un rediseño. Sin embargo, el documento no presenta los datos desagregados de cada fuente, de modo que no es posible establecer cuánto pesó cada una en las decisiones curriculares.

El currículo como proyecto formativo y práctica institucional

Un plan de estudios selecciona conocimientos y distribuye oportunidades formativas, pero lo que produce depende de cómo se enseña, se evalúa y se vive en cada institución. Para Stenhouse (1975), el currículo es una propuesta abierta al examen crítico en la práctica; desde esa perspectiva, un documento aprobado todavía no es una transformación consumada. Biggs y Tang (2011) sostienen, con el principio de alineamiento constructivo, que los resultados previstos, las actividades de aprendizaje y la evaluación deben corresponderse entre sí. Aplicado al caso, el Plan 148-2 tendría que demostrar trazabilidad desde el perfil profesional hasta las evidencias observables de desempeño.

Formación por competencias y evaluación auténtica

El enfoque por competencias supone movilizar saberes conceptuales, procedimentales y éticos ante situaciones profesionales reales, y no se reduce a sustituir objetivos por verbos de acción (Perrenoud, 2004). En la formación de psicólogos, el modelo del cubo distingue competencias fundacionales y funcionales que se desarrollan por etapas (Rodolfa et al., 2005), y los referentes de desempeño propuestos por Fouad et al. (2009) traducen esas competencias en indicadores conductuales para cada nivel de formación. Ambos marcos coinciden en que una competencia se describe por lo que el estudiante es capaz de hacer en cada etapa, no por la asignatura que cursa.

En Psicología, este enfoque obliga a observar si el estudiante sabe formular problemas, elegir instrumentos pertinentes, interpretar evidencia y justificar sus decisiones, y también si interviene dentro de los límites de su competencia y reflexiona sobre las consecuencias éticas de su actuación. Rúbricas, simulaciones, estudios de caso, portafolios y prácticas supervisadas pueden servir para evaluarlo, siempre que cuenten con criterios explícitos, calibración docente y retroalimentación.

Pluralismo teórico y práctica psicológica basada en evidencia

Incorporar terapias cognitivo-conductuales y contextuales amplía el repertorio formativo. Aun así, que las llamadas “olas” se sucedan en la historia no las ordena por eficacia. Hayes (2004) caracteriza la tercera ola por su mayor atención al contexto y a la función de los procesos psicológicos. La práctica basada en evidencia, por su parte, integra la mejor investigación disponible con la experiencia clínica y

con las características, la cultura y las preferencias de las personas atendidas (American Psychological Association, Presidential Task Force on Evidence-Based Practice, 2006). De ahí que el currículo deba enseñar a comparar modelos con criterio, considerando sus indicaciones, limitaciones y contraindicaciones, su adecuación cultural y el monitoreo de resultados, sin confundir novedad terapéutica con superioridad científica.

La literatura sobre terapia de aceptación y compromiso y sobre terapia cognitiva basada en mindfulness aporta evidencia relevante para problemas y poblaciones específicos, pero no autoriza a extrapolar su eficacia a cualquier condición o contexto (A-Tjak et al., 2015; Kuyken et al., 2016). La formación clínica tiene que enseñar a valorar la calidad de los estudios, la magnitud de los efectos, las alternativas disponibles y la seguridad de las intervenciones.

Planteamiento del problema y objetivos

El problema, a la vez científico y práctico, consiste en determinar qué cambia en el diseño curricular y bajo qué condiciones ese cambio puede alterar la experiencia de aprendizaje y el ejercicio profesional. El estudio parte de un supuesto: una innovación curricular no se acredita con la aprobación de una nueva malla, sino con una coherencia demostrable entre competencias, enseñanza, prácticas supervisadas, evaluación y decisiones de mejora.

El objetivo general fue analizar críticamente las modificaciones del Plan 148-2 respecto del Plan 148-1 e identificar condiciones para su implementación y evaluación institucional. Los objetivos específicos fueron: (a) describir los cambios en enfoque curricular, carga académica, organización y perfil profesional registrados en la documentación institucional; (b) identificar las tensiones epistemológicas y pedagógicas asociadas a la incorporación de nuevos modelos clínicos y campos de actuación; y (c) proponer una agenda de implementación y evaluación con evidencias de cumplimiento verificables.

MÉTODO

Diseño

Se realizó un estudio cualitativo de análisis documental, con alcance descriptivo-interpretativo y propositivo, situado en un paradigma interpretativo. Desde esta posición, los documentos curriculares se tratan como textos institucionales que expresan intenciones formativas y decisiones de diseño, no como evidencia de lo que ocurre en las aulas ni de lo que aprenden los estudiantes.

Corpus documental

La fuente primaria fue el *Programa de formación profesional por competencias de la Carrera de Psicología: Plan de estudios 148-2* (Forest Herrera et al., 2026), que incluye

un cuadro comparativo entre los planes 148-1 y 148-2. Como fuentes secundarias se emplearon textos sobre diseño curricular, formación por competencias y práctica psicológica basada en evidencia, seleccionados por su pertinencia conceptual para las categorías de análisis.

Categorías y procedimiento de análisis

El análisis se desarrolló en cuatro pasos. Primero, una lectura exploratoria completa del documento. Segundo, la extracción de la información en una matriz organizada según diez categorías definidas a priori (Tabla 1). Tercero, el cálculo de las variaciones absolutas y relativas de créditos y horas a partir de los valores del cuadro comparativo, tomando el Plan 148-1 como base. Cuarto, el contraste conceptual de los hallazgos con la literatura, del que se derivaron la discusión y la agenda propositiva.

Tabla 1

Categorías de análisis documental

Categoría	Contenido examinado en el documento
Enfoque curricular	Modelo de organización (por objetivos o por competencias) y estructura por ciclos
Perfil profesional	Ámbitos de actuación y funciones declaradas del egresado
Organización y carga académica	Créditos, horas académicas, ciclos y áreas de formación
Campos de formación	Asignaturas nuevas o visibilizadas respecto del plan anterior
Modelos clínicos	Enfoques terapéuticos incluidos y su secuencia
Investigación	Asignaturas, secuencia, prerrequisitos y modalidades de titulación
Ética	Contenidos y espacios de formación ética
Tecnologías	Presencia de tecnologías digitales e inteligencia artificial
Evaluación	Estrategias declaradas de evaluación de competencias
Condiciones de implementación	Recursos, docentes, escenarios de práctica y mecanismos de seguimiento previstos

Nota. Elaboración propia.

Rigor y reflexividad

Para resguardar la confirmabilidad, cada afirmación de la sección de resultados remite a un contenido del documento institucional, y las valoraciones se reservan para la discusión. Debe advertirse que la autora integró el equipo que elaboró el Plan 148-2 (Forest Herrera et al., 2026). Esta doble posición, como participante del diseño y como analista, aporta un conocimiento cercano del proceso, pero también puede inclinar la lectura hacia la justificación de las decisiones adoptadas. Para contrarrestar ese riesgo se adoptó una postura deliberadamente crítica, se separaron los datos documentales de su interpretación.

Consideraciones éticas

El estudio no involucró participantes humanos ni datos personales; se basó exclusivamente en documentación institucional.

Alcance

No se realizaron entrevistas, observaciones ni mediciones de aprendizaje. Por tanto, el estudio no establece efectos causales ni resultados de implementación, y las propuestas que se formulan son recomendaciones analíticas, no acciones institucionales ya ejecutadas.

RESULTADOS

Enfoque curricular

El cuadro comparativo institucional registra el paso de un currículo organizado por objetivos y disciplinas (Plan 148-1) a otro formulado por competencias y ciclos (Plan 148-2), que articula saberes básicos, específicos, aplicados y complementarios (Forest Herrera et al., 2026). En el documento no se identificó una matriz que indique, para cada competencia, qué asignatura la inicia, la desarrolla, la aplica o la integra.

Carga académica y organización

La Tabla 2 resume los indicadores estructurales de ambos planes. La carga se reduce en 35 créditos (13,2 %) y en 936 horas académicas (15,2 %). El documento no desagrega esa reducción por áreas de formación, ni informa las horas de supervisión ni la carga de trabajo autónomo.

Perfil profesional y campos de formación

El documento define un perfil de actuación en los ámbitos clínico, educativo, organizacional y social, sustentado en las funciones de evaluación, diagnóstico, intervención, prevención e investigación (Forest Herrera et al., 2026). El plan incorpora o hace visibles espacios curriculares como Psicología de la Salud, Psicología Jurídica y Forense, Educación Especial, Psicología de la Sexualidad, Acompañamiento Terapéutico, Psicofarmacología, Psicología de la Emergencia y Psicoética.

Modelos clínicos

El plan secuencia las intervenciones conductuales, cognitivo-conductuales y de tercera generación —terapia de aceptación y compromiso (ACT), terapia dialéctico-conductual (DBT), psicoterapia analítico-funcional (FAP), terapia cognitiva basada en mindfulness (MBCT) y terapia conductual integrativa de pareja (IBCT)— y

mantiene las perspectivas psicoanalíticas, humanistas y sistémicas (Forest Herrera et al., 2026).

Investigación, ética y tecnologías

El Plan 148-1 contemplaba cinco asignaturas de investigación. El diagnóstico curricular identificó dos problemas: la preferencia de los estudiantes por el diplomado frente a la tesis como modalidad de titulación y las dificultades de aprobación en determinadas asignaturas de investigación (Forest Herrera et al., 2026). En el Plan 148-2, la ética figura como asignatura específica (Psicoética).

DISCUSIÓN

Los resultados describen un rediseño amplio en el plano del documento. La discusión se ocupa de lo que esos cambios significan y de las condiciones que harían falta para que se traduzcan en mejor formación.

Del cambio nominal al cambio verificable

El tránsito hacia un enfoque por competencias abre la posibilidad de articular los saberes básicos, específicos, aplicados y complementarios. Pero, como advierte Stenhouse (1975), el currículo escrito es una hipótesis que la práctica debe poner a prueba. Si no existe una matriz de trazabilidad que muestre cómo progresa cada competencia a lo largo de los ciclos, la fragmentación, las redundancias y los vacíos formativos del plan anterior pueden persistir bajo una nomenclatura renovada. El alineamiento constructivo (Biggs & Tang, 2011) y los referentes de desempeño por nivel (Fouad et al., 2009; Rodolfa et al., 2005) ofrecen un criterio concreto para construir esa matriz.

Reducción de la carga y suficiencia de la práctica

La reducción de 35 créditos y 936 horas admite dos lecturas. Puede ser una racionalización que elimine redundancias, o puede comprimir experiencias formativas importantes. Con la información disponible no corresponde calificarla como mejora ni como deterioro, porque falta conocer su distribución por áreas, las horas de supervisión, la carga autónoma, la secuencia de prerrequisitos y los logros alcanzados. Hace falta una auditoría de carga curricular que examine si alcanzan las prácticas reales y simuladas y cómo se relacionan las horas con la complejidad de las tareas y el nivel de competencia esperado.

Amplitud del perfil y profundidad formativa

La incorporación de campos como la psicología jurídica y forense, la psicofarmacología o la psicología de la emergencia amplía el horizonte profesional del egresado. Esa amplitud obliga a separar las competencias propias de una formación

generalista de aquellas que exigen entrenamiento avanzado, supervisión especializada o habilitaciones adicionales. Una asignatura, por sí sola, no produce una competencia profesional autónoma, y conviene que el plan lo explicite para no generar expectativas de habilitación que la formación de grado no puede cubrir.

Pluralismo teórico y práctica basada en evidencia

El plan configura una propuesta plural, que suma los modelos de tercera generación sin eliminar los enfoques psicoanalíticos, humanistas y sistémicos. La innovación, sin embargo, no está solo en incluir ACT, DBT, FAP, MBCT o IBCT, sino en enseñar a formular casos y a justificar la elección de procedimientos según la evidencia, el contexto, los objetivos de intervención y el consentimiento informado (American Psychological Association, Presidential Task Force on Evidence-Based Practice, 2006). Los manuales clínicos de cada modelo (Christensen et al., 2020; Hayes et al., 2012; Kohlenberg & Tsai, 1991; Linehan, 2015; Segal et al., 2018) pueden servir como bibliografía especializada, siempre que se distingan de los estudios de eficacia (A-Tjak et al., 2015; Kuyken et al., 2016). Conviene evitar dos supuestos: que todas estas aproximaciones tienen el mismo respaldo empírico y que pueden aplicarse sin formación ni supervisión específicas.

Investigación, ética y tecnologías como ejes verificables

Que el plan anterior incluyera cinco asignaturas de investigación no aseguró una producción científica estudiantil equivalente, y los problemas señalados por el diagnóstico sugieren revisar la secuencia de prerrequisitos y los apoyos pedagógicos, una vez se disponga de estadísticas institucionales desagregadas. Resulta razonable una formación investigativa progresiva, vinculada con problemas de los ámbitos clínico, educativo, organizacional y comunitario, con evidencias de aprendizaje que vayan de la lectura crítica al diseño y la comunicación de resultados.

El uso de tecnologías digitales y de herramientas de inteligencia artificial en la práctica psicológica exige, además, integrar el juicio ético en situaciones concretas: protección de datos, confidencialidad, identificación de sesgos, transparencia, supervisión humana y reconocimiento de los límites de la propia competencia. La efectividad de estos ejes debería evaluarse con indicadores de aprobación, progresión, producción investigativa y calidad del desempeño ético, sin tomar la mera presencia de asignaturas como prueba de logro.

Agenda de implementación y evaluación

A partir de lo anterior se propone una ruta que convierta las decisiones del documento en compromisos académicos auditables (Tabla 2). Los plazos son orientativos y requieren aprobación institucional.

Tabla 2

Agenda propuesta de implementación y evaluación del Plan 148-2

Horizonte	Acción prioritaria	Responsables propuestos	Evidencia de cumplimiento
Primer semestre de implementación	Construir la matriz perfil–competencias–asignaturas–resultados–evidencias; auditar horas y prácticas	Coordinación curricular y equipos de área	Matriz validada; informe de brechas; distribución de prácticas
Primer año	Capacitar a los docentes en alineamiento, evaluación auténtica y práctica basada en evidencia; diseñar rúbricas comunes	Dirección de Carrera y responsables de asignatura	Porcentaje de asignaturas alineadas; rúbricas aplicadas; docentes capacitados
Primer y segundo año	Establecer protocolos de práctica, convenios, supervisión, consentimiento, derivación y resguardo de datos	Coordinación de prácticas e instancias éticas	Cobertura de supervisión; incidentes registrados y resueltos; evaluación de centros
Cada gestión académica	Aplicar la evaluación de competencias por ciclo con portafolios, casos y estaciones prácticas cuando proceda	Comité de evaluación curricular	Resultados por competencia; brechas por cohorte; acciones correctivas
Al egreso y posteriormente	Estudiar trayectoria, inserción, satisfacción de empleadores y desempeño de egresados con instrumentos validados	Unidad de investigación y seguimiento de graduados	Informe de cohortes; retroalimentación documentada al plan

Nota. Elaboración propia. La agenda es una propuesta de este artículo y no un compromiso adoptado por la UAGRM. Antes de usar los indicadores para juzgar calidad se requieren líneas de base, metas acordadas y fuentes de verificación.

Limitaciones y líneas futuras

El estudio tiene cuatro limitaciones. Se basa en una sola fuente institucional, que describe el currículo prescrito y no el implementado ni el aprendido. No dispone de los datos desagregados del diagnóstico ni de la distribución de la carga por áreas. No incorpora la voz de docentes, estudiantes, egresados ni empleadores. Y la autora participó en el diseño del plan, lo que exige leer las interpretaciones a la luz de esa posición. Las investigaciones futuras podrían estudiar la implementación del Plan 148-2 mediante observación de aula, entrevistas y análisis de evidencias de aprendizaje; seguir a las primeras cohortes hasta el egreso; y comparar este rediseño con otros procesos de reforma curricular en carreras de Psicología del país.

CONCLUSIONES

En respuesta al primer objetivo, el Plan 148-2 modifica de forma sustantiva el diseño curricular: cambia el enfoque de objetivos a competencias, reduce la carga en

35 créditos y 936 horas, amplía el perfil profesional y diversifica los modelos clínicos. Son decisiones de diseño. Todavía no puede afirmarse que hayan transformado la formación profesional, porque no existe evidencia de implementación ni de resultados de aprendizaje.

En cuanto al segundo objetivo, el rediseño enfrenta tres tensiones: entre pluralismo teórico y práctica basada en evidencia, entre amplitud del perfil y profundidad formativa, y entre menor carga horaria y suficiencia de la práctica supervisada. Ninguna de ellas se resuelve con la sola inclusión de asignaturas; requiere alfabetización científica, formulación de casos, sensibilidad cultural, supervisión y una distinción clara entre competencias generalistas y especializadas.

Respecto del tercer objetivo, la viabilidad del cambio depende de condiciones organizativas concretas: una matriz de alineamiento revisada periódicamente, una auditoría de carga, desarrollo docente, protocolos éticos para las prácticas y un sistema de seguimiento de cohortes con responsables definidos y decisiones de ajuste documentadas. El éxito del plan no se medirá por la modernidad declarada de la malla, sino por la capacidad demostrable de los egresados para actuar con rigor científico, juicio ético y responsabilidad social. El principal desafío de la Carrera no es defender el Plan 148-2 como reforma concluida, sino convertirlo en un proyecto institucional de mejora, sometido a contrastación y revisión permanente.

REFERENCIAS

A-Tjak, J. G. L., Davis, M. L., Morina, N., Powers, M. B., Smits, J. A. J., & Emmelkamp, P. M. G. (2015). A meta-analysis of the efficacy of acceptance and commitment therapy for clinically relevant mental and physical health problems. *Psychotherapy and Psychosomatics, 84*(1), 30–36. https://doi.org/10.1159/000365764

American Psychological Association, Presidential Task Force on Evidence-Based Practice. (2006). Evidence-based practice in psychology. *American Psychologist, 61*(4), 271–285. https://doi.org/10.1037/0003-066X.61.4.271

Biggs, J., & Tang, C. (2011). *Teaching for quality learning at university* (4th ed.). Open University Press.

Christensen, A., Doss, B. D., & Jacobson, N. S. (2020). *Reconcilable differences: Rebuild your relationship by rediscovering the partner you love—without losing yourself* (3rd ed.). Guilford Press.

Forest Herrera, W. G., Melgar Portales, R., Ocampo Barba, N. R., Escobar Nogales, M. F., Valverde Leiza, W. R., Garzón Cardenas, A. N., & Bruno Esquivel, P. R. (2026). *Programa de formación profesional por competencias de la carrera de Psicología: Plan de estudios 148-2* [Documento curricular no publicado]. Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.

Fouad, N. A., Grus, C. L., Hatcher, R. L., Kaslow, N. J., Hutchings, P. S., Madson, M. B., Collins, F. L., Jr., & Crossman, R. E. (2009). Competency benchmarks: A model for understanding and measuring competence in professional psychology across training levels. *Training and Education in Professional Psychology, 3*(4, Suppl.), S5–S26. https://doi.org/10.1037/a0015832

Hayes, S. C. (2004). Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of behavioral and cognitive therapies. *Behavior Therapy, 35*(4), 639–665. https://doi.org/10.1016/S0005-7894(04)80013-3

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2012). *Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change* (2nd ed.). Guilford Press.

Kohlenberg, R. J., & Tsai, M. (1991). *Functional analytic psychotherapy: Creating intense and curative therapeutic relationships*. Plenum Press.

Kuyken, W., Warren, F. C., Taylor, R. S., Whalley, B., Crane, C., Bondolfi, G., Hayes, R., Huijbers, M., Ma, H., Schweizer, S., Segal, Z., Speckens, A., Teasdale, J. D., Van Heeringen, K., Williams, M., Byford, S., Byng, R., & Dalgleish, T. (2016). Efficacy of mindfulness-based cognitive therapy in prevention of depressive relapse: An individual patient data meta-analysis. *JAMA Psychiatry, 73*(6), 565–574. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2016.0076

Linehan, M. M. (2015). *DBT skills training manual* (2nd ed.). Guilford Press.

Perrenoud, P. (2004). *Diez nuevas competencias para enseñar*. Graó.

Rodolfa, E., Bent, R., Eisman, E., Nelson, P., Rehm, L., & Ritchie, P. (2005). A cube model for competency development: Implications for psychology educators and regulators. *Professional Psychology: Research and Practice, 36*(4), 347–354. https://doi.org/10.1037/0735-7028.36.4.347

Segal, Z. V., Williams, J. M. G., & Teasdale, J. D. (2018). *Mindfulness-based cognitive therapy for depression* (2nd ed.). Guilford Press.

Stenhouse, L. (1975). *An introduction to curriculum research and development*. Heinemann.

World Health Organization. (2022). *World mental health report: Transforming mental health for all*. https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338

Este artículo se publica en acceso abierto bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0).

Reconda Territorio de la Palabra
REVISTA ACADÉMICA DE PSICOLOGÍA
CARRERA DE PSICOLOGÍA · UAGRM
SANTA CRUZ DE LA SIERRA · BOLIVIA

Vol. 1, N.º 1 (2026) · pp. 31–40
CC BY-NC 4.0

ENSAYO · DOCENTES INVESTIGADORES

La flexibilidad y el movimiento pendular del sujeto en el discurso contemporáneo

Flexibility and the pendular movement of the subject in contemporary discourse

María Fátima Escobar[1*]

[1] Carrera de Psicología, Facultad de Humanidades, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
* Correspondencia: mafatimaescobar@gmail.com

RESUMEN

Este ensayo teórico propone una lectura psicoanalítica de la noción de flexibilidad como significante amo del discurso contemporáneo. A partir de la teoría de los cuatro discursos de Jacques Lacan, se sostiene que la flexibilidad, lejos de ser solo una capacidad psicológica de adaptación, opera como un imperativo que convoca al sujeto a doblegarse ante las exigencias del Otro. El análisis se detiene en la tensión entre dos registros que suelen confundirse: la flexibilidad como capacidad psicológica, tal como la presentan la psicología de orientación adaptativa y las terapias contextuales, y la flexibilidad como significante amo, tal como se desprende de la lectura lacaniana. Se argumenta que esta tensión no es un error conceptual, sino el síntoma de una operación ideológica que recubre con el lenguaje de la capacidad lo que el psicoanálisis lee como mandato de adaptación. Se propone la metáfora del movimiento pendular entre flexibilidad y rigidez para pensar la posición del sujeto en la clínica: el sujeto oscila entre doblegarse y endurecerse sin encontrar un punto de reposo. Se concluye que la tarea del psicoanálisis no es promover la flexibilidad ni denostar la rigidez, sino restituir al sujeto su división allí donde el discurso contemporáneo le ofrece la ilusión de unidad, y se plantean cinco retos para la clínica.

Palabras clave: flexibilidad; rigidez; discurso del amo; psicoanálisis lacaniano; clínica contemporánea

ABSTRACT

This theoretical essay proposes a psychoanalytic reading of flexibility as a master signifier of contemporary discourse. Drawing on Jacques Lacan's theory of the four discourses, it argues that flexibility, far from being merely a psychological capacity for adaptation, operates as an imperative that summons the subject to bend before the demands of the Other. The analysis focuses on the tension between two registers that are often conflated: flexibility as a psychological capacity, as presented by adaptation-oriented psychology and contextual therapies, and flexibility as a master signifier, as it emerges from the Lacanian reading. It is argued that this

tension is not a conceptual error but the symptom of an ideological operation that covers with the language of capacity what psychoanalysis reads as a mandate to adapt. The metaphor of a pendular movement between flexibility and rigidity is proposed to think about the subject's position in the clinic: the subject oscillates between bending and hardening without finding a point of rest. It is concluded that the task of psychoanalysis is neither to promote flexibility nor to denigrate rigidity, but to restore the subject's division where contemporary discourse offers the illusion of unity, and five challenges for clinical practice are outlined.

Keywords: flexibility; rigidity; master's discourse; Lacanian psychoanalysis; contemporary clinical practice

RECIBIDO
7 de julio de 2026

ACEPTADO
2 de octubre de 2026

PUBLICADO
30 de noviembre de 2026

CÓMO CITAR (APA 7)
Escobar, M. F. (2026). La flexibilidad y el movimiento pendular del sujeto en el discurso contemporáneo. *Ñe Renda. Territorio de la Palabra, 1*(1), 31–40.

INTRODUCCIÓN

El presente texto es un ensayo teórico, y esa elección no es neutra. En un campo donde la producción académica tiende a adoptar las formas del artículo de investigación —con su estructura IMRyD, su metodología explícita y sus resultados tabulados—, el ensayo académico conserva un estatuto singular: el de un pensamiento que se despliega sin la pretensión de demostrar, sino de interrogar. El psicoanálisis, entendido como una práctica clínica rigurosa y no como mero enfoque o teoría, exige este gesto. No se trata de una concesión al impresionismo, sino de una postura ética: sostener la especificidad de un discurso que no se deja reducir a los protocolos de la investigación positivista.

Esta advertencia tiene consecuencias metodológicas. El ensayo no busca validar hipótesis ni medir variables. Su propósito es analizar críticamente un significante del discurso contemporáneo —la flexibilidad— desde la teoría de los cuatro discursos de Jacques Lacan y proponer una lectura clínica de sus efectos sobre el sujeto. El análisis se apoya en la conceptualización lacaniana del discurso del amo, en la distinción entre enunciado y enunciación y en la noción de goce como aquello que no puede ser puesto en palabras. Se trata, pues, de un ejercicio de elaboración teórica que aspira a producir efectos de lectura.

La elección del término no es arbitraria. En las últimas décadas, la flexibilidad se ha convertido en un imperativo cultural que atraviesa el trabajo, la educación, la salud mental, las relaciones afectivas y la identidad. Se nos dice que debemos ser flexibles, adaptables, resilientes, capaces de reinventarnos ante un mundo que cambia vertiginosamente. La flexibilidad aparece así como una virtud indiscutible, un ideal de subjetividad. Esa aparente evidencia merece ser interrogada.

El punto de partida es una observación clínica: muchos sujetos que consultan por sufrimiento psíquico se presentan a sí mismos como "demasiado rígidos" o "incapaces de adaptarse" y expresan el deseo de volverse "más flexibles"; otros relatan una experiencia de flexibilización extrema que los ha dejado exhaustos, sin puntos de referencia, sin posibilidad de decir "no". En ambos casos, la flexibilidad aparece como un significante que organiza la demanda de análisis y que merece ser escuchado no como una queja superficial, sino como una formación del inconsciente que dice algo sobre la posición del sujeto en el discurso.

La tesis que guía este ensayo es la siguiente: la flexibilidad funciona como un significante amo en el discurso contemporáneo. No es simplemente una capacidad psicológica que algunos tienen y otros no, sino un mandato que convoca al sujeto a doblegarse ante las exigencias del Otro. Como todo significante amo, la flexibilidad no funciona sola: llama a su opuesto, la rigidez, que permanece oculto en el enunciado, pero opera en la enunciación. El sujeto queda así atrapado en un movimiento pendular entre ambos polos. La tarea del psicoanálisis, se sostendrá, no es promover la flexibilidad ni denostar la rigidez, sino restituir al sujeto su división.

El ensayo se organiza en cinco apartados. El primero revisa el significado y la historia del término "flexible" y muestra una ambigüedad fundamental: la flexibilidad como cualidad de lo que se dobla y como disposición a dejarse doblegar. El segundo presenta la teoría lacaniana de los cuatro discursos, con énfasis en el discurso del amo. El tercero analiza la flexibilidad como significante amo, en contraste con su conceptualización como capacidad psicológica, y examina las objeciones que esa lectura admite. El cuarto desarrolla la metáfora del movimiento pendular y su lectura clínica. El quinto presenta las conclusiones en forma de retos para la clínica contemporánea.

Conviene precisar el alcance del trabajo. Este ensayo no pretende ser una contribución original a la teoría lacaniana, sino una lectura situada de un fenómeno contemporáneo a partir de herramientas conceptuales ya establecidas. Su originalidad, si alguna tiene, reside en aplicar la teoría de los discursos a un significante que no ha sido suficientemente interrogado. Se trata de un ejercicio de crítica cultural con consecuencias clínicas, que aspira a contribuir al debate sobre los imperativos de subjetivación en el capitalismo contemporáneo.

FLEXIBILIDAD: SIGNIFICADO E HISTORIA DE UN TÉRMINO

Comenzar por el término mismo es una decisión metodológica: si se va a sostener que la flexibilidad funciona como un significante amo, conviene primero escuchar el significante en su materialidad, en las huellas que la lengua ha dejado en él. La etimología y los diccionarios no revelan una esencia, pero muestran las sedimentaciones históricas de un término que hoy parece evidente. En ese recorri-

do aparece una ambigüedad que no es accidental: la flexibilidad es, a la vez, la cualidad de lo que se dobla y la disposición a dejarse doblegar.

El *Diccionario de la lengua española* registra que "flexible" procede del latín *flexibĭlis* —derivado de *flectere*, 'doblar'— y lo define, en su primera acepción, como lo "que tiene disposición para doblarse fácilmente" (Real Academia Española [RAE], s. f.). En una segunda acepción, referida a las personas, lo define como quien se acomoda con facilidad a la opinión, la voluntad o la actitud de otros. Las dos acepciones conviven sin conflicto aparente: la primera describe una propiedad física; la segunda introduce una dimensión relacional y, podría decirse, política. Ser flexible es, en esta segunda acepción, adaptarse a la voluntad de otro. La lengua misma señala que la flexibilidad no es solo una capacidad del sujeto, sino una respuesta a una demanda del Otro.

Los diccionarios bilingües históricos confirman esta ambigüedad. El diccionario de las lenguas española, francesa y latina de Cormon (1769) hace corresponder "flexible", en su sentido figurado, con el latín *docilis* y con los términos franceses que designan lo "dócil, maniable, traitable". No se trata de una etimología —el origen del término es *flexibilis*—, sino de una equivalencia de sentido; pero esa equivalencia es elocuente: en su acepción figurada, lo flexible es lo que se deja enseñar, manejar y tratar. El sujeto flexible se aproxima así al sujeto dócil, el que se deja conducir y no opone resistencia.

El *Diccionario Reverso* refuerza esta lectura al definir "flexible" como "transigente, tolerable, que no es riguroso y se adapta fácilmente a todos los cambios" (Reverso, s. f.). La flexibilidad se define aquí por negación de la rigidez, pero también por negación de la exigencia: el flexible no es riguroso, no impone condiciones. En esta acepción, la flexibilidad se aproxima a una tolerancia sin límites, a una adaptación que no se detiene ante nada.

En síntesis, el recorrido por los diccionarios muestra una ambigüedad que el discurso contemporáneo tiende a silenciar. La flexibilidad es, por un lado, una capacidad de adaptación que se presenta como deseable, incluso necesaria, para sobrevivir en un mundo cambiante; por otro, una disposición al doblegamiento que puede disfrazar de virtud la sumisión a la voluntad del Otro. Esta ambigüedad no es un defecto de la lengua, sino una de sus verdades. Como todo significante, la flexibilidad está dividida: dice una cosa en el nivel del enunciado ("soy capaz de adaptarme") y otra en el nivel de la enunciación ("me doblego ante el Otro"). Para interrogar esa división se requiere un marco que permita pensar el significante en su función de lazo social: la teoría de los cuatro discursos de Jacques Lacan.

EL DISCURSO DEL AMO EN LACAN

La teoría de los cuatro discursos es una de las contribuciones más originales del último Lacan. Formulada en el Seminario 17, *El reverso del psicoanálisis* (Lacan,

1969-1970/1992), y retomada en el Seminario 19, *...o peor* (Lacan, 1971-1972/2012), no es una tipología de formas de hablar, sino una formalización de los modos de lazo social que pueden establecerse entre los seres hablantes. El discurso, en Lacan, no es el lenguaje en su función comunicativa, sino aquello que instaura un tipo de lazo social definido (Lacan, 1971-1972/2012, p. 48): lo que hace que un conjunto de sujetos se vincule de una manera determinada, con lugares, posiciones y efectos específicos.

Lacan propone cuatro discursos —del amo, universitario, de la histérica y del analista—, cada uno escrito con cuatro términos: S1 (significante amo), S2 (saber), $ (sujeto barrado) y *a* (objeto plus-de-goce), distribuidos en cuatro lugares fijos cuya función se resume en la Tabla 1.

Tabla 1

Lugares de la estructura de los discursos en Lacan

Lugar	Función
Agente	Aquel que aparentemente organiza el discurso; el lugar dominante, el que lo comanda
Otro	La alteridad a la que el discurso se dirige; el lugar del trabajo
Producción	El efecto producido por el discurso en el Otro y sobre él
Verdad	El fundamento oculto del discurso, lo que lo sostiene más allá de las apariencias

Nota. Elaboración propia a partir de Lacan (1969-1970/1992).

Para que haya discurso debe haber un agente que se dirige a un Otro. El sujeto no es el origen del discurso; quien habla no posee la verdad de lo que dice, porque la verdad está en otro lugar, que permanece oculto. Esta topología tiene consecuencias clínicas y políticas, porque muestra que el sujeto no es dueño de su decir, sino que es hablado por un discurso que lo precede.

El discurso del amo es el discurso fundamental. En él, el significante amo (S1) ocupa el lugar del agente y se dirige al saber (S2), que ocupa el lugar del Otro; el sujeto barrado ($) ocupa el lugar de la verdad, y el objeto *a*, el de la producción. El discurso del amo comanda, así, desde un significante que no sabe lo que dice y produce como efecto un resto de goce que el sujeto no puede simbolizar. El amo no es el que obra, sino el que hace hacer: el que ordena, el que exige.

El discurso del amo no es una forma histórica superada, sino una estructura permanente que puede encarnarse en cualquier significante: la patria, la ciencia, el mercado, la salud, la resiliencia, la flexibilidad. Cuando un significante ocupa el lugar del agente y desde allí convoca al sujeto a identificarse con un ideal, se está ante un discurso del amo. La pregunta que guía este ensayo es si la flexibilidad funciona hoy de ese modo. Para responderla, conviene detenerse en un rasgo estructural del significante: no funciona solo, sino en oposición —día y noche, activo y pasivo—, y esa tensión produce el efecto de sentido que captura al sujeto. Si la

flexibilidad es un significante amo, no funciona sin su opuesto, la rigidez, que no aparece en el enunciado, pero opera en la enunciación.

LA FLEXIBILIDAD COMO SIGNIFICANTE AMO

La tesis que se sostiene es que la flexibilidad funciona como un significante amo del discurso contemporáneo. No se propone como metáfora, sino como una afirmación sobre la estructura del discurso: la flexibilidad se presenta como un ideal de identificación —"usted debe ser flexible", "sea adaptable", "tenga mente abierta", "no se aferre a lo que ya no sirve"— que convoca al sujeto a doblegarse ante las exigencias del Otro.

Para fundamentar esta tesis conviene examinar cómo la psicología contemporánea de orientación adaptativa conceptualiza la flexibilidad. Galimberti (2002), en su *Diccionario de psicología*, la define como el "factor psicológico que designa la capacidad de adaptación y de modificación de una persona y la maleabilidad de su comportamiento en relación con los factores internos o externos que afectan su vida" (p. 512). Hayes (2020), desde la terapia de aceptación y compromiso, define la flexibilidad psicológica como "la capacidad de sentir y de pensar con apertura mental" (p. 11). Escudero (2018), por su parte, describe la flexibilidad cognitiva como la capacidad del cerebro "para adaptar nuestra conducta y pensamiento con facilidad a conceptos y situaciones cambiantes, novedosas e inesperadas, o a la capacidad mental de pensar en varios conceptos a la vez" (párr. 1). El hilo común es claro: la flexibilidad se presenta como una capacidad del sujeto, una virtud que le permite adaptarse a un mundo cambiante.

Leídas desde el psicoanálisis lacaniano, estas definiciones muestran que ambas tradiciones no hablan de lo mismo. Para la psicología de orientación adaptativa, la flexibilidad es una capacidad que puede medirse, entrenarse y mejorarse; para el psicoanálisis, es un significante que organiza una demanda y que dice algo sobre la posición del sujeto en el discurso. No se trata de que una lectura sea verdadera y la otra falsa, sino de que operan en registros distintos y producen efectos distintos.

Pero hay algo más. Al presentar la flexibilidad como una capacidad individual deseable, incluso necesaria para el bienestar, esas conceptualizaciones tienden a no problematizarla como imperativo: recubren con el lenguaje de la capacidad lo que el psicoanálisis lee como mandato. Esa operación tiene un efecto ideológico: despolitiza el imperativo y lo convierte en una cuestión de entrenamiento personal. Si alguien es inflexible, es porque no ha desarrollado la capacidad; si es flexible, es porque ha trabajado en sí mismo. La dimensión del Otro que exige la flexibilidad desaparece del horizonte.

El psicoanálisis, en cambio, sostiene que la flexibilidad no es solo una capacidad del sujeto, sino una respuesta a una demanda del Otro. El sujeto no es flexible

por naturaleza ni por entrenamiento, sino porque el discurso contemporáneo —el del capitalismo, la empresa, la salud mental positiva, la adaptabilidad permanente— le exige serlo y lo convoca a identificarse con un ideal de flexibilidad sin límites.

Aquí conviene detenerse en el goce. Para el psicoanálisis lacaniano, lo que no tiene sentido es el goce (Brousse, 2017). El discurso del amo gestiona el goce por medio del sentido. La flexibilidad, como significante amo, ofrece un sentido al sujeto —"sé flexible, adáptate, cambia"—, pero ese sentido recubre un goce que no se deja simbolizar. El sujeto que se dobla ante el imperativo de flexibilidad no sabe qué goce está en juego en su doblegamiento: cree que se adapta por voluntad propia cuando, en realidad, responde a una demanda que lo excede.

Una viñeta clínica ilustra esta operación. Una paciente llega a análisis diciendo: "Necesito ser más flexible. Mi trabajo cambia todo el tiempo, mi pareja cambia, mis hijos cambian, y yo no logro adaptarme". La demanda es explícita. Pero, si se escucha con atención, lo que emerge no es una falta de flexibilidad, sino un agotamiento: la paciente ha estado doblegándose durante años ante las demandas de un Otro que nunca se satisface. Su rigidez no aparece como un déficit, sino como una defensa ante un imperativo de flexibilidad que la ha dejado exhausta. La tarea del análisis no es ayudarla a ser más flexible, sino interrogar qué goce está en juego en su doblegamiento y qué quiere decir ese "necesito ser más flexible" en la economía de su deseo.

Objeciones y alcance de la tesis

La tesis admite al menos dos objeciones. La primera es que la terapia de aceptación y compromiso no define la flexibilidad psicológica como mera adaptación a la demanda ajena, sino como la capacidad de sostener la experiencia presente y actuar en dirección a los propios valores (Hayes, 2020); en esa formulación, la flexibilidad incluye la posibilidad de no ceder. La objeción es pertinente y obliga a precisar el alcance del argumento: lo que aquí se interroga no es la definición técnica de cada modelo, sino el uso de la flexibilidad como ideal cultural, que circula despojado de esas precisiones y se presenta como virtud incondicional. La segunda objeción es que la lectura propuesta podría convertir toda búsqueda de adaptación en síntoma; el ensayo no sostiene eso, sino que la demanda de flexibilidad merece ser escuchada antes de ser satisfecha. Ambas objeciones delimitan la tesis: la flexibilidad funciona como significante amo cuando opera como imperativo sin límite, no cada vez que se la nombra.

Consideraciones éticas

El autor declara contar con el consentimiento informado escrito de los progenitores para la publicación del caso. El protocolo no fue evaluado por un comité de

ética, dado que el caso se originó como una valoración asistencial; esta ausencia se declara como limitación.

EL MOVIMIENTO PENDULAR

Si la flexibilidad es el significante que ocupa el lugar del agente, su opuesto, la rigidez, no desaparece: permanece oculto, pero operando. Este apartado desarrolla esa operación y propone una metáfora para pensar la posición del sujeto.

La metáfora del péndulo no es casual. Un péndulo oscila entre dos puntos extremos sin detenerse en el medio, y cada oscilación responde a la anterior: cuanto más se desplaza hacia un lado, más fuerza acumula para desplazarse hacia el otro. El sujeto atrapado en el imperativo de flexibilidad oscila del mismo modo: se dobla hasta que no puede más, entonces se endurece, y luego vuelve a doblegarse. No hay punto de reposo ni posibilidad de decir "aquí me quedo".

Esta oscilación no es una patología del sujeto, sino una respuesta a una contradicción del discurso. El discurso contemporáneo exige flexibilidad, pero también resultados; adaptación, pero también rendimiento; apertura, pero también eficacia. El sujeto que se dobla demasiado pierde su consistencia; el que se endurece demasiado pierde su adaptabilidad. El discurso del amo no ofrece una salida, sino una doble atadura de la que el sujeto no puede escapar por sus propios medios.

La rigidez, en este contexto, no es lo contrario de la flexibilidad, sino su sombra: el resto que el discurso de la flexibilidad produce, el objeto *a* que el sujeto produce sin saberlo. Cuando el sujeto dice "soy demasiado rígido", puede estar diciendo: "he intentado ser flexible hasta el agotamiento, y este es el precio que he pagado". La rigidez aparece, así, como síntoma del imperativo de flexibilidad.

Conviene introducir aquí una distinción clínica. No es lo mismo la rigidez del sujeto que la firmeza del acto analítico. La primera es un síntoma, una defensa, una respuesta al imperativo; la segunda es una posición ética: el analista no se adapta a la demanda del paciente ni responde a ella con su satisfacción, sino que sostiene una posición, la de la escucha del inconsciente y el respeto por la división del sujeto. Confundir ambas es uno de los riesgos de la clínica contemporánea, que tiende a promover una "flexibilidad terapéutica" que disuelve el acto en la adaptación al paciente.

El movimiento pendular no se resuelve, entonces, flexibilizando ni endureciendo al sujeto, sino —si algo se resuelve— restituyéndole su división: permitiéndole reconocer que no es ni flexible ni rígido, sino habitado por una falta, por un goce que no se deja domesticar y por un deseo que no se deja adaptar. La tarea del psicoanálisis no es encontrar el punto medio del péndulo —eso sería una fantasía de equilibrio—, sino permitir que el sujeto se detenga y escuche el movimiento, para inventar, caso por caso, una posición que no sea ni la sumisión flexible ni el endurecimiento defensivo. Esa posición no está dada de antemano: no hay una "flexibi-

lidad saludable" ni una "rigidez patológica", sino sujetos que, en su análisis, inventan formas singulares de habitar el imperativo, de decir "no" cuando es necesario, de ceder cuando tiene sentido y de sostenerse cuando la dignidad lo exige. El psicoanálisis no promete liberar al sujeto del discurso del amo, pero puede ofrecerle un espacio para interrogar su relación con ese discurso y encontrar, en la invención de su propio decir, una forma de resistencia que no sea ni la queja ni la adaptación.

CONCLUSIONES: RETOS PARA LA CLÍNICA CONTEMPORÁNEA

A lo largo de este ensayo se ha sostenido que la flexibilidad funciona como un significante amo del discurso contemporáneo y que su opuesto, la rigidez, permanece oculto en la enunciación, atrapando al sujeto en un movimiento pendular sin punto de reposo. Esta aserción no pretende clausurar el debate, sino abrirlo. Si el psicoanálisis es una ética del bien decir y no una técnica de normalización, su tarea frente al imperativo de flexibilidad no puede ser promover una "flexibilidad saludable" ni denostar la rigidez como patología, sino restituir al sujeto su división allí donde el discurso contemporáneo le ofrece la ilusión de unidad. De esta posición se desprenden cinco retos, que se plantean como aperturas para el trabajo clínico y para el debate entre colegas.

El primer reto es escuchar la flexibilidad como formación del inconsciente. Cuando un paciente dice "necesito ser más flexible" o "soy demasiado rígido", no se está ante una queja superficial ni ante un objetivo terapéutico evidente, sino ante un significante que organiza su demanda. La pregunta no es cómo ayudarlo a ser más flexible, sino qué quiere decir ese significante en la economía de su goce: ¿a qué renuncia cuando se dobla?, ¿qué pierde cuando se endurece?, ¿de qué Otro espera el permiso para dejar de adaptarse?

El segundo reto es resistir la tentación de la "flexibilidad terapéutica". En la psicoterapia contemporánea, la flexibilidad se ha convertido en un ideal: el terapeuta debe adaptarse al paciente, ajustar la técnica, integrar enfoques. Este ideal, aunque bien intencionado, puede convertirse en una nueva forma del discurso del amo que silencia la dimensión del acto analítico, que no se adapta, sino que corta e interpreta desde otro lugar. El reto es sostener la firmeza del acto sin confundirla con la rigidez del sujeto que sufre.

El tercer reto es pensar el movimiento pendular sin patologizarlo. El sujeto que oscila entre flexibilidad y rigidez no está "enfermo": responde, con los recursos de que dispone, a un imperativo contradictorio —sé flexible, pero no te doblegues del todo—. La clínica no debe apurar la resolución de ese movimiento, sino acompañar la invención de una posición propia, que se construye en el análisis, caso por caso.

El cuarto reto es interrogar la propia flexibilidad del analista. ¿En qué medida los analistas están también capturados por el imperativo de flexibilidad? ¿Cuándo se dice "flexibilidad" para nombrar lo que en realidad es falta de posición? ¿Cuándo se confunde la apertura al Otro con la disolución del acto? Estos interrogantes forman parte del trabajo permanente que el psicoanálisis exige a quienes lo practican.

El quinto reto es sostener la dimensión política del psicoanálisis. Si la flexibilidad es un significante amo del capitalismo contemporáneo, el psicoanálisis no puede limitarse a la clínica del uno por uno: su ética implica también intervenir en el debate cultural, desmontar los imperativos de subjetivación, señalar las contradicciones del discurso dominante y sostener que no todo es adaptable ni negociable. Hay algo del orden del goce que resiste, y esa resistencia no es un déficit, sino una verdad del sujeto.

Estos retos no constituyen un programa, sino preguntas abiertas. El aporte del ensayo consiste en ofrecer a clínicos, docentes y estudiantes una lectura que permite escuchar de otro modo la demanda de flexibilidad, distinguir la rigidez sintomática de la firmeza del acto analítico y abrir una línea de reflexión sobre los imperativos de adaptación que hoy interpelan a analistas y pacientes, docentes y estudiantes, y que, como todo significante amo, exigen ser interrogados antes que obedecidos.

REFERENCIAS

Cormon, F. (1769). *Sobrino aumentado o nuevo diccionario de las lenguas española, francesa y latina*

Galimberti, U. (2002). *Diccionario de psicología*. Siglo XXI.

Hayes, S. C. (2020). *Una mente liberada: La guía esencial de la terapia de aceptación y compromiso*. Paidós. (Obra original publicada en 2019)

Lacan, J. (1992). *El seminario de Jacques Lacan: Libro 17. El reverso del psicoanálisis, 1969-1970*. Paidós. (Obra original publicada en 1991)

Lacan, J. (2012). *El seminario de Jacques Lacan: Libro 19. ...o peor, 1971-1972*

Real Academia Española. (s. f.). Flexible. En *Diccionario de la lengua española* (23.ª ed., versión en línea). Recuperado el 14 de octubre de 2026, de https://dle.rae.es/flexible

Reverso. (s. f.). Flexible. En *Diccionario Reverso de español*. https://diccionario.reverso.net/espanol-definiciones/flexible

Este artículo se publica en acceso abierto bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0).

Territorio de la Palabra
REVISTA ACADÉMICA DE PSICOLOGÍA
CARRERA DE PSICOLOGÍA · UAGRM
SANTA CRUZ DE LA SIERRA · BOLIVIA

Vol. 1, N.° 1 (2026) · pp. 41–54
CC BY-NC 4.0

ARTÍCULO METODOLÓGICO · DOCENTES INVESTIGADORES

Método comparativo de enfoques psicoterapéuticos basado en experiencias vivenciales grupales: Psicodrama y Psicoterapia Positiva

A comparative method for psychotherapeutic approaches based on group experiential practices: Psychodrama and Positive Psychotherapy

Teresa Baldiviezo Álvarez[1*]

[1] Carrera de Psicología, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
* Correspondencia: teresabaldiviezo@uagrm.edu.bo

RESUMEN

Objetivo. Formular y fundamentar un método comparativo para enfoques psicoterapéuticos —el Psicodrama y la Psicoterapia Positiva— basado en experiencias vivenciales grupales. Método. Estudio cualitativo de orientación fenomenológica y comparativa, sustentado en el enfoque epistemológico introspectivo-vivencial. La fase documental examinó los antecedentes históricos, los fundamentos epistemológicos y teóricos, los recursos metodológicos y los conceptos de ambos enfoques. La fase vivencial sistematizó experiencias de talleres grupales desarrollados en programas de formación de posgrado en psicoterapia y en la práctica clínica, registradas mediante notas de campo, protocolos de sesión y registros reflexivos de la investigadora. La fase de análisis aplicó nueve criterios de comparación organizados en tres etapas: experiencias vivenciales, alianza terapéutica múltiple y proceso psicoterapéutico. Resultados. Se identificaron convergencias en la centralidad del encuentro terapéutico, el contacto interpersonal, la experiencia grupal y la transformación subjetiva del paciente, y divergencias en las bases epistemológicas, los recursos metodológicos y las formas de intervención de cada enfoque. Conclusiones. El método comparativo propuesto se presenta como una herramienta cualitativa para el análisis sistemático de enfoques psicoterapéuticos, sin establecer jerarquías entre ellos, con utilidad potencial para la formación, la supervisión y la investigación clínica. No constituye una evaluación empírica de la eficacia de los enfoques comparados.

Palabras clave: psicodrama; psicoterapia positiva; método comparado; alianza terapéutica; psicoterapia de grupo

ABSTRACT

Objective. To formulate and substantiate a comparative method for psychotherapeutic approaches—Psychodrama and Positive Psychotherapy—based on group experiential practices. Method. Qualitative study with a phenomenological and comparative orientation, grounded in the introspective-experiential epistemological approach. The documentary phase examined the historical background, epistemological and theoretical foundations, methodological resources, and core concepts of both approaches. The experiential phase systematized experiences from group workshops conducted in graduate psychotherapy training programs and in clinical practice, recorded through field notes, session protocols, and the researcher's reflective records. The analysis phase applied nine comparison criteria organized in three stages: experiential practices, multiple therapeutic alliance, and psychotherapeutic process. Results. Convergences were identified in the centrality of the therapeutic encounter, interpersonal contact, group experience, and the patient's subjective transformation, and divergences in the epistemological bases, methodological resources, and forms of intervention of each approach. Conclusions. The proposed comparative method is presented as a qualitative tool for the systematic analysis of psychotherapeutic approaches, without establishing hierarchies between them, with potential usefulness for training, supervision, and clinical research. It is not an empirical evaluation of the efficacy of the approaches compared.

Keywords: psychodrama; positive psychotherapy; comparative method; therapeutic alliance; group psychotherapy

RECIBIDO
25 de mayo de 2026

ACEPTADO
2 de octubre de 2026

PUBLICADO
30 de noviembre de 2026

CÓMO CITAR (APA 7)
Baldiviezo Álvarez, T. (2026). Método comparativo de enfoques psicoterapéuticos basado en experiencias vivenciales grupales: Psicodrama y Psicoterapia Positiva. *Ñe Renda. Territorio de la Palabra, 1*(1), 41–54.

INTRODUCCIÓN

La investigación en psicología y el ejercicio psicoterapéutico profesional exigen herramientas que permitan objetivar y estructurar la práctica clínica sin desvirtuar los procesos de subjetivación que le son constitutivos. En los programas de formación profesional de modalidad presencial, las experiencias vivenciales constituyen un componente central que sostiene tanto la formación técnica como la formación personal del terapeuta, y operan como principio organizador del conocimiento experiencial que se construye en los espacios de formación y en la práctica terapéutica (Baldiviezo Álvarez, 2018). En los enfoques psicoterapéuticos grupales, las experiencias subjetivas, relacionales y vivenciales adquieren un papel central en la construcción del conocimiento clínico, y las metodologías cualitativas de orientación fenomenológica e introspectivo-vivencial permiten aproximarse a procesos terapéuticos complejos, considerando la experiencia humana como fuente válida de conocimiento (Padrón, 2001).

En la docencia universitaria y la práctica clínica, la transmisión de la metodología de la investigación enfrenta un desafío singular: requiere una transposición didáctica que contemple no solo el "conocer" teórico, sino el "saber hacer" práctico, es decir, aprender a investigar investigando (Wainerman y Sautu, 2011). Bajo esta premisa, el investigador o el docente no es un mero ejecutor de prescripciones, sino que realiza una construcción metodológica propia (Frigerio y Diker, 2005).

Pese al desarrollo de múltiples corrientes psicoterapéuticas, el entorno académico carece con frecuencia de metodologías sistemáticas que permitan comparar las estructuras internas, las epistemologías y las técnicas de intervención de dichos enfoques en formatos grupales (Caballero et al., 2016). Esta carencia limita la formación profesional, la supervisión y la investigación experiencial en psicología clínica. La comparación entre enfoques no busca establecer jerarquías de calidad, sino ofrecer indicadores descriptivos que permitan conocerlos mejor y facilitar su comprensión para la formación y el ejercicio profesional (Baldiviezo Álvarez, 2018).

El presente artículo expone el diseño de un método comparativo aplicado a dos corrientes de relevancia contemporánea: el Psicodrama y la Psicoterapia Positiva. El Psicodrama, desarrollado por Jacob Levy Moreno, utiliza la dramatización, la espontaneidad y el encuentro terapéutico como ejes del proceso clínico (Moreno, 1975). La Psicoterapia Positiva, creada por Nossrat Peseschkian, enfatiza los recursos personales, las capacidades de afrontamiento y la comprensión transcultural de los conflictos humanos (Peseschkian, 1977). Ambos enfoques, aunque difieren en sus bases epistemológicas y sus recursos metodológicos, comparten el interés por la experiencia subjetiva, la interacción interpersonal y el proceso grupal como vías de transformación clínica.

El problema de investigación se centra en cómo estructurar una matriz de comparación metodológica y epistemológica que unifique criterios descriptivos sin alterar los supuestos ontológicos de cada escuela. La finalidad del estudio es proponer una metodología de investigación comparativa entre ambos enfoques, basada en experiencias vivenciales grupales, que ofrezca a profesionales e investigadores un modelo transparente y verificable para el análisis de la intervención psicoterapéutica grupal. El estudio no busca integrar ambos modelos ni jerarquizarlos, sino identificar convergencias, divergencias y posibilidades metodológicas derivadas de su comparación. Se guía por tres preguntas: (a) ¿qué criterios descriptivos permiten comparar el Psicodrama y la Psicoterapia Positiva sin alterar sus supuestos ontológicos y epistemológicos?; (b) ¿qué convergencias y divergencias emergen entre ambos enfoques a partir del análisis de experiencias vivenciales grupales?, y (c) ¿qué aportes ofrece el método propuesto a la formación profesional, la supervisión psicoterapéutica y la investigación clínica cualitativa?

Fundamentación epistemológica

El estudio se sustenta en el enfoque epistemológico introspectivo-vivencial desarrollado por Padrón (1994, 1998, 2001), según el cual el conocimiento científico puede construirse a partir de experiencias subjetivas, procesos de interpretación y vivencias humanas compartidas. Este enfoque privilegia la comprensión de significados, experiencias internas y simbolismos socioculturales mediante la observación participante, la convivencia, la interpretación hermenéutica y el consenso intersubjetivo (Camacho y Marcano, 2003). A diferencia del positivismo, que aspira a la objetividad mediante la separación entre sujeto y objeto, reconoce que el investigador forma parte del fenómeno que estudia y que su experiencia subjetiva constituye una fuente legítima de datos (Padrón, 2001). Esta premisa resulta pertinente en psicoterapia, donde la relación terapéutica, la contratransferencia y la implicación personal del clínico son dimensiones constitutivas del proceso de cambio (Gendlin, 1970; Riveros, 2000), y se inscribe en el giro que, desde mediados del siglo XX, ha reivindicado el valor del conocimiento experiencial frente a las pretensiones de objetividad absoluta (Denzin y Lincoln, 1994; Pérez, 2001).

En consecuencia, la investigación adopta un enfoque fenomenológico orientado a la comprensión de la experiencia vivida, en la línea de la fenomenología husserliana, que propone el retorno "a las cosas mismas", es decir, la descripción de la experiencia tal como se presenta a la conciencia, suspendiendo los juicios teóricos previos (Husserl, 1962). En este estudio, la fenomenología permite aproximarse a la experiencia de los participantes en dispositivos grupales sin reducirla a categorías preestablecidas. Para Rogers (1972), la experiencia subjetiva es el fundamento de todo conocimiento significativo, pues solo aquello que es vivido y sentido por la persona adquiere relevancia para su proceso de cambio.

El concepto de *experiencing* propuesto por Gendlin (1970) es clave para la dimensión vivencial de la propuesta. Gendlin lo define como un proceso vivido, sentido corporalmente y experimentado en interacción con el entorno: un flujo continuo de sensaciones y significados que precede a la conceptualización y constituye la base del cambio terapéutico (Riveros, 2000). A diferencia de las emociones puntuales o de los pensamientos explícitos, el *experiencing* es un proceso prerreflexivo y corporalmente anclado, accesible mediante la atención a la sensación sentida (*felt sense*).

La adscripción al enfoque introspectivo-vivencial se inscribe en la clasificación de metodologías de investigación en psicología de Montero y León (2002) y de León y Montero (2003), que distinguen el enfoque cualitativo de origen fenomenológico, hermenéutico o constructivista del enfoque cuantitativo. Las metodologías cualitativas comprenden tradiciones diversas —fenomenología, etnografía, teoría fundamentada, investigación acción, análisis narrativo—, cuya elección depende

del objeto, los objetivos y la posición epistemológica del investigador. En psicoterapia, la investigación cualitativa resulta adecuada para explorar procesos subjetivos que no se reducen a variables medibles, comprender la experiencia de los participantes desde su perspectiva y captar la singularidad de los procesos terapéuticos (Denzin y Lincoln, 1994; Martínez, 1996; Pérez, 2001).

El método comparado, por su parte, es una tradición con raíces en la educación comparada (Bereday, 1968; García Garrido, 1996; Hilker, 1964; Raventós, 1983; Velloso y Pedró, 1991) que ha sido incorporada al análisis de enfoques y dispositivos clínicos (Caballero et al., 2016; Martínez Usarralde, 2003). No consiste en la yuxtaposición de descripciones, sino en la construcción de criterios explícitos que permitan identificar convergencias, divergencias y especificidades sin reducir los enfoques a un denominador común que desvirtúe sus supuestos ontológicos (Caballero et al., 2016; Velloso y Pedró, 1991).

En síntesis, la fundamentación del estudio se articula en cuatro ejes: el enfoque introspectivo-vivencial como marco epistemológico general (Padrón, 1994, 1998, 2001); la fenomenología como perspectiva orientada a la experiencia vivida (Husserl, 1962; Rogers, 1972); el *experiencing* como categoría para acceder a la dimensión corporal y prerreflexiva de la experiencia terapéutica (Gendlin, 1970; Riveros, 2000), y el método comparado como estrategia de análisis sistemático (Bereday, 1968; Caballero et al., 2016; Velloso y Pedró, 1991).

MÉTODO

Diseño

Se trata de un estudio cualitativo, de orientación fenomenológica y comparativa, basado en experiencias vivenciales desarrolladas en contextos de psicoterapia grupal. El objeto de estudio fue la construcción de una metodología comparativa entre el Psicodrama y la Psicoterapia Positiva. El carácter comparativo se sustenta en el método comparado (Bereday, 1968; García Garrido, 1996; Hilker, 1964; Raventós, 1983; Velloso y Pedró, 1991), que exige construir criterios explícitos para identificar convergencias y divergencias sin alterar los supuestos ontológicos de cada escuela (Caballero et al., 2016; Martínez Usarralde, 2003).

Participantes y escenario

Las experiencias sistematizadas provienen de talleres grupales de Psicodrama y de Psicoterapia Positiva desarrollados en programas de formación de posgrado —la Maestría en Psicoterapia de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y la Maestría en Psicoterapia Positiva de la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz— y en la práctica psicoterapéutica. Los participantes fueron adultos vinculados a esos programas y profesionales en ejercicio clínico. Los grupos estuvieron conformados por entre 8 y 15 participantes, se desarrollaron en modalidad pre-

sencial y tuvieron una duración variable según el dispositivo. La investigadora acumula más de dos décadas de experiencia en la conducción de talleres vivenciales de Psicodrama y en experiencias formativas de Psicoterapia Positiva (Baldiviezo Álvarez, 2018). Dado el carácter cualitativo del estudio, no se buscó representatividad estadística, sino densidad experiencial y pertinencia de los casos.

Fases del método comparativo

La metodología se estructuró en tres fases consecutivas, conforme a los fundamentos del método comparado (Bereday, 1968; García Garrido, 1996; Raventós, 1983; Velloso y Pedró, 1991).

Fase documental

Consistió en la revisión, el análisis y la delimitación de los marcos teóricos y epistemológicos de ambos enfoques, en correspondencia con la fase descriptiva del método comparado (García Garrido, 1996; Raventós, 1983). Se examinaron las bases del Psicodrama —su concepción del encuentro, la espontaneidad y la acción— (Boria, 2001; Moreno, 1975) y de la Psicoterapia Positiva —basada en las capacidades humanas y el balance transcultural— (Peseschkian, 1977; Peseschkian y Remmers, 2013), en seis dimensiones: aspectos históricos, bases epistemológicas, fundamentos teóricos, recursos metodológicos, conceptos fundamentales y psicoterapia grupal.

Fase vivencial

Se centró en el procesamiento de experiencias grupales reales, diseñadas y ejecutadas según las directrices técnicas de cada enfoque, mediante su registro, seguimiento y descripción. Corresponde al nivel vivencial e introspectivo del enfoque epistemológico adoptado (Padrón, 2001) e incorporó el concepto de *experiencing*, entendido como un proceso de interacción incesante entre los sentimientos personales y corporales y los símbolos propios o del medio (Gendlin, 1970; Riveros, 2000). El registro se realizó mediante notas de campo, protocolos de sesión y registros reflexivos elaborados por la investigadora, así como mediante materiales producidos en los talleres —dibujos, narrativas y dramatizaciones registradas en video cuando hubo consentimiento—, que constituyeron el corpus del análisis.

Fase de análisis

Se organizó en tres etapas secuenciales y aplicó nueve criterios de comparación, que actúan como indicadores descriptivos, sin juicios de valor sobre la calidad de un enfoque frente al otro (Baldiviezo Álvarez, 2018; García Garrido, 1996), en concordancia con el criterio de comparación como elemento esencial del método comparado (Raventós, 1983; Velloso y Pedró, 1991). La Tabla 1 presenta las etapas y sus criterios.

Tabla 1
Etapas de análisis y criterios de comparación

Etapa	Criterios de comparación
Primera: análisis de experiencias vivenciales	1. Experiencias vivenciales grupales de Psicoterapia Positiva; 2. Experiencias vivenciales grupales de Psicodrama
Segunda: análisis de la alianza terapéutica múltiple	3. Alianza en relación con el cuerpo; 4. Alianza en relación con el síntoma; 5. Alianza en relación con el contacto entre terapeuta y paciente
Tercera: análisis del proceso psicoterapéutico	6. Fases y etapas de intervención; 7. Encuentro; 8. Resistencia; 9. Catarsis

Nota. Elaboración propia a partir de Baldiviezo Álvarez (2018).

La primera etapa desarrolló un análisis teórico y metodológico de las experiencias vivenciales de ambos enfoques, con el propósito de elevar el nivel experiencial al rango de mediación conceptual (Baldiviezo Álvarez, 2018). La segunda comparó los componentes de la alianza terapéutica múltiple —la relación terapéutica vinculada al cuerpo, al síntoma y al contacto entre terapeuta y paciente—, eje transversal de los procesos de cambio (Bordin, 1994; Horvath y Luborsky, 1993; Watson y Greenberg, 1995). La tercera comparó las fases del proceso psicoterapéutico, el encuentro —inspirado en la filosofía del Yo-Tú de Buber (1984) y central en el Psicodrama (Moreno, 1975)—, la resistencia y la catarsis, que admiten operacionalizaciones diferenciadas en cada enfoque (Peseschkian, 1977; Rosenzweig, 2002).

Análisis de los materiales

El análisis siguió un procedimiento de análisis temático comparativo en cinco momentos: (a) inmersión en los materiales mediante la lectura y relectura de registros, notas de campo y producciones de los talleres; (b) codificación inicial de segmentos significativos en relación con los nueve criterios; (c) organización en matrices comparativas que contrastaron la operacionalización de cada criterio en ambos enfoques; (d) interpretación hermenéutica de los significados emergentes, articulando la experiencia vivencial con los marcos teóricos de cada enfoque, y (e) síntesis comparativa de convergencias, divergencias y aportes del método.

Rigor y reflexividad

Se adoptaron los criterios de rigor propuestos por Martínez (1996) para la investigación en ciencias humanas (Tabla 2) y los de León y Montero (2003) y Montero y León (2002), que enfatizan la coherencia entre el objeto de estudio, el método y los resultados, así como la transparencia del procedimiento. La investigadora, que condujo los talleres analizados, ocupa una doble posición de facilitadora e investigadora; esta implicación se reconoce como constitutiva del enfoque adoptado y

como una fuente de posible sesgo interpretativo que se procuró controlar mediante el registro reflexivo.

Tabla 2

Criterios de rigor y estrategias aplicadas

Criterio	Estrategia aplicada
Credibilidad	Triangulación de fuentes (registros vivenciales, revisión documental y literatura teórica de cada enfoque); uso de registros textuales en el análisis para sustentar las interpretaciones
Transferibilidad	Descripción del contexto de los talleres, los participantes y los dispositivos empleados
Dependencia	Documentación sistemática del proceso de análisis y registro de las decisiones metodológicas
Confirmabilidad	Reflexividad crítica de la investigadora respecto de su implicación en el fenómeno y de sus posicionamientos teóricos

Nota. Elaborado a partir de Martínez (1996).

Consideraciones éticas

Los participantes fueron informados sobre los objetivos del estudio, el carácter voluntario de su participación y el uso confidencial de la información, y otorgaron su consentimiento informado por escrito para la participación y, cuando correspondió, para el registro audiovisual de las sesiones. Los materiales fueron anonimizados y resguardados de forma segura. Dado que la investigadora conducía los talleres en programas de formación en los que participaban estudiantes, se reconoce una relación asimétrica que exige garantizar que la negativa a participar en el estudio no tuviera consecuencias académicas.

RESULTADOS

Los resultados se presentan según las fases del método comparativo: documental, vivencial y de análisis.

Resultados de la fase documental

La revisión teórica evidenció diferencias epistemológicas sustantivas entre ambos enfoques. El Psicodrama se fundamenta en la espontaneidad, la creatividad, la dramatización y el encuentro terapéutico (Boria, 2001; Moreno, 1975), mientras que la Psicoterapia Positiva enfatiza los recursos personales, las capacidades de afrontamiento y el equilibrio transcultural (Peseschkian, 1977; Peseschkian y Remmers, 2013). Ambos coinciden en reconocer la importancia de la experiencia subjetiva, la interacción interpersonal y el proceso grupal (Rosenzweig, 2002). La revisión de antecedentes identificó aplicaciones del Psicodrama en contextos clínicos, educativos, comunitarios y formativos de diversos países latinoamericanos y europeos (Caballero et al., 2016), y de la Psicoterapia Positiva en contextos trans-

culturales, con énfasis en las capacidades y recursos personales (Peseschkian y Remmers, 2013). La Tabla 3 sintetiza el contraste.

Tabla 3

Matriz de contraste epistemológico y operacional entre ambos enfoques

Criterio de comparación	Psicodrama	Psicoterapia Positiva
Eje epistemológico	Filosofía del momento, la acción, el coinconsciente y la espontaneidad creadora (Moreno, 1975)	Enfoque humanista-transcultural, centrado en las capacidades y en una concepción positiva del ser humano (Peseschkian, 1977)
Dispositivo grupal	Escenario psicodramático: director, protagonista, yo auxiliares y auditorio (Boria, 2001; Moreno, 1975)	Grupo de interacción basado en las capacidades de conocer y de amar y en el modelo de balance (Peseschkian, 1977)
Fases de intervención	Caldeamiento (inespecífico y específico), acción (dramatización) y compartir (eco grupal) (Moreno, 1975)	Observación y distanciamiento, inventario, estimulación situacional, verbalización y ampliación de metas (Peseschkian, 1977)

Nota. Elaboración propia a partir de Moreno (1975), Peseschkian (1977) y Baldiviezo Álvarez (2018).

Resultados de la fase vivencial

Las experiencias grupales permitieron reconocer que el componente vivencial es central en los procesos psicoterapéuticos de ambos enfoques, que favorecen (a) la participación del paciente, (b) la expresión emocional, (c) la interacción grupal, (d) los procesos de autoconocimiento y (e) la construcción de significados subjetivos. Las experiencias vivenciales facilitaron, además, la comprensión de procesos relacionales difíciles de captar con metodologías exclusivamente descriptivas o cuantitativas (Denzin y Lincoln, 1994; Pérez, 2001). El concepto de *experiencing* resultó pertinente para describir la dimensión corporal y subjetiva de estas experiencias (Gendlin, 1970; Riveros, 2000).

Resultados de la fase de análisis

Primera etapa: experiencias vivenciales

La comparación identificó convergencias en la importancia del encuentro terapéutico, la interacción grupal y la construcción experiencial del conocimiento clínico. Las divergencias principales se asociaron a los recursos metodológicos: el Psicodrama utiliza la dramatización, la representación escénica y los roles (Boria, 2001; Moreno, 1975), mientras que la Psicoterapia Positiva privilegia recursos narrativos, reflexivos y transculturales (Peseschkian, 1977).

Segunda etapa: alianza terapéutica múltiple

Ambos enfoques consideran el vínculo terapéutico como condición del cambio clínico (Bordin, 1994; Horvath y Luborsky, 1993; Paivio y Bahr, 1998). En el Psico-

drama, el cuerpo y la dramatización ocupan un lugar central en la construcción de la alianza (Moreno, 1975); en la Psicoterapia Positiva predomina el trabajo interpretativo, reflexivo y relacional (Peseschkian, 1977). Respecto del síntoma, ambos modelos reconocen su valor comunicacional y su función en el proceso terapéutico (Poch y Ávila, 1997). En la operacionalización de la alianza, el Psicodrama emplea el cuerpo y la acción como vías de acceso al núcleo del conflicto mediante técnicas como la inversión de roles o el espejo (Boria, 2001; Moreno, 1975), mientras que la Psicoterapia Positiva recurre a la resignificación del síntoma mediante historias, metáforas y el autoanálisis de las capacidades primarias y secundarias (Peseschkian, 1977; Peseschkian y Remmers, 2013).

Tercera etapa: proceso psicoterapéutico

La comparación identificó semejanzas en las etapas relacionadas con el encuentro, la resistencia y la catarsis. En ambos enfoques, el proceso implica movilización emocional, elaboración subjetiva y transformación relacional, y supone respetar reglas que orientan los actos terapéuticos sin excluir la espontaneidad y la creatividad ni asumir una secuencia lineal y estática (Baldiviezo Álvarez, 2018). Cada modelo organiza, sin embargo, esas etapas mediante recursos técnicos diferenciados (Tabla 4).

Tabla 4

Operacionalización de los criterios clínicos de intervención en ambos enfoques

Fenómeno clínico	Psicodrama	Psicoterapia Positiva
Encuentro (criterio 7)	Tele y copresencia: relación cara a cara e inmediata, en la que los roles se vivencian en el aquí y ahora (Buber, 1984; Moreno, 1975)	Vínculo dialógico transcultural basado en la aceptación del paciente a partir de sus capacidades básicas (Peseschkian, 1977)
Resistencia (criterio 8)	Bloqueo de la espontaneidad o caldeamiento deficiente, manifestado en el cuerpo o en la imposibilidad de accionar (Moreno, 1975)	Esfuerzo adaptativo del paciente aferrado a conceptos tradicionales inconscientes (Peseschkian, 1977; Peseschkian y Remmers, 2013)
Catarsis (criterio 9)	Catarsis de integración y de acción; liberación emocional compartida en el grupo (Moreno, 1975; Rosenzweig, 2002)	Proceso paulatino de toma de conciencia, *insight* cognitivo-afectivo y reequilibrio en el modelo de balance (Peseschkian, 1977)

Nota. Elaboración propia a partir de Buber (1984), Moreno (1975), Peseschkian (1977) y Rosenzweig (2002).

Síntesis

Los resultados de las tres fases pueden sintetizarse en tres hallazgos. En cuanto a las convergencias, ambos enfoques comparten la centralidad del encuentro terapéutico, la relevancia del contacto interpersonal y la experiencia grupal como vías de transformación subjetiva, y la alianza terapéutica aparece como eje transversal. En cuanto a las divergencias, estas se concentran en las bases epistemoló-

gicas (filosofía de la acción y la espontaneidad frente a enfoque humanista-transcultural), los recursos metodológicos (dramatización y roles frente a narrativas y reflexión) y las formas de intervención (acción corporal frente a trabajo interpretativo). En cuanto al método, la propuesta permitió operacionalizar criterios descriptivos para la comparación sistemática de ambos enfoques sin reducir sus especificidades ni jerarquizarlos.

DISCUSIÓN

El estudio se propuso formular y fundamentar un método comparativo para enfoques psicoterapéuticos basado en experiencias vivenciales grupales. Los hallazgos permiten discutir tres dimensiones: la pertinencia del enfoque introspectivo-vivencial para la investigación en psicoterapia, las convergencias y divergencias entre ambos enfoques, y los aportes y limitaciones del método propuesto.

Los resultados respaldan la pertinencia del enfoque introspectivo-vivencial (Padrón, 1994, 1998, 2001) para investigaciones cualitativas sobre psicoterapia y procesos grupales. Este enfoque permitió elevar la experiencia vivencial al nivel de mediación conceptual y metodológica (Baldiviezo Álvarez, 2018), reconociendo la experiencia terapéutica como vía para la construcción de conocimiento (Gendlin, 1970; Riveros, 2000), en línea con los criterios de Martínez (1996): basar el procedimiento en observaciones sistemáticas y expresar los resultados mediante una estructura coherente. La adopción de este enfoque implica, sin embargo, una posición epistemológica explícita y no neutral: el investigador forma parte del fenómeno que estudia (Padrón, 2001). Esa implicación puede ser una fortaleza en psicoterapia, donde la relación terapéutica y la implicación del clínico son constitutivas del cambio (Gendlin, 1970; Riveros, 2000), pero exige una reflexividad crítica permanente para distinguir entre la experiencia subjetiva de la investigadora y los hallazgos que se desprenden del análisis de los materiales.

Las convergencias identificadas —centralidad del encuentro, del contacto interpersonal y de la experiencia grupal— y el papel transversal de la alianza terapéutica son consistentes con la tesis de los factores comunes en psicoterapia (Rosenzweig, 2002) y con la literatura sobre la alianza (Bordin, 1994; Horvath y Luborsky, 1993; Watson y Greenberg, 1995). Las divergencias —bases epistemológicas, recursos metodológicos y formas de intervención— no constituyen jerarquías de calidad, sino especificidades que deben respetarse en toda comparación (Caballero et al., 2016; Velloso y Pedró, 1991). Un hallazgo relevante es que ambos enfoques comparten una concepción no lineal del proceso terapéutico, que respeta la espontaneidad y la creatividad sin renunciar a una estructura que orienta los actos terapéuticos (Baldiviezo Álvarez, 2018); esta convergencia sugiere un núcleo común en la concepción del cambio que podría servir de base para el diálogo entre enfoques en la psicoterapia grupal.

Implicaciones teóricas y prácticas

En el plano teórico, el estudio propone una forma de trasladar el método comparado, de tradición pedagógica, al análisis de enfoques psicoterapéuticos, mediante criterios explícitos —experiencias vivenciales, alianza terapéutica múltiple y proceso psicoterapéutico— que pueden aplicarse a otros enfoques (Caballero et al., 2016; Martínez Usarralde, 2003). En el plano práctico, ofrece a docentes, estudiantes y supervisores una guía estructurada para examinar la práctica clínica con rigor epistemológico y favorecer la transposición didáctica del "saber hacer" en investigación psicológica (Frigerio y Diker, 2005; Wainerman y Sautu, 2011), en un campo donde la investigación cualitativa ha estado históricamente subrepresentada frente a los diseños cuantitativos (Denzin y Lincoln, 1994; Pérez, 2001). Su utilidad formativa debe, no obstante, evaluarse empíricamente.

Limitaciones

El estudio presenta limitaciones que deben reconocerse. Primera, no es un estudio empírico sobre los efectos de las modalidades comparadas: compara dos enfoques a partir de experiencias vivenciales para actualizar la metodología psicoterapéutica grupal como herramienta de trabajo (Baldiviezo Álvarez, 2018). Segunda, el artículo no informa el número de talleres ni de participantes analizados, ni reproduce fragmentos de los registros que sustentan las interpretaciones, lo que limita la posibilidad de que el lector valore la credibilidad de los hallazgos. Tercera, la implicación de la investigadora como facilitadora de los talleres, aunque constitutiva del enfoque introspectivo-vivencial, no elimina el riesgo de sesgo interpretativo, y el análisis no incluyó contraste con otros codificadores. Cuarta, el carácter situado de las experiencias impide extrapolar los resultados a otros contextos sin la debida cautela. Por último, el estudio no pretende la integración del Psicodrama y la Psicoterapia Positiva: sus resultados deben entenderse como convergencias o coincidencias, no como integraciones.

Líneas futuras

Sería pertinente aplicar el método a otros enfoques —por ejemplo, terapia cognitivo-conductual, sistémica o humanista— para evaluar su capacidad de generar indicadores descriptivos pertinentes; desarrollar estudios con diseños mixtos que evalúen los efectos de los dispositivos grupales de cada enfoque en poblaciones específicas, y explorar las implicaciones del método para la supervisión psicoterapéutica, incorporando el contraste entre varios analistas.

CONCLUSIONES

El estudio permitió elaborar una propuesta de metodología comparativa entre enfoques psicoterapéuticos basada en experiencias vivenciales grupales, organizada en una fase documental, una vivencial y una de análisis con nueve criterios de comparación.

La aplicación del método al Psicodrama y a la Psicoterapia Positiva permitió identificar convergencias en la centralidad del encuentro terapéutico, el contacto interpersonal y la experiencia grupal, y divergencias en las bases epistemológicas, los recursos metodológicos y las formas de intervención, sin reducir las especificidades de cada enfoque ni establecer jerarquías entre ellos.

La alianza terapéutica múltiple —en relación con el cuerpo, el síntoma y el contacto terapéutico— emergió como uno de los principales criterios comparativos, en consonancia con la literatura sobre factores comunes, lo que sugiere que la alianza constituye un eje que trasciende las diferencias entre enfoques.

El enfoque introspectivo-vivencial se mostró pertinente para el análisis de procesos terapéuticos subjetivos, relacionales y grupales, a condición de explicitar la implicación de la investigadora y de documentar los materiales que sustentan las interpretaciones.

El estudio no constituye una validación empírica de los efectos de las modalidades comparadas, sino una propuesta metodológica que puede orientar la formación, la supervisión y la investigación cualitativa en psicoterapia, y cuya utilidad deberá contrastarse en futuras aplicaciones a otros enfoques.

REFERENCIAS

Bereday, G. Z. F. (1968). *El método comparativo en pedagogía*. Herder.

Bordin, E. S. (1994). Theory and research on the therapeutic working alliance: New directions. En A. O. Horvath y L. S. Greenberg (Eds.), *The working alliance: Theory, research, and practice* (pp. 13–37). Wiley.

Buber, M. (1984). *Yo y tú*. Nueva Visión.

Denzin, N. K., y Lincoln, Y. S. (Eds.). (1994). *Handbook of qualitative research*. SAGE.

Frigerio, G., y Diker, G. (Comps.). (2005). *Educar: Ese acto político*. Del Estante.

García Garrido, J. L. (1996). *Fundamentos de educación comparada* (3.ª ed.). Dykinson.

Gendlin, E. T. (1970). A theory of personality change. En J. T. Hart y T. M. Tomlinson (Eds.), *New directions in client-centered therapy* (pp. 129–173). Houghton Mifflin.

Hilker, F. (1964). *La pédagogie comparée: Introduction à son histoire, sa théorie et sa pratique*.

Horvath, A. O., y Luborsky, L. (1993). The role of the therapeutic alliance in psychotherapy. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, *61*(4), 561–573. https://doi.org/10.1037/0022-006X.61.4.561

Husserl, E. (1962). *Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica* (J. Gaos, Trad.; 2.ª ed.). Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 1913)

León, O. G., y Montero, I. (2003). *Métodos de investigación en psicología y educación* (3.ª ed.). McGraw-Hill.

Martínez, M. (1996). *Comportamiento humano: Nuevos métodos de investigación*

Martínez Usarralde, M. J. (2003). *Educación comparada: Nuevos retos, renovados desafíos*. La Muralla.

Montero, I., y León, O. G. (2002). Clasificación y descripción de las metodologías de investigación en Psicología. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, *2*(3), 503–508.

Moreno, J. L. (1975). *Psicodrama*.

Paivio, S. C., y Bahr, L. M. (1998). Interpersonal problems, working alliance, and outcome in short-term experiential therapy. *Psychotherapy Research*, *8*

Peseschkian, H., y Remmers, A. (2013). *Positive Psychotherapie*.

Peseschkian, N. (1977). *Positive Psychotherapie: Theorie und Praxis einer neuen Methode*.

Rogers, C. R. (1972). *El proceso de convertirse en persona*

Rosenzweig, S. (2002). Some implicit common factors in diverse methods of psychotherapy. *Journal of Psychotherapy Integration*, *12*(1), 5–9. https://doi.org/10.1037/1053-0479.12.1.5 (Obra original publicada en 1936)

Wainerman, C., y Sautu, R. (Comps.). (2011). *La trastienda de la investigación* (4.ª ed.). Manantial.

Watson, J. C., y Greenberg, L. S. (1995). Alliance ruptures and repairs in experiential therapy. *In Session: Psychotherapy in Practice*, *1*

Este artículo se publica en acceso abierto bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0).

Territorio de la Palabra
REVISTA ACADÉMICA DE PSICOLOGÍA
CARRERA DE PSICOLOGÍA · UAGRM
SANTA CRUZ DE LA SIERRA · BOLIVIA

Vol. 1, N.° 1 (2026) · pp. 55–68
CC BY-NC 4.0

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN · ESTUDIANTES

Estrés laboral en fuerzas del orden: dimensiones organizacionales y lectura sistémica en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Occupational stress in law enforcement personnel: Organizational dimensions and a systemic reading in Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Rafael Mauricio Ribera Jiménez[1*]

[1] Carrera de Psicología, Facultad de Humanidades, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
* Correspondencia: riberajrafaelm99@outlook.com

RESUMEN

Objetivo. Describir los niveles de estrés laboral y la distribución de sus dimensiones en sargentos y suboficiales de una unidad de orden de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, durante la gestión 2025. Método. Estudio cuantitativo, no experimental y transversal. Se aplicó la Escala de Estrés Laboral de la OIT/OMS, adaptada por Suárez Tunanñaña (2013), a 56 participantes seleccionados por muestreo no probabilístico por cuotas. Se calcularon frecuencias, correlación de Pearson, prueba t de Student, análisis de varianza y alfa de Cronbach (SPSS v. 26). Resultados. El 80,36 % presentó nivel bajo de estrés, el 17,86 % intermedio y el 1,79 % alto. El porcentaje del puntaje total aportado por cada dimensión reprodujo casi exactamente su proporción de ítems, por lo que no permite identificar dimensiones más afectadas. No hubo diferencias significativas según sexo (p = ,680; d = −0,18), contraste de potencia muy baja por el reducido grupo femenino; la comparación por grado jerárquico fue exploratoria. La edad se correlacionó de forma positiva y moderada con el estrés (r = ,35; IC 95 % [0,10; 0,56]; p = ,008). Conclusiones. Predominó el estrés bajo, con casos intermedios y altos que justifican atención preventiva; la asociación con la edad no admite interpretación causal. La perspectiva sistémica se usa solo como lente interpretativa de segundo orden, porque los datos provienen de un instrumento individual: sus lecturas se presentan como hipótesis y no como resultados del diseño.

Palabras clave: estrés laboral; fuerzas del orden; dimensiones organizacionales; escala OIT/OMS; salud ocupacional

ABSTRACT

Objective. To describe occupational stress levels and the distribution of its dimensions among sergeants and non-commissioned officers of a public order unit in Santa Cruz de la Sierra, Bo-

livia, during 2025. Method. Quantitative, non-experimental, cross-sectional study. The ILO/WHO Occupational Stress Scale, adapted by Suárez Tunanñaña (2013), was administered to 56 participants selected through non-probabilistic quota sampling. Frequencies, Pearson correlation, Student's t test, analysis of variance, and Cronbach's alpha were computed (SPSS v. 26). Results. Overall, 80.36 % of participants showed low stress, 17.86 % intermediate stress, and 1.79 % high stress. The share of the total score contributed by each dimension almost exactly mirrored its proportion of items and therefore does not identify the most affected dimensions. No significant difference was found by sex ($p = .680$; $d = -0.18$), a very low-powered comparison due to the small female group; the comparison by rank was exploratory. Age correlated positively and moderately with stress ($r = .35$, 95 % CI [0.10, 0.56], $p = .008$). Conclusions. Low stress predominated, with intermediate and high cases that warrant preventive attention; the association with age does not support a causal interpretation. The systemic perspective is used only as a second-order interpretive lens, because data come from an individual instrument: its readings are presented as hypotheses, not as results of the design.

Keywords: occupational stress; law enforcement personnel; organizational dimensions; ILO/WHO scale; occupational health

RECIBIDO
7 de junio de 2026

ACEPTADO
2 de octubre de 2026

PUBLICADO
30 de noviembre de 2026

CÓMO CITAR (APA 7)
Ribera Jiménez, R. M. (2026). Estrés laboral en fuerzas del orden: dimensiones organizacionales y lectura sistémica en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. *Ñe Renda. Territorio de la Palabra, 1*(1), 55–68.

INTRODUCCIÓN

El estrés laboral constituye una problemática psicosocial relevante por su impacto potencial en la salud de los trabajadores y en el funcionamiento de las organizaciones. La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2016) lo relaciona con las exigencias del entorno laboral y los recursos disponibles para afrontarlas, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2023a, 2023b) destaca su relevancia para la salud y el bienestar en el trabajo. Estudios recientes también han examinado la relación entre estrés, clima organizacional y salud mental en distintos contextos laborales (Barrera Pintado y Baculima Suárez, 2024; Chiang Vega et al., 2022; Segura Lozano et al., 2025). En las fuerzas del orden, esta problemática adquiere particular relevancia debido a la exposición a demandas operativas, situaciones de riesgo, presión social y exigencias organizacionales. La revisión de Violanti et al. (2017) documenta asociaciones entre los estresores del trabajo policial —organizacionales, de turnos y traumáticos— y resultados adversos de salud mental y física, y advierte que el predominio de diseños transversales en este campo impide establecer causalidad.

Investigaciones internacionales y regionales evidencian la naturaleza multifactorial del estrés en cuerpos vinculados a la seguridad pública. En España, Talavera

Velasco (2017) reportó que el 48,4 % de los policías municipales de Madrid percibía estrés operativo intermedio. En Ecuador, Mongón Vega y Mejía Rubio (2023) hallaron que el 78,4 % de los integrantes de las fuerzas del orden presentaba bajo riesgo de estrés, pero el 12 % registraba niveles altos. En Perú, Chancahuaña Lizana (2025) identificó que el 58,3 % de los policías de carretera del norte de Lima presentaba estrés elevado en dimensiones organizacionales, y en Costa Rica, Jiménez Alfaro y Valverde Ceciliano (2024) documentaron que el 96,6 % de los efectivos había experimentado síntomas de estrés laboral. La revisión de Queirós et al. (2020), que identificó 108 estudios sobre estrés y agotamiento en policías de numerosos países, muestra además que pocos emplean cuestionarios específicos del trabajo policial, lo que dificulta comparar prevalencias entre estudios que usan instrumentos distintos.

En Bolivia, estudios en La Paz (García Choquetopa, 2016; Claure Torrez, 2011) y Oruro (Valencia Espejo, 2021) han documentado indicadores de agotamiento emocional, despersonalización y percepción generalizada del estrés como factor que compromete el desempeño institucional. No obstante, en Santa Cruz de la Sierra no se identificaron investigaciones previas que aborden sistemáticamente el estrés laboral en una unidad de orden, brecha que limita el diseño de estrategias preventivas adaptadas a sus particularidades.

Marco teórico y conceptual

Modelos explicativos del estrés laboral

La OIT (2016) define el estrés laboral como la respuesta que se produce cuando las exigencias del entorno superan las capacidades, recursos o necesidades del trabajador. El modelo transaccional (Camacho Gómez et al., 2024) plantea que el estrés emerge de la evaluación cognitiva sobre si una situación supera los recursos de afrontamiento del individuo, lo que explica las variaciones individuales en la percepción de las dimensiones organizacionales. El modelo de ajuste persona–ambiente (Medina Falero, 2018) sostiene que el estrés surge de la incongruencia entre las características subjetivas del trabajador y las condiciones objetivas del entorno; cuando esta incompatibilidad es persistente, se desencadenan tensiones psicológicas y fisiológicas que pueden derivar en enfermedad.

El modelo de demandas–control–apoyo (Karasek, 1979; Martínez Mejía, 2022) propone que el estrés resulta de la combinación de altas demandas laborales y escaso control del trabajador, agravada por apoyo social deficiente. Desde este modelo, un clima organizacional adverso y una estructura rígida amplifican el estrés, mientras la cohesión grupal opera como factor protector. El modelo de desequilibrio esfuerzo–recompensa (Siegrist, 1996; Villarreal Villanueva, 2023) explica el estrés como resultado de la disparidad entre el esfuerzo invertido y las recompen-

sas recibidas, especialmente pronunciado en estructuras jerárquicas rígidas como las instituciones policiales.

La teoría de demandas y recursos laborales (Bakker y Demerouti, 2017) integra los modelos anteriores al distinguir entre demandas, que consumen energía, y recursos, que la amortiguan; entre estos últimos se cuentan el apoyo del supervisor y de los compañeros. Este marco permite leer las dimensiones de influencia del líder, cohesión y respaldo del grupo de la Escala OIT/OMS como recursos laborales, y ofrece un puente contrastable entre los modelos individuales y la lectura sistémica que se expone en el apartado siguiente.

Enfoque sistémico como lente interpretativa

El enfoque sistémico se incorpora en este estudio como una lente interpretativa de segundo orden, no como paradigma metodológico de recolección o análisis de datos. Esta precisión es necesaria porque el diseño es cuantitativo, no experimental y transversal, y el instrumento utilizado recoge percepciones individuales mediante una escala de autorreporte. Desde esta posición, los conceptos sistémicos permiten formular hipótesis interpretativas sobre la posible relación entre dimensiones organizacionales, sin presentarlas como relaciones causales demostradas por el estudio (Garibay Rivas, 2013).

Dentro de esta lectura, la totalidad permite considerar que las percepciones individuales se producen en interacción con diferentes niveles del contexto institucional; la homeostasis describe la tendencia de los sistemas a conservar determinados patrones, y la causalidad circular permite plantear que ciertas dinámicas relacionales podrían retroalimentarse. Estos conceptos no fueron operacionalizados ni medidos directamente, por lo que su uso en el presente artículo se limita a la interpretación posterior de los hallazgos.

De manera complementaria, conceptos como doble vínculo e isomorfismo pueden orientar preguntas para investigaciones posteriores, especialmente cuando existan diseños capaces de observar directamente interacciones, comunicación y patrones relacionales. En consecuencia, la perspectiva sistémica no constituye una explicación empíricamente contrastada en este estudio, sino una propuesta interpretativa que permite contextualizar los resultados organizacionales y generar líneas de investigación futura.

Dimensiones del estrés laboral según la Escala OIT/OMS

La Escala de Estrés Laboral de la OIT/OMS operacionaliza el fenómeno en siete dimensiones. En el presente estudio, estas dimensiones se analizaron como variables organizacionales percibidas individualmente. El clima organizacional refleja la percepción del ambiente interno —motivación, confianza y comunicación— (Chiavenato, 2019; Olaz Capitán, 2024). La estructura organizacional comprende las reglas formales y los canales de autoridad (Pineda Pizarro y Erazo Álvarez,

2021). La influencia del líder refiere a la capacidad del mando para orientar y generar pertenencia institucional (Alles, 2009). La falta de cohesión expresa la ausencia de unidad y colaboración grupal (Paredes Saavedra, 2013); el territorio organizacional integra las dimensiones espaciales y sociales de las interacciones (López Figueroa, 2020); la tecnología comprende los recursos técnicos disponibles (Jones, 2008), y el respaldo del grupo da cuenta del apoyo entre pares (Herrero Olaizola, 2019). Las siete dimensiones son de naturaleza organizacional y relacional: la escala no mide estresores operativos, como el riesgo, el tránsito o la confrontación con la ciudadanía. La eventual lectura sistémica de estas dimensiones se reserva para la discusión y se formula como hipótesis interpretativa.

Objetivos del estudio

En consecuencia, la presente investigación se propuso describir los niveles de estrés laboral y de sus dimensiones en integrantes de las fuerzas del orden de los grados de sargentos y suboficiales de una unidad de orden de Santa Cruz de la Sierra durante la gestión 2025. Los objetivos específicos fueron: (a) evaluar los niveles globales de estrés laboral; (b) describir la distribución del puntaje entre las siete dimensiones del instrumento, y (c) explorar la relación entre variables sociodemográficas —edad, sexo y grado jerárquico— y los niveles de estrés. El estudio se justifica teóricamente al aportar evidencia empírica en un campo escasamente explorado en Bolivia y, de manera aplicada, al orientar acciones de salud ocupacional y bienestar institucional.

MÉTODO

Diseño

La investigación adoptó un enfoque cuantitativo-positivista con diseño no experimental, transversal y de campo. Es no experimental porque las variables no fueron manipuladas; transversal porque la recolección de datos se efectuó en un único momento temporal, y de campo porque la información se obtuvo directamente en el contexto laboral de los participantes (Hernández Sampieri et al., 2014; Arias González y Covinos Gallardo, 2021). El alcance es descriptivo-correlacional: busca caracterizar los niveles de estrés laboral y la distribución de sus dimensiones y explorar su relación con variables sociodemográficas, sin establecer causalidad. En términos de las guías internacionales de reporte, corresponde a un estudio observacional transversal (STROBE) con medición por autoinforme. La perspectiva sistémica no intervino en la selección de la muestra, la aplicación del instrumento ni el análisis estadístico; se utiliza únicamente como lente interpretativa posterior.

Participantes

La población objetivo estuvo conformada por integrantes de las fuerzas del orden de los grados jerárquicos de sargentos y suboficiales destinados en una unidad de orden de Santa Cruz de la Sierra. Debido a restricciones logísticas que impidieron acceder al universo total, se recurrió a un muestreo no probabilístico por cuotas, condicionado por la disponibilidad de participantes durante el receso institucional (13:00 h). La muestra final fue de 56 participantes. La distribución por sexo fue 89,29 % masculino y 10,71 % femenino, con una edad promedio de 40,11 años (DE = 12,16). No se realizó un cálculo previo del tamaño muestral, por lo que los análisis inferenciales deben interpretarse considerando la disponibilidad de la muestra y el reducido tamaño de algunos subgrupos. Como análisis de sensibilidad, con 50 hombres y 6 mujeres la comparación por sexo tenía una potencia aproximada de 0,21 para detectar un efecto de tamaño medio (d = 0,5) y solo alcanzaba una potencia de 0,80 ante efectos de $d \geq 1{,}23$; la correlación entre edad y estrés, con n = 56, alcanzaba una potencia aproximada de 0,76 para un coeficiente de la magnitud observada. Estas estimaciones no sustituyen un cálculo de potencia a priori.

Instrumento

Se utilizó la Escala de Estrés Laboral de la OIT/OMS adaptada al español por Suárez Tunanñaña (2013). El instrumento consta de 25 ítems valorados en escala Likert de 1 (nunca) a 7 (siempre), que miden siete dimensiones: clima organizacional (ítems 1, 10, 11, 20), estructura organizacional (2, 12, 16, 24), territorio organizacional (3, 15, 22), tecnología (4, 14, 25), influencia del líder (5, 6, 13, 17), falta de cohesión (7, 9, 18, 21) y respaldo del grupo (8, 19, 23). El puntaje total oscila entre 25 y 175 puntos. Los niveles de interpretación global son: bajo (≤ 90,2 puntos), intermedio (90,3–117,2), estrés (117,3–153,2) y alto (≥ 153,3). La adaptación peruana reportó α = 0,966 (Suárez Tunanñaña, 2013). Esa adaptación se realizó con trabajadores de 25 a 35 años de un *contact center* de Lima, por lo que su aplicabilidad a integrantes de las fuerzas del orden de mayor rango de edad no está establecida.

Procedimiento y análisis de datos

Previa autorización institucional y obtención del consentimiento informado, la escala fue administrada colectivamente durante el receso operativo. Los datos fueron digitalizados en Microsoft Excel y procesados con SPSS v. 26 (IBM). El análisis estadístico incluyó: (a) análisis descriptivo mediante frecuencias y porcentajes; (b) correlación de Pearson para explorar la relación entre edad y nivel de estrés; (c) prueba t de Student para comparar niveles de estrés según sexo, con verificación de homogeneidad de varianzas mediante la prueba de Levene; (d) análisis de

varianza para explorar diferencias según grado jerárquico, y (e) confiabilidad mediante alfa de Cronbach. Se adoptó $\alpha = 0{,}05$. La consistencia interna de la muestra principal fue $\alpha = 0{,}928$; el pilotaje previo ($n = 25$; $\alpha = 0{,}938$) se reporta únicamente como antecedente, ya que la documentación disponible no permite establecer si los participantes del piloto coincidieron con los de la muestra principal. Como tamaños del efecto se informan la d de Cohen (comparación por sexo), el intervalo de confianza del coeficiente de Pearson, estimado mediante la transformación de Fisher, y η^2 (comparación por grado). El análisis por grado jerárquico se consideró exploratorio por la presencia de subgrupos pequeños, incluida una categoría con $n = 1$. Como análisis de sensibilidad, los grados se reagruparon en sargentos ($n = 39$) y suboficiales ($n = 17$) y se compararon a partir de las medias y desviaciones estándar por grado registradas en la tesis de la que procede el estudio. Ese cálculo es aproximado, porque se basa en estadísticas agregadas y redondeadas, y no sustituye un análisis con la base de datos individual.

Consideraciones éticas

En relación con los aspectos éticos, el estudio contó con la autorización institucional correspondiente y con el consentimiento informado de los participantes. No se contó con un dictamen previo de un comité de ética o bioética para la ejecución del estudio. En su lugar, se aplicaron medidas de resguardo orientadas a garantizar la participación voluntaria, la confidencialidad y el anonimato de los participantes. El instrumento no incorporó identificadores personales y la información obtenida fue utilizada exclusivamente con fines académicos y científicos. Asimismo, los participantes fueron informados sobre el propósito del estudio y su derecho a participar de manera voluntaria.

RESULTADOS

Características sociodemográficas

El 30,36 % de los participantes tenía entre 41 y 50 años; el 28,57 %, entre 20 y 30 años; el 23,21 %, entre 51 y 60 años; el 16,07 %, entre 31 y 40 años, y el 1,79 %, entre 61 y 65 años. El 89,29 % correspondió al sexo masculino y el 10,71 % al femenino. La distribución por grados mostró predominancia del grado de Sargento (26,79 %), seguido del Suboficial Segundo (21,43 %) y Sargento Primero (17,86 %).

Niveles globales de estrés laboral

La Tabla 1 presenta la distribución de los participantes por nivel global de estrés. Ningún participante alcanzó la categoría de “estrés” (117,3–153,2 puntos). La media global fue $M = 68{,}36$ ($DE = 27{,}77$), en el tramo inferior del rango teórico de la escala (25–175).

Tabla 1

Distribución de los participantes según nivel global de estrés laboral

Nivel	Rango de puntaje	*n*	%
Bajo	≤ 90,2	45	80,36
Intermedio	90,3–117,2	10	17,86
Estrés	117,3–153,2	0	0,00
Alto	≥ 153,3	1	1,79
Total		56	100,00

Nota. $N = 56$. Puntos de corte según Suárez Tunanñaña (2013).

Distribución del puntaje entre dimensiones

El porcentaje del puntaje total aportado por cada dimensión fue: influencia del líder, 17 %; clima organizacional, estructura organizacional y falta de cohesión, 16 % cada una; respaldo del grupo, 13 %; tecnología, 12 %, y territorio organizacional, 10 %. Como el instrumento asigna cuatro ítems a cuatro dimensiones y tres ítems a las otras tres, la proporción esperada si todos los ítems se puntuaran igual es del 16 % y del 12 %, respectivamente. La Tabla 2 compara ambos valores: las diferencias no superan los dos puntos porcentuales, por lo que este indicador no permite afirmar que unas dimensiones estén más afectadas que otras. No se dispone de las medias por ítem de cada dimensión, que serían el indicador adecuado para esa comparación.

Tabla 2

Peso relativo observado y esperado de cada dimensión en el puntaje total

Dimensión	Ítems	Peso observado (%)	Peso esperado por número de ítems (%)	Diferencia (puntos porcentuales)
Influencia del líder	4	17	16	+1
Clima organizacional	4	16	16	0
Estructura organizacional	4	16	16	0
Falta de cohesión	4	16	16	0
Respaldo del grupo	3	13	12	+1
Tecnología	3	12	12	0
Territorio organizacional	3	10	12	−2

Nota. Peso esperado = número de ítems de la dimensión / 25 × 100. Los pesos observados están redondeados a la unidad.

Estrés laboral y variables sociodemográficas

Respecto al sexo, el grupo masculino ($n = 50$) obtuvo $M = 67{,}82$ ($DE = 28{,}86$) y el femenino ($n = 6$), $M = 72{,}83$ ($DE = 17{,}11$). La prueba de Levene no detectó diferencias

significativas en la varianza (F = 2,900; p = ,094). La prueba t de Student no mostró una diferencia estadísticamente significativa, $t(54) = -0{,}42$; p = ,680; $d = -0{,}18$; IC 95 % de la diferencia de medias [−29,25; 19,23]. Este resultado no debe interpretarse como evidencia de ausencia de efecto, especialmente por el reducido tamaño del grupo femenino.

La correlación de Pearson evidenció una asociación positiva y estadísticamente significativa entre la edad y el nivel total de estrés, $r(54)$ = ,35; p = ,008; IC 95 % [0,10; 0,56]. Esto indica una asociación moderada en la muestra, sin permitir establecer causalidad. El análisis de varianza según los ocho grados jerárquicos no mostró diferencias estadísticamente significativas, $F(7, 48) = 1{,}288$; p = ,276; η^2 = , 16. Debido a que una categoría contó con un solo participante y otras presentaron tamaños reducidos, este resultado se considera exploratorio y no permite establecer conclusiones sobre categorías individuales. Al reagrupar los grados en sargentos (n = 39) y suboficiales (n = 17), la comparación aproximada fue igualmente no significativa, $t(54) \approx -0{,}11$; $p \approx ,910$; $d \approx -0{,}03$.

DISCUSIÓN

Lectura general de los resultados

Los hallazgos muestran que, en la muestra estudiada, la distribución global del estrés fue predominantemente baja (80,36 %), en las dimensiones organizacionales y relacionales que mide la escala. Este resultado es consistente con Mongón Vega y Mejía Rubio (2023) en Ecuador (78,4 %), aunque contrasta con Costa Rica (96,6 % con síntomas de estrés; Jiménez Alfaro y Valverde Ceciliano, 2024) y Lima, donde Chancahuaña Lizana (2025) reportó estrés elevado en dimensiones organizacionales. Estas diferencias deben interpretarse considerando las características institucionales, ocupacionales y contextuales de cada población, y también que los estudios emplean instrumentos y puntos de corte distintos, una heterogeneidad que Queirós et al. (2020) identifican como obstáculo general para comparar el estrés policial entre investigaciones.

La distribución del puntaje entre dimensiones no permite identificar una dimensión crítica (véase la Tabla 2). La influencia del líder y el respaldo del grupo superaron en un punto su peso esperado, una diferencia demasiado pequeña, y sin medida de dispersión, para interpretarla como hallazgo. Si se confirmara con medias por ítem, podría relacionarse con el desequilibrio esfuerzo–recompensa y con el modelo de demandas–control–apoyo. Asimismo, estudios sobre clima organizacional y estrés han señalado la relevancia de las condiciones relacionales y organizacionales para comprender el bienestar laboral (Chiang Vega et al., 2022). No obstante, las asociaciones causales entre estas condiciones y el estrés no fueron evaluadas mediante el diseño empleado.

La ausencia de evidencia estadística de diferencias según sexo, $t(54) = -0{,}42$; $p = {,}680$; $d = -0{,}18$, debe interpretarse con cautela: con seis mujeres, la comparación solo tenía potencia suficiente para detectar diferencias muy grandes ($d \geq 1{,}23$), por lo que el resultado no permite concluir que el sexo carezca de relación con el estrés. De manera similar, el análisis por grado jerárquico no mostró diferencias significativas, pero las categorías pequeñas reducen la precisión de esa comparación. En contraste, la asociación positiva entre edad y estrés ($r = {,}35$; $p = {,}008$) constituye evidencia de relación en esta muestra, sin implicar causalidad. Este hallazgo puede discutirse desde el modelo de desequilibrio esfuerzo–recompensa, que sitúa el control de estatus y las perspectivas de ascenso entre las recompensas (Siegrist, 1996): los integrantes con mayor trayectoria podrían percibir que su esfuerzo acumulado no se corresponde con recompensas proporcionales. La interpretación es explicativa y no está demostrada por el diseño, que tampoco permite distinguir un efecto de la edad de uno de cohorte o de antigüedad en el cargo, variable que no se registró.

Lectura sistémica como hipótesis interpretativa

Como lectura de segundo orden, la perspectiva sistémica permite formular hipótesis sobre la posible relación entre liderazgo, cohesión grupal y clima organizacional. Bajo la lógica de la causalidad circular, podría plantearse que las tensiones en el estilo de liderazgo debiliten la cohesión y la percepción del clima y que, a su vez, una cohesión debilitada condicione el ejercicio del liderazgo, mientras la estructura organizacional delimita las reglas en que esas interacciones ocurren. Esta circularidad no fue medida: los datos proceden de percepciones individuales recogidas en un único momento y no contienen información sobre interacciones ni secuencias temporales.

Del mismo modo, la ausencia de diferencias significativas según sexo y grado no puede leerse como un "patrón de invarianza" que indique una cultura sistémica compartida o un isomorfismo: con grupos de tamaño insuficiente, un resultado no significativo no demuestra igualdad. La asociación entre edad y estrés admite, como hipótesis, una lectura de trayectoria acumulada en la interfaz sujeto–organización, compatible con la interpretación desde el modelo esfuerzo–recompensa expuesta en la lectura general de los resultados.

Para contrastar estas hipótesis se requieren diseños relacionales o longitudinales —por ejemplo, mediciones repetidas de liderazgo, cohesión y clima, o análisis de redes dentro de la unidad— que la teoría de demandas y recursos laborales (Bakker y Demerouti, 2017) permite formular en términos verificables.

Implicaciones teóricas y prácticas

En el plano teórico, el estudio aporta una descripción inicial del estrés organizacional en una unidad de orden boliviana no estudiada antes y advierte que, con la Escala OIT/OMS, el porcentaje del puntaje total por dimensión no sirve para jerarquizar dimensiones; futuros estudios con este instrumento deberían informar medias por ítem. También propone una hipótesis de circularidad entre liderazgo, cohesión y clima, contrastable desde la teoría de demandas y recursos laborales. En términos aplicados, los resultados respaldan la pertinencia de fortalecer la formación en liderazgo, los espacios de cohesión grupal y las estrategias de reconocimiento institucional, en especial para el personal de mayor edad, procurando intervenir sobre las relaciones y condiciones organizacionales sin reducir el problema exclusivamente al individuo. Una intervención específicamente sistémica deberá evaluar directamente patrones de interacción, comunicación, jerarquías y retroalimentación dentro de la unidad de orden, y su eficacia deberá establecerse con mediciones antes y después.

Limitaciones

Entre las limitaciones destacan: (a) el muestreo no probabilístico por cuotas y disponibilidad, que restringe la generalización más allá de la muestra estudiada; (b) el diseño transversal, que impide establecer causalidad o rastrear cambios longitudinales, limitación que Violanti et al. (2017) señalan como predominante en la investigación sobre estrés policial; (c) la especificidad del contexto institucional, y (d) la presencia de subgrupos jerárquicos pequeños, que limita la interpretación del análisis de varianza por categoría. A ello se suman: (e) el uso de un instrumento adaptado en trabajadores de *contact center*, no validado en fuerzas del orden y que no mide estresores operativos; (f) la medición por autoinforme en un contexto jerárquico, donde la deseabilidad social podría haber reducido los puntajes; (g) la ausencia de medias por ítem por dimensión, y (h) la ausencia de dictamen de un comité de ética independiente de la institución, cuando la autorización procede de la misma cadena de mando a la que pertenecen los participantes. Además, la perspectiva sistémica no fue operacionalizada en la recolección ni en el análisis estadístico, por lo que sus aportes en este artículo son exclusivamente interpretativos. Futuras investigaciones deberían ampliar el tamaño muestral, utilizar criterios de muestreo que permitan mayor representatividad, incorporar diseños longitudinales y, si se desea contrastar la perspectiva sistémica, incluir métodos capaces de observar directamente las interacciones y patrones relacionales.

CONCLUSIONES

El presente estudio constituye una aproximación al estrés laboral en integrantes de las fuerzas del orden de una unidad de orden de Santa Cruz de la Sierra. Los hallazgos permiten establecer cuatro conclusiones. Primera: los niveles globales de estrés laboral fueron predominantemente bajos (80,36 %), aunque se identificaron participantes en niveles intermedio y alto que justifican atención preventiva. Segunda: el porcentaje del puntaje total por dimensión reproduce la proporción de ítems de cada una, por lo que con los datos disponibles no es posible identificar dimensiones más afectadas; la influencia del líder y el respaldo del grupo muestran desvíos mínimos que justifican estudiarlas con indicadores adecuados. Tercera: no se obtuvo evidencia estadística de diferencias según sexo ni según las categorías jerárquicas analizadas; sin embargo, las limitaciones de tamaño de algunos subgrupos obligan a interpretar estos resultados con cautela. Asimismo, se identificó una asociación positiva entre edad y estrés (r = ,35; p = ,008), sin que el diseño permita establecer una relación causal. Cuarta: desde una perspectiva sistémica, empleada como lente interpretativa, el estrés laboral puede comprenderse no solo como una experiencia individual, sino también como un fenómeno inserto en patrones de interacción y comunicación. Se plantea como hipótesis una retroalimentación circular entre el estilo de liderazgo, la cohesión de los equipos y la percepción del clima, que no fue medida y que traza una ruta para futuras investigaciones empíricas con diseños relacionales.

En términos aplicados, los resultados respaldan la pertinencia de fortalecer la formación en liderazgo, los espacios de cohesión grupal y las estrategias de reconocimiento institucional. Estas recomendaciones corresponden a una aplicación organizacional de los hallazgos. Cualquier intervención específicamente sistémica deberá considerarse una propuesta para investigación e intervención futura y deberá evaluar directamente patrones de interacción, comunicación y retroalimentación dentro de la unidad de orden.

REFERENCIAS

Alles, M. (2009). *Nuevo enfoque: Diccionario de competencias*. Granica.

Arias González, J. L., y Covinos Gallardo, M. (2021). *Diseño y metodología de la investigación*. Biblioteca Nacional del Perú.

Bakker, A. B., y Demerouti, E. (2017). Job demands–resources theory: Taking stock and looking forward. *Journal of Occupational Health Psychology*, *22*(3), 273–285. https://doi.org/10.1037/ocp0000056

Barrera Pintado, J. E., y Baculima Suárez, J. A. (2024). Efectos del estrés laboral en la salud física y mental de trabajadores de la salud. *Cienciamatria*, *10*(1), 284–306. https://doi.org/10.35381/cm.v10i1.1223

Camacho Gómez, O., Pedroza Cabrera, F. J., Navarro Contreras, G., de la Roca Chiapas, J. M., y Fulgencio Juárez, M. (2024). Modelo transaccional del estrés y estilos de afrontamiento en investigación psicológica del estrés: Análisis crítico. *UARICHA Revista Psicológica*, *22*, 42–53. https://doi.org/10.35830/kcgm5244

Chancahuaña Lizana, L. A. (2025). *Satisfacción laboral y estrés laboral en policías de carreteras de Lima Norte, 2025* [Tesis]. Universidad Autónoma de Ica.

Chiang Vega, M. M., Sanhueza Hernández, C., y Rivera Cerda, M. J. (2022). Clima organizacional, ¿afecta al estrés laboral? Comparación entre funcionarios de la salud y seguridad pública. *Revista Academia & Negocios*, *8*(1), 43–54. https://doi.org/10.29393/RAN8-6COMM30006

Chiavenato, I. (2019). *Administración de recursos humanos* (10.ª ed.). McGraw-Hill.

Claure Torrez, C. R. (2011). *Síndrome de burnout y desempeño laboral en policías vigilantes del recinto penitenciario San Pedro de la ciudad de La Paz, Bolivia* [Tesis de licenciatura]. Universidad Mayor de San Andrés.

García Choquetopa, M. (2016). *El síndrome de burnout y desempeño laboral en policías de la Unidad de Solución Temprana de la FELCC de la ciudad de La Paz* [Tesis de licenciatura]. Universidad Mayor de San Andrés.

Garibay Rivas, S. (2013). *Enfoque sistémico: Una introducción a la psicoterapia familiar* (2.ª ed.). Manual Moderno.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, M. del P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill.

Herrero Olaizola, J. (2019). *Bases conceptuales en el estudio de los grupos*. FUOC. https://openaccess.uoc.edu/server/api/core/bitstreams/3cdf961e-34b9-455d-a5e5-732064348726/content

Jiménez Alfaro, D., y Valverde Ceciliano, S. (2024). Estrés laboral en policías de la Delegación Policial El Carmen en Costa Rica: Una propuesta psicoeducativa de primeros auxilios psicológicos. *Revista Fidélitas*, *5*(2), 35–41. https://doi.org/10.46450/revistafidelitas.v5i2.78

Jones, G. R. (2008). *Teoría organizacional: Diseño y cambio en las organizaciones* (7.ª ed.). Pearson Educación.

Karasek, R. A. (1979). Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for job redesign. *Administrative Science Quarterly*, *24*(2), 285–308. https://doi.org/10.2307/2392498

López Figueroa, J. C. (2020). Pensar el territorio desde los estudios organizacionales: Conversaciones para el análisis organizacional en la dimensión espacial. *Innovar*, *31*(79), 89–101.

Martínez Mejía, E. (2022). Modelos de estrés laboral: Funcionamiento e implicaciones para el bienestar psicosocial en las organizaciones. *Revista Electrónica de Psicología de la FES Zaragoza-UNAM*, *12*(24), 17–28.

Medina Falero, N. de. (2018). *Ajuste persona-entorno laboral y su relación con la satisfacción laboral y la satisfacción vital* [Trabajo de fin de grado]. Universidad de La Laguna.

Mongón Vega, A. M., y Mejía Rubio, A. del C. (2023). Estrés laboral y consumo de alcohol en servidores policiales. *Revista Ecuatoriana de Psicología*, *6*(14), 7–18. https://doi.org/10.33996/repsi.v6i14.85

Olaz Capitán, Á. (2024). Definiendo el clima laboral: 100 años de revisión bibliográfica. *Revista Internacional de Organizaciones.*

Organización Internacional del Trabajo. (2016). *Estrés en el trabajo: Un reto colectivo*. OIT.

Organización Mundial de la Salud. (2023a). *Estrés*. https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/stress

Organización Mundial de la Salud. (2023b). *Salud mental en el trabajo*. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-at-work

Paredes Saavedra, M. (2013). Cohesión de equipos de trabajo y clima laboral percibido por los empleados de la Universidad de Montemorelos. *Apuntes Universitarios*, *3*(2), 39–56.

Pineda Pizarro, V. P., y Erazo Álvarez, J. C. (2021). La estructura organizacional y su relación con los procesos administrativos en instituciones educativas privadas. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, *6*(12), 37–68. https://doi.org/10.35381/r.k.v6i12.1272

Queirós, C., Passos, F., Bártolo, A., Marques, A. J., da Silva, C. F., y Pereira, A. (2020). Burnout and stress measurement in police officers: Literature review and a study with the Operational Police Stress Questionnaire. *Frontiers in Psychology*, *11*, Artículo 587. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00587

Segura Lozano, X., Flores Álvarez, L. N., Fuantos Núñez, J. T., Cruz Pecina, H. E., y Peña López, J. E. (2025). Impacto del estrés laboral prolongado en la salud mental de los trabajadores en entornos organizacionales. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, *6*(3), 2084–2096. https://doi.org/10.56712/latam.v6i3.4095

Siegrist, J. (1996). Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions. *Journal of Occupational Health Psychology*, *1*(1), 27–41. https://doi.org/10.1037/1076-8998.1.1.27

Suárez Tunanñaña, Á. (2013). Adaptación de la Escala de Estrés Laboral de la OIT-OMS en trabajadores de 25 a 35 años de edad de un contact center de Lima. *PsiqueMag*, *2*(1), 33–50.

Talavera Velasco, B. (2017). *Estrés laboral en policías municipales de Madrid* [Tesis doctoral]. Universidad Complutense de Madrid.

Valencia Espejo, R. W. (2021). *Implementar profesionales en salud mental en las unidades investigativas para bajar el nivel del estrés laboral en los servidores públicos policiales de la F.E.L.C.C. de Oruro* [Tesis]. Universidad Policial Mcal. Antonio José de Sucre.

Villarreal Villanueva, J. I. (2023). Breve revisión de literatura sobre el estrés laboral. *Reforma Siglo XXI*, *30*(115), 16–20. https://reforma.uanl.mx/index.php/revista/article/view/114

Violanti, J. M., Charles, L. E., McCanlies, E., Hartley, T. A., Baughman, P., Andrew, M. E., Fekedulegn, D., Ma, C. C., Mnatsakanova, A., y Burchfiel, C. M. (2017). Police stressors and health: A state-of-the-art review. *Policing: An International Journal*, *40*(4), 642–656. https://doi.org/10.1108/PIJPSM-06-2016-0097

Este artículo se publica en acceso abierto bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0).

Territorio de la Palabra
REVISTA ACADÉMICA DE PSICOLOGÍA
CARRERA DE PSICOLOGÍA · UAGRM
SANTA CRUZ DE LA SIERRA · BOLIVIA

Vol. 1, N.° 1 (2026) · pp.69–78
CC BY-NC 4.0

ESTUDIO DE CASO · ESTUDIANTES

Aquiescencia en autoinformes infantiles y límites de la inferencia proyectiva: estudio de caso único

Acquiescence in children's self-reports and the limits of projective inference: A single case study

Carlos Raúl Lara Aguilar[1*]

Tutor: PhD. Juan Jesus Justiniano

[1] Carrera de Psicología, Facultad de Humanidades, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

* Correspondencia: carlosraullara000@gmail.com

RESUMEN

Objetivo. El presente estudio de caso único describe la evaluación psicológica de un niño de 9 años de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con el objetivo de integrar su perfil cognitivo y socioafectivo. Método. Se empleó un enfoque mixto con una batería compuesta por el Test de Matrices Progresivas de Raven, el Test Gestáltico Visomotor de Bender (sistema de Koppitz), el Test de la Figura Humana de Goodenough, tres cuestionarios de autoinforme (Coopersmith, SPECI y EPQ-J) y las técnicas gráficas de la Casa, el Árbol y la Familia. Resultados. Los resultados cognitivos se ubicaron en el rango promedio (Raven, percentil 55; Goodenough, CI = 102), y el Bender registró un único error, rendimiento compatible con lo esperado para la edad. En los tres autoinformes el niño respondió afirmativamente a todos los ítems, incluidos pares de enunciados mutuamente excluyentes; este patrón de aquiescencia invalidó los perfiles de autoestima, síntomas y personalidad. Conclusiones. Se discuten cuatro hipótesis explicativas del patrón —desarrollo evolutivo del estilo de respuesta, comprensión o fatiga, impulsividad en la tarea y defensividad emocional— y se presenta la hipótesis de una vivencia de carencia afectiva, derivada de indicadores gráficos, como una hipótesis a contrastar con fuentes independientes. El caso ilustra la necesidad de controlar los estilos de respuesta en los autoinformes infantiles y de no sustituir los datos invalidados por inferencias proyectivas de validez limitada.

Palabras clave: aquiescencia; autoinforme infantil; evaluación psicológica; técnicas proyectivas; estudio de caso

ABSTRACT

Objective. This single case study describes the psychological assessment of a 9-year-old boy from Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, aimed at integrating his cognitive and socio-affective profile. Method. A mixed approach was used, with a battery including Raven's Progressive Matrices, the Bender Visual-Motor Gestalt Test (Koppitz scoring), the Goodenough Draw-a-Man Test, three self-report questionnaires (Coopersmith, SPECI, and EPQ-J), and the House, Tree, and Family drawing techniques. Results. Cognitive results fell within the average range (Raven, 55th percentile; Goodenough, IQ = 102), and the Bender showed a single error, a performance consistent with age expectations. On all three self-reports the child endorsed every item, including mutually exclusive statements; this acquiescent pattern invalidated the self-esteem, symptom, and personality profiles. Conclusions. Four explanatory hypotheses are discussed—developmental response style, comprehension or fatigue, task impulsivity, and emotional defensiveness—and the hypothesis of experienced affective deprivation, derived from drawing indicators, is presented as a hypothesis to be tested against independent sources. The case illustrates the need to control response styles in children's self-reports and not to replace invalid data with projective inferences of limited validity.

Keywords: acquiescence; child self-report; psychological assessment; projective techniques; case study

RECIBIDO
26 de mayo de 2026

ACEPTADO
2 de octubre de 2026

PUBLICADO
30 de noviembre de 2026

CÓMO CITAR (APA 7)
Lara Aguilar, C. R. (2026). Aquiescencia en autoinformes infantiles y límites de la inferencia proyectiva: estudio de caso único. *Ñe Renda. Territorio de la Palabra, 1*(1), 69–78.

INTRODUCCIÓN

El psicodiagnóstico infantil en los ámbitos clínico y educativo exige un abordaje capaz de relacionar el potencial cognitivo del niño con su ecología socioafectiva, puesto que evaluar a un niño no se reduce a cuantificar sus funciones superiores o su madurez perceptomotora; implica comprender cómo procesa sus vivencias emocionales y los vínculos primarios establecidos en la familia. El Test de Matrices Progresivas de Raven y el Test de la Figura Humana de Goodenough ofrecen estimaciones del razonamiento y de la madurez intelectual con baja carga verbal, y el Test de Bender permite explorar la maduración perceptomotora como indicador de riesgo de dificultades de aprendizaje, sin que ninguno de ellos baste por sí solo para establecer la integridad neurológica.

Sin embargo, el principal reto metodológico surge al explorar la personalidad y el área afectiva. En las últimas décadas la psicología ha incorporado cuestionarios de autoinforme infantil para operacionalizar constructos como la autoestima o la sintomatología conductual, mediante instrumentos como el Coopersmith, el SPECI o el EPQ-J. Si bien estas escalas cuentan con validez psicométrica estandarizada, su aplicación está expuesta a distorsiones dependientes del estado emocional

y madurativo del evaluado. Uno de los fenómenos más disruptivos es la aquiescencia extrema, en la que el niño responde afirmativamente de forma sistemática a todos los reactivos. La aquiescencia es más frecuente y más variable cuanto menor es la edad: en un estudio con autoinformes de personalidad de jóvenes de 10 a 20 años, Soto et al. (2008) hallaron grandes diferencias individuales en la respuesta aquiescente en las edades más tempranas, con efectos marcados sobre las propiedades psicométricas de las escalas, un patrón que no se explicaba solo por la comprensión verbal de los ítems. En la práctica clínica, el patrón puede asociarse además a dificultades de comprensión, a fatiga, a impulsividad en la tarea o a una actitud defensiva ante las preguntas del adulto; distinguir entre estas explicaciones exige procedimientos específicos.

Desde la teoría del apego y la noción de carencia afectiva, algunos autores proponen que niños criados en entornos con baja expresión de afecto podrían desarrollar estrategias de cumplimiento formal y de distanciamiento defensivo, que en una evaluación se traducirían en respuestas automáticas a los autoinformes. Esta es una de las hipótesis que el caso permite plantear, pero no la única. Ante sesgos que anulan los datos cuantitativos socioafectivos, las técnicas proyectivas gráficas, como los dibujos de la Casa, el Árbol y la Familia, suelen emplearse como fuente complementaria. Su validez como base de inferencias diagnósticas es, sin embargo, limitada: la revisión de Lilienfeld et al. (2000) concluyó que la evidencia de validez de los dibujos de la figura humana es escasa y que la mayoría de los índices proyectivos no aportan validez incremental respecto de otros datos psicométricos.

Marco teórico

La afectividad constituye una de las dimensiones primordiales del desarrollo humano. Lejos de ser un mero epifenómeno de las necesidades biológicas, funciona como un sistema motivacional que organiza la experiencia cognitiva, conductual y relacional del niño desde el nacimiento. Se define como el conjunto de estados emocionales y sentimientos que matizan la interacción del sujeto con su entorno, y desempeña un papel crítico en la estructuración de la identidad, la autoestima y la adaptación social. En las etapas iniciales del ciclo vital, la familia es el primer agente socializador del niño; su tarea no se restringe a transmitir normas, sino que provee una matriz relacional en la que el niño aprende a reconocer su mundo interno y el ajeno y ensaya sus primeras estrategias de regulación emocional.

Durante la segunda infancia, de los seis a los doce años, el soporte afectivo familiar contribuye al desarrollo de la tolerancia a la frustración, la flexibilidad cognitiva y un autoconcepto positivo. Algunos planteamientos clínicos proponen que, cuando el ambiente familiar se caracteriza por la privación de estos estímulos, el

niño podría sobreinvertir en el rendimiento académico como vía para obtener reconocimiento.

Esta comprensión cobró un nuevo sentido a partir de las formulaciones de John Bowlby (1969/2014), quien postuló que los seres humanos poseen un sistema de apego innato cuyo objetivo primordial es mantener la proximidad con un cuidador significativo para asegurar protección ante situaciones de amenaza. Vinculada a esto emerge la noción de base segura, desarrollada por Ainsworth et al. (1978/2015) para describir la confianza que se genera cuando el niño comprueba que su cuidador está disponible y es sensible a sus demandas. Esta base segura permite al niño reducir la ansiedad y activar su sistema de exploración para interactuar con el entorno y aprender. Si la base segura es frágil, el sistema de exploración se inhibe y el niño centra sus recursos en conductas defensivas para evitar el rechazo.

Como consecuencia de este proceso se estructuran los modelos internos de trabajo, esquemas representacionales que guían la interpretación de las experiencias relacionales a lo largo del ciclo vital (Bowlby, 1969/2014). Estos modelos contienen un componente sobre las figuras de apego —si son percibidas como accesibles— y un modelo del sí mismo —si el sujeto se considera digno de recibir afecto—. Si las interacciones primarias están teñidas por la distancia afectiva, el niño puede internalizar un modelo devaluado de sí mismo y regular de forma rígida la expresión de sus sentimientos.

A través del procedimiento de la Situación Extraña, aplicado en el segundo año de vida, fue posible clasificar las respuestas infantiles en estilos de apego diferenciados, siendo el apego seguro el resultado de cuidadores que responden con sintonía afectiva a las señales de malestar (Ainsworth et al., 1978/2015). En contraposición, el apego inseguro-evitativo es de especial interés clínico: emerge cuando los cuidadores rechazan de forma sistemática las demandas de proximidad, y el niño responde desactivando la expresión de su necesidad de apego. Estudios psicofisiológicos con lactantes de 12 meses mostraron que, pese a su menor malestar manifiesto, los niños clasificados como inseguro-evitativos presentan una activación fisiológica comparable a la de los seguros durante la separación y niveles más altos de cortisol, lo que sugiere que la calma aparente no equivale a ausencia de estrés (Spangler y Grossmann, 1993).

A partir de este marco, la carencia afectiva en la infancia se define como la privación o el ocultamiento sutil de los estímulos emocionales y empáticos necesarios para la maduración psíquica. En la literatura clínica se ha descrito una forma encubierta de carencia afectiva en familias que satisfacen las demandas materiales y académicas, pero cuyo clima interno se caracteriza por la frialdad, la rigidez y la falta de sintonía empática, con interacciones predominantemente instrumentales en las que el afecto aparecería condicionado al rendimiento escolar. Frente a

ello, el niño podría desplegar una orientación compensatoria al logro y un distanciamiento protector de su mundo afectivo.

Cuando los datos psicométricos cuantitativos resultan inválidos, las técnicas gráficas suelen usarse para formular hipótesis sobre la vivencia subjetiva de los vínculos. Se fundamentan en el supuesto de proyección, según el cual el sujeto expresa en el dibujo aspectos de sí mismo y de su dinámica relacional (Buck, 2014; Koch, 2015). Ese supuesto, sin embargo, tiene apoyo empírico limitado (Lilienfeld et al., 2000). Por ello, su interpretación debe evitar los signos fijos y buscar recurrencias entre pruebas y con otras fuentes; sus resultados son hipótesis que requieren corroboración y no restituyen por sí mismos la validez de un psicodiagnóstico.

Objetivo del estudio

Con base en estas premisas, el presente artículo examina, mediante un estudio de caso único, cómo un patrón de aquiescencia extrema invalidó los autoinformes socioafectivos de un niño de 9 años con funcionamiento cognitivo promedio, y analiza qué inferencias permiten —y cuáles no— los datos de ejecución y las producciones gráficas para formular hipótesis explicativas y orientar la intervención.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Diseño

Se trata de un estudio de caso único, de alcance descriptivo y con enfoque mixto, que combina puntuaciones estandarizadas con el análisis cualitativo de producciones gráficas y de la conducta durante la evaluación. El reporte sigue los elementos de la guía CARE aplicables a la evaluación psicológica.

Datos del caso

El participante es un niño de 9 años y 2 meses, estudiante regular de cuarto año de educación primaria en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Reside en un hogar nuclear y es hijo único. Fue remitido para una valoración integral de su desarrollo madurativo, cognitivo, emocional y conductual. El padre fue la fuente de la anamnesis.

Consideraciones éticas

El procedimiento se ajustó a las normativas vigentes sobre protección de menores y a los códigos deontológicos profesionales. Se realizó una sesión informativa con los progenitores sobre los alcances, los objetivos y la confidencialidad del psicodiagnóstico, tras la cual el padre firmó el consentimiento informado. Se obtuvo el asentimiento verbal del niño, a quien se informó que podía solicitar pausas, y los datos de filiación se codificaron mediante seudónimos. El autor declara contar con el consentimiento informado escrito de los progenitores para la publicación

del caso. El protocolo no fue evaluado por un comité de ética, dado que el caso se originó como una valoración asistencial; esta ausencia se declara como limitación.

Instrumentos

Para la dimensión intelectual se aplicaron el Test de Matrices Progresivas de Raven (Raven et al., 2014), prueba no verbal de razonamiento analógico, y el Test de la Figura Humana de Goodenough (Goodenough, 2009), escala gráfica de madurez intelectual. La maduración perceptomotora se evaluó con el Test Gestáltico Visomotor de Bender, puntuado con el sistema evolutivo de Koppitz (2012). La esfera socioafectiva se exploró con tres autoinformes: el Inventario de Autoestima de Coopersmith (Coopersmith, 1981), el Screening de Problemas Emocionales y de Conducta Infantil (SPECI; Sánchez-Cánovas, 2013) y el Cuestionario de Personalidad EPQ-J (Eysenck y Eysenck, 2002), que incluye una escala de sinceridad. Se emplearon además las técnicas gráficas de la Casa y el Árbol (Buck, 2014; Koch, 2015) y el dibujo de la Familia.

Procedimiento

La evaluación se organizó en cuatro fases, en un entorno clínico-pedagógico. En la primera se realizó una entrevista semiestructurada con el padre para recabar antecedentes evolutivos y se estableció el *rapport* con el niño. En la segunda se administraron las pruebas gráficas y de ejecución perceptomotora, por su carácter lúdico y su baja demanda verbal, con registro del control motor y del estilo de resolución. En la tercera se aplicaron los cuestionarios de autoinforme; el evaluador entregó las consignas estandarizadas y registró la conducta del niño. En la cuarta se puntuaron las pruebas estandarizadas, se analizaron cualitativamente las producciones gráficas y se evaluó la validez de los autoinformes. No se registraron el número de sesiones, su duración ni el tiempo transcurrido hasta la aplicación de los autoinformes, que fueron los últimos de la secuencia.

EVALUACIÓN

La Tabla 1 sintetiza los resultados de las pruebas estandarizadas. En el área cognitiva, el niño obtuvo un percentil 55 en el Raven y un CI de 102 en la prueba de Goodenough, ambos en el rango promedio. Su dibujo de la figura humana presentó un esquema corporal completo y proporcionado. En el Bender registró un único error, por distorsión leve.

Tabla 1
Resultados de las pruebas estandarizadas

Instrumento	Puntuación	Baremo de referencia	Interpretación
Raven, Matrices Progresivas	Percentil 55	Sin elementos consignados	Razonamiento analógico promedio
Goodenough, Figura Humana	CI 102	Sin elementos consignados	Madurez intelectual promedio
Bender (sistema de Koppitz)	1 error (distorsión leve)	Koppitz (2012)	Sin indicadores de inmadurez perceptomotora
Coopersmith, SPECI, EPQ-J	Respuesta afirmativa a la totalidad de los ítems	No aplica	Perfiles inválidos por aquiescencia

Nota. No se especifican la forma del Raven aplicada ni los baremos de referencia del Raven y de la escala de Goodenough, ni se informan las puntuaciones de la escala de sinceridad del EPQ-J.

Durante la aplicación de los autoinformes, el niño respondió con gran rapidez y marcó la opción afirmativa en la totalidad de los ítems de las tres escalas, validando de forma simultánea enunciados mutuamente excluyentes dentro de un mismo protocolo. En consecuencia, los perfiles de autoestima, síntomas y personalidad se consideraron inválidos y no se interpretaron.

En el dibujo de la familia, el niño representó a todos los miembros sobre una línea de base común, dibujó en primer lugar a la madre y no incluyó interacciones ni detalles afectivos entre las figuras. En el dibujo de la casa trazó una puerta central cerrada con picaporte, ventanas con cortinas detalladas y una chimenea sin humo. En el dibujo del árbol trazó un tronco ancho y recto y una copa con abundantes frutos.

DISCUSIÓN

Interpretación de los hallazgos

Los resultados muestran un contraste entre un funcionamiento cognitivo promedio y una respuesta inválida a los autoinformes socioafectivos. Los datos de ejecución no indican déficit intelectual ni inmadurez perceptomotora. Sin embargo, un único error en el Bender a los 9 años es un rendimiento esperable en un baremo evolutivo que se aproxima a su suelo y no permite inferir una madurez superior; tampoco el conjunto de pruebas aplicadas permite descartar categóricamente una alteración neurológica, para lo que se requeriría una evaluación neuropsicológica específica.

La invalidación de los autoinformes es una conclusión metodológica firme. La interpretación del patrón de aquiescencia, en cambio, admite varias hipótesis que el estudio no permite discriminar. La primera es evolutiva: la aquiescencia es más frecuente y variable en las edades más tempranas, y en estudios con autoinformes

de personalidad no se explica solo por la comprensión de los ítems (Soto et al., 2008). La segunda es de comprensión y fatiga: los autoinformes fueron los últimos instrumentos aplicados y no se registró la duración de la evaluación. La tercera es la impulsividad en la tarea, coherente con la rapidez de respuesta observada. La cuarta es la defensividad emocional ante preguntas sobre la propia intimidad, que el autor relaciona con una posible carencia afectiva. Esta última lectura plantea un problema de falsabilidad: si el niño hubiera respondido de forma diferenciada, sus puntuaciones se habrían interpretado; al no hacerlo, la ausencia de diferenciación se interpretó igualmente como evidencia de la carencia afectiva, de modo que ningún resultado posible habría contado en su contra. Para discriminar entre las hipótesis se requeriría readministrar los autoinformes con lectura asistida, ítems invertidos y control del tiempo, e incorporar índices formales de aquiescencia y de sinceridad.

Los indicadores gráficos —ausencia de interacción en el dibujo de la familia, puerta cerrada, cortinas y chimenea sin humo en la casa, copa con frutos en el árbol— son compatibles con la hipótesis de contención emocional que plantea el autor. Su fuerza probatoria es, sin embargo, baja por tres razones. La validez de los índices gráficos aislados tiene escaso apoyo empírico (Lilienfeld et al., 2000), y el propio marco teórico de este estudio advierte contra la lectura de signos fijos. No se informa acuerdo entre jueces. Y la única fuente de información sobre el hogar fue el padre, miembro del mismo sistema evaluado. Además, la clasificación de un estilo de apego requiere procedimientos validados para la edad del niño y no puede derivarse de dibujos. Por ello, la vivencia de carencia afectiva y el estilo de apego inseguro-evitativo se presentan como hipótesis a contrastar, no como hallazgos. La cautela no es formal: caracterizar el hogar de un niño como emocionalmente distante tiene consecuencias para la familia evaluada.

Los indicadores de contención emocional que el niño mostró durante la evaluación son compatibles con lo observado por Spangler y Grossmann (1993) en lactantes: una calma aparente no implica ausencia de activación emocional. Esa evidencia procede de otra etapa del desarrollo y de otro procedimiento, por lo que solo justifica no tomar la serenidad conductual como indicador de bienestar.

Implicaciones teóricas y prácticas

En el plano teórico, el caso muestra que un patrón de respuesta invalidante puede recibir varias explicaciones con la misma plausibilidad aparente, y que la literatura evolutiva sobre estilos de respuesta (Soto et al., 2008) debe considerarse antes de atribuirlo a mecanismos defensivos. En el plano práctico, el caso sugiere tres pautas para la evaluación infantil: incluir controles de aquiescencia —ítems invertidos o enunciados contradictorios— y revisar la consistencia de las respuestas antes de interpretar cualquier autoinforme; aplicar los cuestionarios antes de que la

fatiga acumulada pueda influir; y, ante datos inválidos, triangular con informantes independientes del hogar, como el docente, en lugar de sustituir esos datos por inferencias proyectivas.

Limitaciones

El estudio presenta las limitaciones propias de un caso único: no permite generalizar ni establecer relaciones causales. A ello se suman: (a) la ausencia de índices formales de aquiescencia y de las puntuaciones de la escala de sinceridad del EPQ-J; (b) la falta de registro de la duración de la evaluación; (c) la ausencia de baremos de referencia declarados para el Raven y la prueba de Goodenough; (d) el uso de técnicas gráficas de validez limitada, sin acuerdo entre jueces; (e) el padre como única fuente de información sobre el hogar, y (f) la ausencia de evaluación del protocolo por un comité de ética.

CONCLUSIONES

El participante presenta un funcionamiento cognitivo en el rango promedio, sin indicadores de inmadurez perceptomotora, de modo que las dificultades observadas en la evaluación no parecen deberse a limitaciones de aptitud.

El patrón de aquiescencia extrema detectado en la totalidad de los autoinformes (Coopersmith, SPECI y EPQ-J) invalida el uso de sus puntuaciones en el diagnóstico. Este patrón admite explicaciones evolutivas, de comprensión o fatiga, de impulsividad en la tarea y de defensividad emocional, que el diseño no permite discriminar.

La hipótesis de una vivencia de carencia afectiva en el ámbito doméstico, planteada a partir de los indicadores gráficos, es plausible pero no está demostrada; su contraste requiere fuentes independientes del hogar e instrumentos de apego validados para la edad.

Finalmente, el estudio aporta una conclusión metodológica: no deben fundamentarse perfiles socioafectivos infantiles exclusivamente en autoinformes de formato cerrado sin controles de estilo de respuesta, y la triangulación con la observación estructurada y con informantes independientes es preferible a la sustitución de los datos invalidados por inferencias proyectivas.

REFERENCIAS

Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., y Wall, S. N. (2015). *Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation*. Psychology Press. (Obra original publicada en 1978)

Bowlby, J. (2014). *El apego y la pérdida: Vol. 1. El apego*. Paidós. (Obra original publicada en 1969)

Buck, J. N. (2014). *H-T-P: Manual y guía de interpretación de la técnica de dibujo de la Casa-Árbol-Persona*. Manual Moderno.

Coopersmith, S. (1981). *Self-Esteem Inventories*. Consulting Psychologists Press.

Eysenck, H. J., y Eysenck, S. B. G. (2002). *Manual del Cuestionario de Personalidad para Niños y Adultos (EPQ-A y EPQ-J)*. TEA Ediciones.

Goodenough, F. L. (2009). *Test de la figura humana: Aplicación, corrección e interpretación*. Paidós.

Koch, K. (2015). *El test del árbol: El diagnóstico psicológico a través del dibujo del árbol*. Editorial Luis Miracle.

Koppitz, E. M. (2012). *El test gestáltico visomotor de Bender para niños*. Guadalupe.

Lilienfeld, S. O., Wood, J. M., y Garb, H. N. (2000). The scientific status of projective techniques. *Psychological Science in the Public Interest*, *1*(2), 27–66. https://doi.org/10.1111/1529-1006.002

Raven, J. C., Court, J. H., y Raven, J. (2014). *Test de Matrices Progresivas: Escala Coloreada, General y Avanzada*. Paidós.

Sánchez-Cánovas, J. (2013). *Screening de Problemas Emocionales y de Conducta Infantil (SPECI): Manual de aplicación*. TEA Ediciones.

Soto, C. J., John, O. P., Gosling, S. D., y Potter, J. (2008). The developmental psychometrics of Big Five self-reports: Acquiescence, factor structure, coherence, and differentiation from ages 10 to 20. *Journal of Personality and Social Psychology*, *94*(4), 718–737. https://doi.org/10.1037/0022-3514.94.4.718

Spangler, G., y Grossmann, K. E. (1993). Biobehavioral organization in securely and insecurely attached infants. *Child Development*, *64*(5), 1439–1450. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1993.tb02962.x

Este artículo se publica en acceso abierto bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0).

Territorio de la Palabra
REVISTA ACADÉMICA DE PSICOLOGÍA
CARRERA DE PSICOLOGÍA · UAGRM
SANTA CRUZ DE LA SIERRA · BOLIVIA

Vol. 1, N.° 1 (2026) · pp. 79–87
CC BY-NC 4.0

ESTUDIO DE CASO · ESTUDIANTES

Procesos atencionales y de memoria en una niña con indicadores de inatención: estudio de caso

Attentional and memory processes in a girl with indicators of inattention: A case study

Gabriela Rosales[1]*

Tutor: PhD. Juan Jesus Justiniano

[1] Carrera de Psicología, Facultad de Humanidades, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

* Correspondencia: gabriela.rosaless@icloud.com

RESUMEN

Objetivo. El presente estudio de caso describe los procesos atencionales y de memoria de una niña de 5 años y 11 meses evaluada por sospecha de dificultades de aprendizaje. Método. Se administró una batería de diez instrumentos cognitivos, proyectivos y atencionales. Resultados. Los resultados mostraron un funcionamiento intelectual general dentro del promedio y un rendimiento bajo en razonamiento analógico (Raven, percentil 5) y en atención perceptiva sostenida (Test de Caras, percentiles 15 a 20). La memoria visual diferida se situó en el percentil 50, rendimiento promedio, con una discrepancia de 30 puntos percentilares respecto de la copia (percentil 80). El cuestionario de ansiedad arrojó una puntuación directa de 17, interpretada por la evaluadora como nivel moderado. Conclusiones. El perfil es compatible con dificultades atencionales, pero una sola prueba de atención en una niña menor de seis años no permite sostener indicadores de trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), cuyo diagnóstico requiere síntomas persistentes en dos o más contextos. A partir de los hallazgos se diseñó un plan de intervención lúdico-cognitiva, que no fue aplicado ni evaluado. Se concluye la importancia de una evaluación temprana y multimétodo para orientar la intervención en niños con dificultades atencionales.

Palabras clave: inatención; atención sostenida; memoria visual; evaluación psicológica; estudio de caso

ABSTRACT

Objective. This case study describes the attentional and memory processes of a 5-year-11-month-old girl assessed for suspected learning difficulties. Method. A battery of ten cognitive, projective, and attentional instruments was administered. Results. Results showed average ge-

neral intellectual functioning and low performance in analogical reasoning (Raven, 5th percentile) and in sustained perceptual attention (Faces Test, 15th to 20th percentile). Delayed visual memory fell at the 50th percentile, an average performance, with a 30-point percentile discrepancy relative to copy (80th percentile). The anxiety questionnaire yielded a raw score of 17, interpreted by the examiner as moderate. Conclusions. The profile is consistent with attentional difficulties, but a single attention test in a child under six does not support indicators of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), whose diagnosis requires persistent symptoms in two or more settings. Based on these findings, a play-based cognitive intervention plan was designed, which was neither implemented nor evaluated. The study highlights the importance of early, multimethod assessment to guide intervention in children with attentional difficulties.

Keywords: inattention; sustained attention; visual memory; psychological assessment; case study

RECIBIDO
30 de mayo de 2026

ACEPTADO
2 de octubre de 2026

PUBLICADO
30 de noviembre de 2026

CÓMO CITAR (APA 7)
Rosales, G. (2026). Procesos atencionales y de memoria en una niña con indicadores de inatención: estudio de caso. *Ñe Renda. Territorio de la Palabra, 1*(1), 79–87.

INTRODUCCIÓN

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por un patrón persistente de inatención, hiperactividad-impulsividad o ambas, que interfiere en el funcionamiento y se manifiesta en dos o más contextos; la presentación predominantemente con falta de atención corresponde a los casos en que predominan los síntomas de inatención (American Psychiatric Association [APA], 2022). Según Romero Pérez y Lavigne Cerván (2004), el trastorno se debe a una alteración neuropsicológica que provoca disfunciones en los mecanismos de control ejecutivo del comportamiento, afectando la atención sostenida, la memoria de trabajo, la autorregulación de la motivación y el afecto, la internalización del lenguaje y los procesos de análisis y síntesis. Esta caracterización procede del modelo de Barkley (1997), que propone un déficit primario de inhibición conductual del que dependerían cuatro funciones ejecutivas —memoria de trabajo, autorregulación del afecto, la motivación y la activación, internalización del lenguaje y reconstitución— y que el propio autor presentó como una teoría prometedora que requería más investigación.

En lo que respecta a la inatención, esta dificultad no es un constructo simple: se manifiesta como incapacidad para mantener la atención sostenida, seguir reglas e instrucciones y seleccionar estímulos relevantes frente a las distracciones. Desde una perspectiva neurobiológica, la hipótesis con más apoyo propone una disfunción en los circuitos frontoestriatales que afecta funciones ejecutivas como la me-

moria operativa y la integración temporal. A diferencia de los síntomas de hiperactividad, que suelen declinar con el desarrollo, la inatención muestra una notable estabilidad temporal y persiste con frecuencia en la adolescencia y la vida adulta (Carboni, 2011). No obstante, el metaanálisis de Willcutt et al. (2005), con 83 estudios, halló debilidades ejecutivas de tamaño moderado en los grupos con TDAH, pero no universales, por lo que concluyó que no son condición necesaria ni suficiente del trastorno: un rendimiento bajo en una prueba ejecutiva no basta para inferirlo.

El TDAH presenta una relación crítica con la memoria de trabajo, componente de las funciones ejecutivas encargado de almacenar y manipular información en tiempo real. Las deficiencias en este proceso se traducen en dificultades para seguir instrucciones, organizar tareas y mantener acciones dirigidas a objetivos, con impacto negativo en el rendimiento escolar y la adaptación (Venegas et al., 2018).

En el ámbito escolar, el TDAH se encuentra estrechamente vinculado al fracaso escolar, ya que sus síntomas de inatención afectan el rendimiento en diversas áreas académicas, especialmente matemáticas, lectura y escritura; el bajo rendimiento no suele reflejar la capacidad intelectual real del alumno, sino dificultades en las funciones ejecutivas y el control atencional (García Santana y Briones Palacios, 2023). Respecto a la evaluación temprana, Taboada y Pinto (2018) sostienen que la evaluación psicológica y neuropsicológica de niños con TDAH permite obtener un diagnóstico fidedigno que sirva de base para programas de rehabilitación cognitiva individualizados y evitar diagnósticos erróneos y tratamientos prematuros.

El objetivo del presente estudio fue describir los procesos atencionales y de memoria de una niña con sospecha de dificultades de aprendizaje y, a partir de ese perfil, proponer una intervención psicológica temprana.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Diseño

Estudio de caso único, descriptivo e interpretativo, con enfoque mixto: combina puntuaciones estandarizadas con observación conductual y análisis de producciones gráficas. El reporte sigue los elementos de la guía CARE aplicables a la evaluación psicológica.

Datos del caso

La participante es una niña de 5 años y 11 meses que cursa el primer grado de primaria en una unidad educativa de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La evaluación fue solicitada por la madre ante la sospecha de dificultades de aprendizaje. La niña no contaba con diagnóstico previo.

Consideraciones éticas

La evaluación fue solicitada por la madre de la niña ante la sospecha de dificultades de aprendizaje. La madre consiente de manera escrita tanto la evaluacion como la posterior publicacion salvaguardando la identidad de la menor. En el presente reporte se omitieron el nombre de la niña, el de la unidad educativa y cualquier otro dato que permita identificarla. No consta que el protocolo haya sido evaluado por un comité de ética, dado que el caso se originó como una valoración asistencial; esta ausencia se declara como limitación.

Técnicas

Se emplearon: (a) revisión de antecedentes escolares aportados por la madre; (b) observación conductual durante toda la administración, con registro del comportamiento, el nivel de atención y las reacciones, y (c) análisis integrado de los resultados de la batería. La evaluación se realizó de forma individual, en un ambiente tranquilo y sin distractores, en dos sesiones.

Instrumentos

Se administró una batería de diez instrumentos en dos momentos. En el primero se aplicaron siete pruebas cognitivas y proyectivas para evaluar visomotricidad, desarrollo intelectual, madurez, razonamiento lógico y mundo emocional-vincular. En el segundo, a partir de los resultados del primero, se aplicaron tres pruebas centradas en la atención, la memoria visual y la ansiedad (Tabla 1).

Tabla 1

Instrumentos administrados

Instrumento	Área evaluada	Momento	Función principal
Bender (sistema de Koppitz)	Visomotricidad	Primero	Maduración perceptivo-motora
Goodenough, Figura Humana	Inteligencia general	Primero	Madurez intelectual
Dibujo de la Figura Humana (Koppitz)	Madurez evolutiva	Primero	Ítems evolutivos e indicadores emocionales
Raven, Matrices Progresivas Coloreadas	Razonamiento	Primero	Razonamiento analógico no verbal
Machover	Área emocional	Primero	Indicadores proyectivos
Test de la Familia	Área emocional	Primero	Indicadores vinculares
H-T-P	Área emocional	Primero	Indicadores proyectivos casa-árbol-persona
Figura Compleja de Rey (figura A)	Memoria visual	Segundo	Copia y reproducción diferida
Test de Caras	Atención perceptiva	Segundo	Atención sostenida y selectiva
CAS	Ansiedad	Segundo	Nivel de ansiedad infantil

Nota. No se consignan los manuales ni los baremos de referencia de los instrumentos (véase Discusión, Limitaciones).

Procedimiento

El procedimiento se desarrolló en tres fases. En la primera se recabó información sobre el contexto escolar a través de la madre. En la segunda se administró la batería en dos sesiones individuales, comenzando por las pruebas cognitivas y proyectivas y continuando con las pruebas de atención, memoria y ansiedad. En la tercera se analizaron e integraron los resultados, se elaboró el informe y se diseñó el plan de intervención, que fue presentado a la familia. No se registraron la duración de las sesiones ni el orden de aplicación dentro de cada una.

EVALUACIÓN

La Tabla 2 sintetiza los resultados. En las pruebas de desarrollo intelectual general (Goodenough) y de madurez gráfica (DFH de Koppitz) la niña obtuvo resultados dentro del promedio para su edad, y la visomotricidad (Bender-Koppitz, PD = 9) se ubicó dentro de lo esperado.

En el Test de Matrices Progresivas de Raven la niña obtuvo un percentil 5 (rango V), por debajo de su rendimiento en las demás pruebas cognitivas. Durante su administración se registró una perseverancia irregular en la tarea.

En el Test de Caras obtuvo un índice de control de la impulsividad (ICI) de 62,5, con un rendimiento situado entre los percentiles 15 y 20, por debajo del promedio para su edad, y cometió 3 errores.

En la Figura Compleja de Rey obtuvo una puntuación bruta de 15,5 en la copia (percentil 80) y de 5 en la memoria diferida (percentil 50). Ambas puntuaciones se ubican en el rango normal; la diferencia de 30 puntos percentilares entre copia y memoria constituye una discrepancia intraindividual.

En el Cuestionario de Ansiedad Infantil (CAS) obtuvo una puntuación directa de 17, que la evaluadora interpretó como nivel moderado; el percentil se estimó solo de forma aproximada. En las técnicas gráficas se registraron, en el H-T-P, un árbol con tronco débil sin raíces y una casa con puerta pequeña sin línea de suelo, y en el Test de la Familia la omisión de la propia evaluada en el dibujo familiar.

Tabla 2

Síntesis de resultados de la evaluación

Instrumento	Puntuación	Nivel informado	Interpretación
Bender (sistema de Koppitz)	PD = 9	Promedio	Visomotricidad esperada para la edad
Goodenough	Sin elementos consignados	Promedio	Inteligencia general dentro de lo esperado
DFH (Koppitz)	Sin elementos consignados	Promedio	Madurez gráfica esperada

Instrumento	Puntuación	Nivel informado	Interpretación
Raven, Matrices Coloreadas	Pc = 5 (rango V)	Muy por debajo del promedio	Rendimiento bajo en razonamiento analógico (véase Discusión, Hipótesis rival)
Rey, copia	PD = 15,5; Pc = 80	Promedio alto	Buena organización perceptiva
Rey, memoria diferida	PD = 5; Pc = 50	Promedio	Retención visual promedio; discrepancia de 30 puntos respecto de la copia
Test de Caras	ICI = 62,5; Pc = 15–20	Por debajo del promedio	Atención perceptiva sostenida inferior a la esperada
CAS	PD = 17	Moderado (según la evaluadora)	Percentil exacto no informado

Nota. PD = puntuación directa; Pc = percentil; ICI = índice de control de la impulsividad.

Tabla 3

Análisis de contenido de los instrumentos del segundo momento

Contenido	Test de Caras	Figura de Rey	CAS
Comportamiento	Cooperativa, con dispersión atencional e impulsividad en la respuesta	Cooperativa; mayor concentración en la copia que en la memoria	Cooperativa, con tensión observable en algunos ítems
Aspectos intelectuales	Baja eficacia visoperceptiva y velocidad de procesamiento	Buena capacidad de copia; retención diferida promedio	Sin afectación intelectual directa
Aspectos orgánicos	Sin elementos significativos	Sin elementos significativos	Sin elementos significativos
Aspectos afectivos	Inseguridad y baja tolerancia a la frustración	Ansiedad ante tareas de mayor dificultad	Vulnerabilidad emocional
Área de conflicto	Atención selectiva y sostenida	Discrepancia copia-memoria	Ansiedad vincular y de rendimiento
Indicadores observados	Inatención de tipo perceptivo; impulsividad leve	Discrepancia copia-memoria sin déficit normativo	Nivel moderado según la evaluadora

Nota. Tabla de síntesis cualitativa elaborada por la evaluadora. Los indicadores observados no constituyen criterios diagnósticos.

DISCUSIÓN

Lectura general

La discrepancia entre el funcionamiento intelectual general y el rendimiento en atención perceptiva (Caras, percentiles 15 a 20) es coherente con lo señalado por Alava et al. (2021), quienes documentan que los niños con TDAH de presentación inatenta presentan dificultades en la atención sostenida y selectiva sin déficit intelectual global. Ese contraste es compatible con dificultades atencionales, pero no las especifica: en un caso evaluado con una sola prueba de atención, sin escalas de síntomas para padres y docentes y sin información de un segundo contexto, no se

cumplen los requisitos para plantear un TDAH (APA, 2022). Además, las debilidades ejecutivas no son condición necesaria ni suficiente del trastorno (Willcutt et al., 2005).

Hipótesis rival para el rendimiento en el Raven

El percentil 5 en el Raven contrasta con el rendimiento promedio en las demás pruebas cognitivas. La evaluadora lo interpretó inicialmente como una dificultad específica de razonamiento abstracto, pero consigna que durante esa prueba se observó una perseverancia irregular en la tarea. Cabe, por tanto, una hipótesis rival: el puntaje bajo podría ser consecuencia de la propia dificultad atencional y no una segunda dificultad independiente. La interpretación debe quedar en suspenso. Además, sostener la normalidad intelectual en la escala de Goodenough —una estimación gráfica de menor validez— y atribuir un déficit específico al Raven invierte la jerarquía psicométrica esperable. Una reevaluación del razonamiento con una prueba no verbal estandarizada, en condiciones de menor demanda atencional, permitiría discriminar entre ambas hipótesis.

Memoria visual y ansiedad

La memoria visual diferida se situó en el percentil 50, por lo que no puede hablarse de un compromiso de la memoria. La discrepancia de 30 puntos percentilares entre copia y memoria es un dato intraindividual que merece seguimiento, pero no un déficit. Venegas et al. (2018) describen alteraciones de la memoria de trabajo en niños con TDAH; la Figura de Rey en reproducción diferida evalúa la memoria visual a largo plazo, un proceso distinto, por lo que esa referencia no se aplica directamente a este resultado.

La puntuación del CAS fue interpretada como ansiedad moderada. Robles Bermejo (2024), en un estudio retrospectivo con 24 niños con TDAH sin tratamiento farmacológico, describió un perfil cognitivo dentro de la normalidad pero inferior al de los controles, y una alta frecuencia de trastornos específicos del aprendizaje asociados (58 %). La hipótesis de un círculo en el que la ansiedad reduce la capacidad atencional y los fracasos aumentan la ansiedad es plausible, pero no procede de esa fuente y no fue evaluada en este caso. Los indicadores gráficos —tronco débil, puerta pequeña, omisión de la propia figura en el dibujo familiar— podrían reflejar tensión emocional en el contexto vincular, pero se trata de signos aislados de validez limitada, sin acuerdo entre jueces ni corroboración independiente. Su lectura es una hipótesis que justifica una evaluación clínica complementaria, no una conclusión sobre la familia.

En el presente caso, la evaluación fue el primer acercamiento diagnóstico. Esto subraya la importancia señalada por Taboada y Pinto (2018) de evaluaciones psi-

cológicas tempranas y exhaustivas que permitan identificar perfiles de riesgo antes de que las dificultades se consoliden.

Propuesta de intervención

A partir del perfil se diseñó una propuesta de intervención de cinco sesiones semanales de dos horas, organizada en cinco ejes: (a) entrenamiento de la atención sostenida mediante discriminación visual progresiva y laberintos; (b) fortalecimiento de la memoria visual mediante secuencias, juegos de memoria y reproducción diferida; (c) estimulación del razonamiento lógico con matrices visuales, clasificación y deducción; (d) autorregulación emocional con herramientas psicoeducativas como el semáforo de emociones, la caja de calma y la respiración guiada, y (e) integración y consolidación de los aprendizajes. **La propuesta no fue aplicada ni evaluada**, por lo que su eficacia no ha sido establecida; su evaluación requeriría mediciones repetidas antes, durante y después de la intervención.

Implicaciones teóricas y prácticas

En el plano teórico, el caso ilustra por qué el modelo ejecutivo del TDAH (Barkley, 1997) no autoriza a inferir el trastorno a partir de un rendimiento bajo aislado: el mismo puntaje admite explicaciones atencionales, motivacionales o de procedimiento. En el plano práctico, sugiere que, ante sospechas tempranas de inatención, la evaluación debe incluir escalas de síntomas para padres y docentes, observación en más de un contexto y una lectura normativa cuidadosa de cada puntuación antes de orientar la intervención.

Limitaciones

El estudio no permite generalizar ni establecer relaciones causales. Además: (a) se empleó una sola prueba específica de atención; (b) no se recogió información de un segundo contexto (escuela) ni escalas de síntomas; (c) varias puntuaciones se informan de forma aproximada o sin percentil; (d) no se declaran manuales ni baremos de los instrumentos; (e) no consta la duración de las sesiones; (f) los indicadores proyectivos carecen de acuerdo entre jueces, y (g) el protocolo no fue evaluado por un comité de ética.

CONCLUSIONES

Los resultados del presente estudio de caso muestran que la niña presenta un rendimiento por debajo del promedio en atención perceptiva sostenida y un rendimiento bajo en razonamiento analógico cuya interpretación queda en suspenso, porque puede deberse a la propia dificultad atencional. Su funcionamiento intelectual general es promedio y su memoria visual diferida es normal, con una discrepancia intraindividual respecto de la copia. Este perfil es compatible con difi-

cultades atencionales, pero no basta para plantear indicadores de TDAH. La ansiedad informada por la evaluadora es una dimensión emocional que conviene explorar con una evaluación clínica complementaria.

La evaluación temprana permitió identificar un perfil de riesgo antes de la consolidación de las dificultades, lo que representa una oportunidad de intervención. La propuesta de intervención lúdica y estructurada diseñada para el caso no fue aplicada ni evaluada; su eficacia deberá establecerse con mediciones repetidas.

Se recomienda continuar con el seguimiento psicológico, articular la intervención con la docente de aula y la familia, y derivar a psicología clínica para explorar los indicadores emocionales. La confirmación o el descarte de un TDAH requiere una segunda fase de evaluación con escalas de valoración de síntomas para padres y docentes (por ejemplo, las escalas de Conners) y con información de al menos dos contextos.

REFERENCIAS

Alava, S., Cantero García, M., Garrido Hernansaiz, H., Sánchez Iglesias, I., y Santacreu, J. (2021). Atención sostenida y selectiva en subtipos de TDAH y en trastorno de aprendizaje: Una comparación clínica. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, *19*(53). https://doi.org/10.25115/ejrep.v19i53.3778

American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5.ª ed., texto rev.). https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787

Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: Constructing a unifying theory of ADHD. *Psychological Bulletin*, *121*(1), 65–94. https://doi.org/10.1037/0033-2909.121.1.65

García Santana, S. L., y Briones Palacios, Y. M. (2023). Principales dificultades de aprendizaje en estudiantes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. *Revista Cubana de Educación Superior*

Robles Bermejo, F. (2024). Trastorno por déficit de atención e hiperactividad: Perfil neuropsicológico y estudio de su impacto en las funciones ejecutivas y académicas. *Anales de Pediatría*, *100*(2), 87–96. https://doi.org/10.1016/j.anpede.2024.01.004

Romero Pérez, J. F., y Lavigne Cerván, R. (2004). *Dificultades en el aprendizaje: Unificación de criterios diagnósticos* (Vol. 2). Junta de Andalucía, Consejería de Educación. https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO24885/dificultades_aprendizaje_2.pdf

Taboada, R., y Pinto, B. (2018). Evaluación neuropsicológica en dos niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad: Estudios de caso. *Ajayu*, *16*(1). https://app.lpz.ucb.edu.bo/publicaciones/ajayu/v16n1/v16n1_a04.pdf

Venegas, S., Fernanda, C., y López, M. (2018). Alteraciones de la memoria de trabajo en niños con trastorno de déficit atencional e hiperactividad: Qué nos dicen las neurociencias. *Revista Chilena de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia*

Willcutt, E. G., Doyle, A. E., Nigg, J. T., Faraone, S. V., y Pennington, B. F. (2005). Validity of the executive function theory of attention-deficit/hyperactivity disorder: A meta-analytic review. *Biological Psychiatry*, *57*(11), 1336–1346. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2005.02.006

Este artículo se publica en acceso abierto bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0).

Territorio de la Palabra
REVISTA ACADÉMICA DE PSICOLOGÍA · UAGRM · SANTA CRUZ DE LA SIERRA · BOLIVIA

Vol. 1, N.° 1 (2026) · pp.88–95
CC BY-NC 4.0

ESTUDIO DE CASO · ESTUDIANTES

Dificultades en habilidades preacadémicas y de lectoescritura en una niña sin escolarización inicial: reporte clínico de caso

Difficulties in pre-academic and literacy skills in a girl without early schooling: A clinical case report

Natalia Gabriela Montaño López[1*]

Tutor: PhD. Juan Jesus Justiniano

[1] Carrera de Psicología, Facultad de Humanidades, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

* Correspondencia: nataliamontanol190204@gmail.com

RESUMEN

Objetivo. El presente reporte de caso describe las dificultades de aprendizaje de una niña de 6 años y 4 meses sin escolarización inicial formal y con antecedentes de estimulación temprana insuficiente, según la información aportada por la familia. El objetivo fue identificar las áreas cognitivas, neuropsicológicas y afectivas comprometidas en la adquisición de habilidades preacadémicas y de lectoescritura. Método. Se trata de un estudio de caso cualitativo-descriptivo basado en entrevista con la familia, observación conductual y una batería psicométrica y proyectiva (Bender, TONI-2, Raven, CUMANES, HTP, Figura Humana, Persona bajo la Lluvia, Test de la Familia y Goodenough), cuyos resultados se informan de forma cualitativa porque no se dispone de puntuaciones. Resultados. Se observó un funcionamiento intelectual en el rango normal bajo, según la estimación cualitativa de la evaluadora, y dificultades en conciencia fonológica, organización temporoespacial, atención sostenida, secuenciación y grafomotricidad, además de indicadores emocionales de inseguridad y baja autoconfianza. Conclusiones. En la impresión clínica de la evaluadora, el perfil no es compatible con discapacidad intelectual. La existencia de un trastorno específico del aprendizaje no puede confirmarse ni descartarse, porque su diagnóstico requiere que las dificultades persistan pese a una enseñanza adecuada. Se plantea como hipótesis que las dificultades se relacionen principalmente con la falta de oportunidades pedagógicas y de estimulación temprana, hipótesis que podrá contrastarse con la respuesta de la niña a una intervención psicopedagógica sistemática. Se destaca la importancia de la intervención psicopedagógica temprana, el acompañamiento familiar y el fortalecimiento emocional.

Palabras clave: dificultades del aprendizaje; estimulación temprana; lectoescritura; conciencia fonológica; reporte de caso

ABSTRACT

Objective. This case report describes the learning difficulties of a 6-year-4-month-old girl with no formal early schooling and a history of insufficient early stimulation, as reported by her family. The aim was to identify the cognitive, neuropsychological, and emotional areas involved in the acquisition of pre-academic and literacy skills. Method. It is a qualitative-descriptive case study based on a family interview, behavioral observation, and a psychometric and projective battery (Bender, TONI-2, Raven, CUMANES, HTP, Draw-a-Person, Person in the Rain, Family Drawing, and Goodenough), whose results are reported qualitatively because the manuscript provides no scores. Results. Findings indicated intellectual functioning in the low-average range, according to the examiner's qualitative estimate, and difficulties in phonological awareness, temporospatial organization, sustained attention, sequencing, and graphomotor skills, as well as emotional indicators of insecurity and low self-confidence. Conclusions. In the examiner's clinical impression, the profile is not consistent with intellectual disability. A specific learning disorder can be neither confirmed nor ruled out, because its diagnosis requires difficulties to persist despite adequate instruction. It is hypothesized that the difficulties are mainly related to the lack of educational opportunities and early stimulation, a hypothesis that can be tested through the child's response to systematic psychoeducational intervention. Early psychoeducational intervention, family involvement, and emotional support are highlighted.

Keywords: learning difficulties; early stimulation; literacy; phonological awareness; case report

RECIBIDO
7 de junio de 2026

ACEPTADO
2 de octubre de 2026

PUBLICADO
30 de noviembre de 2026

CÓMO CITAR (APA 7)
Montaño López, N. G. (2026). Dificultades en habilidades preacadémicas y de lectoescritura en una niña sin escolarización inicial: reporte clínico de caso. *Ñe Renda. Territorio de la Palabra, 1*(1), 88–95.

INTRODUCCIÓN

Las dificultades del aprendizaje constituyen una de las problemáticas más frecuentes en el contexto educativo infantil, debido a que interfieren en la adquisición de habilidades académicas fundamentales como la lectura, la escritura y el cálculo. Pueden originarse por múltiples factores biológicos, cognitivos, emocionales, familiares y socioculturales, y afectan el desempeño escolar y el desarrollo integral del niño (American Psychiatric Association [APA], 2022; Sánchez y García, 2020).

Durante la primera infancia, la estimulación temprana cumple un papel fundamental en el desarrollo neurológico, cognitivo y emocional. Las experiencias educativas y afectivas tempranas favorecen la consolidación de habilidades relacionadas con el lenguaje, la atención, la memoria, la motricidad y los procesos preacadémicos necesarios para el aprendizaje escolar (Papalia y Martorell, 2021). La se-

rie de *The Lancet* sobre desarrollo infantil temprano resume evidencia neurocientífica que vincula la adversidad temprana y el cuidado cariñoso y sensible con el desarrollo y el funcionamiento cerebral a lo largo de la vida, y estima que el 43 % de los menores de cinco años de países de ingresos bajos y medios está en riesgo de no alcanzar su potencial de desarrollo (Black et al., 2017). La ausencia de estos estímulos puede asociarse a retrasos en la maduración cognitiva y a dificultades de adaptación escolar.

Asimismo, la conciencia fonológica, la organización espacial y la coordinación visomotora son habilidades relevantes para el desarrollo de la lectoescritura. Según Cuetos (2019), las alteraciones en estos procesos repercuten en la adquisición del lenguaje escrito y en el rendimiento académico durante los primeros años escolares. Un metaanálisis de 235 estudios confirmó que la conciencia fonémica es el correlato más fuerte de las diferencias individuales en la lectura de palabras, incluso tras controlar la memoria verbal a corto plazo y la conciencia de la rima (Melby-Lervåg et al., 2012). De igual manera, factores emocionales como la inseguridad, la ansiedad y la baja autoestima pueden intensificar las dificultades de aprendizaje, al afectar la motivación y la confianza del estudiante frente a las tareas académicas (Bisquerra, 2020).

En este contexto, el presente artículo tiene como objetivo describir las dificultades de aprendizaje de una niña de 6 años y 4 meses, considerando los factores cognitivos y emocionales involucrados en su desempeño escolar. El estudio parte de una evaluación psicodiagnóstica que identificó retrasos en habilidades preacadémicas y en los procesos iniciales de lectoescritura, en una niña que, según la familia, no recibió escolarización inicial formal ni una estimulación temprana suficiente.

La importancia del estudio radica en visibilizar cómo las condiciones educativas y afectivas tempranas pueden influir en el desarrollo académico infantil, y en la necesidad de una intervención psicopedagógica oportuna y de acompañamiento familiar.

PRESENTACIÓN DEL CASO

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo-descriptivo, mediante la modalidad de estudio de caso único. Dado que no se dispone de puntuaciones directas, transformadas ni percentiles de ninguno de los instrumentos, el trabajo se presenta como un reporte clínico cualitativo: los resultados psicométricos se describen en los términos cualitativos registrados por la evaluadora. El reporte sigue los elementos de la guía CARE aplicables a la evaluación psicológica.

Datos del caso

La participante es una niña de 6 años y 4 meses, estudiante de primero de primaria de una unidad educativa privada de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Fue remitida para evaluación psicológica por dificultades en el aprendizaje escolar, principalmente relacionadas con la lectoescritura y el rendimiento académico inicial.

Consideraciones éticas

Los padres otorgaron su consentimiento informado por escrito para la evaluación, incluida la autorización expresa para publicar el caso, y se obtuvo el asentimiento de la niña, adaptado a su edad. En el reporte se omitieron el nombre de la niña, el de la unidad educativa y cualquier otro dato que permita identificarla. No consta que el protocolo haya sido evaluado por un comité de ética, dado que el caso se originó como una valoración asistencial; esta ausencia se declara como limitación. Por otra parte, el autor declara no tener ningun tipo de conflicto de interes con la investigacion realizada.

Instrumentos de evaluación

Para la recolección de información se emplearon la entrevista clínica con familiares, la observación conductual y la evaluación psicométrica y proyectiva. Se administraron el Test Gestáltico Visomotor de Bender, el Test de Inteligencia No Verbal TONI-2, las Matrices Progresivas de Raven, el Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Escolar (CUMANES), las técnicas proyectivas Casa-Árbol-Persona (HTP), Dibujo de la Figura Humana (DFH), Persona bajo la Lluvia y Test de la Familia, y la escala de madurez intelectual de Goodenough. No se consignan los manuales, las versiones ni los baremos de referencia de los instrumentos.

Procedimiento

La evaluación se realizó en sesiones individuales durante mayo de 2026. Inicialmente se efectuó una entrevista con familiares para recopilar antecedentes evolutivos, escolares y emocionales. Posteriormente se administraron las pruebas de forma individual, respetando criterios de confidencialidad y bienestar de la menor. Finalmente, se integraron e interpretaron los resultados en las áreas cognitiva, neuropsicológica y afectiva, con el propósito de formular conclusiones diagnósticas y recomendaciones de intervención. No se registraron el número ni la duración de las sesiones.

EVALUACIÓN

La Tabla 1 transcribe la hoja de análisis de contenidos de las tres pruebas psicométricas principales, elaborada por la evaluadora. Contiene únicamente categorías cualitativas: no incluye puntuaciones.

Tabla 1

Análisis cualitativo de contenidos de las pruebas Bender, TONI-2 y CUMANES

Contenidos	Bender	TONI-2	CUMANES
Comportamiento durante la prueba	Concentrada, interesada, tranquila, segura	Concentrada, interesada	Ansiosa, indecisa
Aspectos intelectuales	Organización espacial inmadura; coordinación visomotora descendida	Razonamiento no verbal conservado; comprensión adecuada; CI normal bajo	Dificultades en lectoescritura; sin conciencia fonológica
Aspectos orgánicos	Sin elementos consignados	Sin elementos consignados	Sin elementos consignados
Aspectos afectivos	Inseguridad; fragilidad emocional	Interés por lograr objetivos	Ansiedad, inseguridad; temor al error
Aspectos sexuales	Sin elementos consignados	Sin elementos consignados	Sin elementos consignados
Área básica de conflictos	Sin elementos consignados	Sin elementos consignados	Sin elementos consignados
Indicadores diagnósticos	Inmadurez visomotora	Funcionamiento intelectual normal	Retraso preacadémico
Indicadores sintomatológicos	Dificultades grafomotoras; desorganización espacial	Sin elementos consignados	Dificultad de lectura y escritura

Nota. Hoja de análisis de contenidos elaborada por la evaluadora. CI = cociente intelectual (estimación cualitativa; no se informa el valor). No se presentan resultados de Raven, HTP, DFH, Persona bajo la Lluvia, Test de la Familia ni Goodenough.

En la estimación de la evaluadora, el funcionamiento intelectual se ubicó en el rango normal bajo, sin indicadores de discapacidad intelectual. En el área cognitiva se observaron dificultades en conciencia fonológica, reconocimiento letra-sonido, organización temporoespacial, atención sostenida, memoria secuencial, grafomotricidad, secuenciación y automatización inicial de la lectura y la escritura.

El Test de Bender mostró inmadurez visomotora y dificultades en la organización espacial y la coordinación gráfico-perceptiva, que afectaban el manejo del espacio gráfico y la direccionalidad en tareas de escritura. En el TONI-2 se observó un razonamiento no verbal conservado, con limitaciones en la resolución autónoma de tareas nuevas. El CUMANES mostró dificultades en procesos neuropsicológicos relacionados con la lectoescritura y las habilidades preacadémicas.

A nivel académico, la niña reconoce las vocales y presenta conteo básico conservado, pero aún no consolida el reconocimiento completo del abecedario, la lectura funcional ni una escritura adecuada para su edad cronológica.

En el área afectiva se identificaron indicadores de inseguridad emocional, necesidad de aprobación, baja autoconfianza, temor al error, dependencia afectiva, sensibilidad emocional y frustración frente a las exigencias escolares. Según la información recogida en la entrevista, la niña habría contado con escaso acompañamiento afectivo y limitada contención emocional en el entorno familiar.

DISCUSIÓN

Los hallazgos son coherentes con la literatura sobre el papel de la estimulación temprana en el desarrollo cognitivo y académico. Desde la teoría de Piaget, las experiencias tempranas permiten la construcción progresiva de las estructuras cognitivas necesarias para el aprendizaje escolar (como se citó en Papalia y Martorell, 2021), y la evidencia neurocientífica reciente vincula la adversidad temprana y el cuidado sensible con el desarrollo cerebral (Black et al., 2017).

La ausencia de escolarización inicial y de aprestamiento académico es una explicación plausible de las dificultades observadas en conciencia fonológica, coordinación visomotora y organización espacial. Es coherente con Cuetos (2019) y con el metaanálisis de Melby-Lervåg et al. (2012), que sitúa la conciencia fonémica como el predictor más sólido de las diferencias individuales en la lectura inicial. Sin embargo, el caso no permite establecer que la falta de escolarización sea la causa: no hay línea de base ni comparación, y la información sobre los antecedentes procede de la propia familia.

Las dificultades emocionales encontradas sugieren una influencia del contexto afectivo sobre el desempeño académico. Bisquerra (2020) afirma que la inseguridad emocional y la baja autoestima afectan la motivación hacia el aprendizaje y aumentan la ansiedad ante situaciones escolares. Cabe también la relación inversa: la experiencia reiterada de fracaso en tareas escolares para las que la niña no fue preparada podría generar inseguridad y temor al error. Por otra parte, la valoración del entorno familiar procede de la entrevista y de técnicas proyectivas de validez limitada, por lo que debe tomarse como una hipótesis que requiere confirmación.

Por otra parte, la evaluación no permite descartar un trastorno específico del aprendizaje, pero sí situar correctamente la pregunta diagnóstica. En este sentido, el DSM-5-TR establece que el diagnóstico de trastorno específico del aprendizaje requiere la persistencia de las dificultades pese a intervenciones adecuadas y a oportunidades educativas suficientes (APA, 2022). En una niña que no recibió enseñanza formal previa, esa condición aún no puede evaluarse. Los modelos de respuesta a la intervención (Fletcher y Vaughn, 2009) ofrecen un procedimiento

para resolverla: una intervención basada en evidencia, con evaluaciones periódicas del progreso, permite distinguir las dificultades que remiten con una enseñanza adecuada de las que persisten.

Por ello, el caso evidencia la necesidad de considerar factores pedagógicos, familiares y emocionales antes de establecer diagnósticos definitivos relacionados con trastornos del neurodesarrollo. La intervención temprana y multidisciplinaria es fundamental para prevenir la cronificación del rezago escolar y fortalecer el desarrollo integral del niño.

Implicaciones teóricas y prácticas

En el plano teórico, el caso ilustra cómo la falta de oportunidades de aprendizaje puede producir un perfil de dificultades similar al de un trastorno del aprendizaje, lo que refuerza el criterio de exclusión del DSM-5-TR y la lógica de los modelos de respuesta a la intervención. En el plano práctico, sugiere priorizar una intervención intensiva en conciencia fonológica y correspondencia letra-sonido, junto con el apoyo emocional y la participación de la familia, y monitorear periódicamente el progreso: si las dificultades persisten pese a una enseñanza adecuada, deberá reevaluarse la hipótesis de un trastorno específico del aprendizaje.

Limitaciones

Además de las propias de un caso único (no generalización, no inferencia causal), el estudio presenta las siguientes limitaciones: (a) no se informan puntuaciones de ninguno de los instrumentos, por lo que los resultados no son verificables; (b) no se declaran los manuales ni los baremos; (c) seis de los nueve instrumentos aplicados no tienen resultados informados; (d) el CUMANES es una prueba baremada para escolares mayores que la participante, por lo que sus resultados solo pueden tomarse a título orientativo; (e) la información sobre los antecedentes y el clima familiar procede de la propia familia; (f) no consta el número ni la duración de las sesiones, y (g) el protocolo no fue evaluado por un comité de ética.

CONCLUSIONES

La evaluación permitió describir dificultades de aprendizaje en la niña que, según la información disponible, se presentan en un contexto de estimulación temprana insuficiente, ausencia de escolarización inicial formal y escaso acompañamiento afectivo; la relación entre ese contexto y las dificultades es una hipótesis que el caso no permite confirmar.

A nivel cognitivo se observaron dificultades en conciencia fonológica, organización espacial, atención, secuenciación y lectoescritura inicial. La impresión clínica no es compatible con discapacidad intelectual, y la existencia de un trastorno

específico del aprendizaje solo podrá valorarse tras un período de enseñanza adecuada.

En el área emocional se identificaron inseguridad, baja autoestima y temor al error, aspectos que pueden interferir en la adaptación escolar y en la disposición frente al aprendizaje.

El estudio resalta la importancia de la intervención psicopedagógica temprana, con seguimiento periódico del progreso, el fortalecimiento emocional y la participación activa de la familia para favorecer el desarrollo académico y socioemocional infantil.

Las dificultades del aprendizaje deben abordarse desde una perspectiva integral, considerando factores cognitivos, afectivos y contextuales, con el fin de promover estrategias de intervención oportunas.

REFERENCIAS

American Psychiatric Association. (2022). *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales* (5.ª ed., texto rev.; DSM-5-TR). Editorial Médica Panamericana.

Bisquerra, R. (2020). *Educación emocional y bienestar*. Wolters Kluwer.

Black, M. M., Walker, S. P., Fernald, L. C. H., Andersen, C. T., DiGirolamo, A. M., Lu, C., McCoy, D. C., Fink, G., Shawar, Y. R., Shiffman, J., Devercelli, A. E., Wodon, Q. T., Vargas-Barón, E., y Grantham-McGregor, S. (2017). Early childhood development coming of age: Science through the life course. *The Lancet*, *389*(10064), 77–90. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31389-7

Cuetos, F. (2019). *Psicología de la lectura*. Wolters Kluwer.

Fletcher, J. M., y Vaughn, S. (2009). Response to intervention: Preventing and remediating academic difficulties. *Child Development Perspectives*, *3*(1), 30–37. https://doi.org/10.1111/j.1750-8606.2008.00072.x

Melby-Lervåg, M., Lyster, S. A. H., y Hulme, C. (2012). Phonological skills and their role in learning to read: A meta-analytic review. *Psychological Bulletin*, *138*(2), 322–352. https://doi.org/10.1037/a0026744

Papalia, D. E., y Martorell, G. (2021). *Desarrollo humano* (14.ª ed.). McGraw-Hill.

Sánchez, E., y García, J. N. (2020). *Dificultades del aprendizaje e intervención psicopedagógica*. Pirámide.

Este artículo se publica en acceso abierto bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0).

Ñe Renda
Revista Académica de Psicología
Territorio de la Palabra

ENFOQUE Y ALCANCE

Ñe Renda — Territorio de la Palabra es la revista académica de la Carrera de Psicología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Publica investigación original, revisiones, estudios de caso y ensayos que amplían la comprensión de la psicología en Bolivia y la región.

VOL. 1 · N.° 1 · 2026

Carrera de Psicología · Facultad de Humanidades
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

UAGRM

FACULTAD DE HUMANIDADES
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO

PSICOLOGÍA